รายงานฉบับสมบูรณ์

การศึกษาความเพียงพอของงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ (สำหรับสังคมผู้สูงอายุ): การดูแลระยะยาว (Long-term care: LTC) และการดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC)

คณะวิจัย

หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

ดร.รุ่งนภา คำผาง

ผศ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส

ดร.ณิชากร วรขจิต

ภก. คณิต พิศวงศ์

ภก. ศักดิโชติ เพชรสม

นายอานนท์ คุณากรจรัสพงศ์

นางสาว ธนัญพร พรมจันทร์

นางสาว นันทวัน ป้อมค่าย

นพ. ปฏิภาณ ตะเพียนทอง

นพ. ณัฏฐ์ชลิต ไกรวัฒนพงศ์

นางสาว ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

ดร. ภญ.สุธาสินี คำหลวง

26 ธันวาคม 2568

สาระสำคัญ

การดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC)

ในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ซึ่งมีรูปแบบบริการแบบ ผู้ป่วยใน (IPD-IMC) ผู้ป่วยนอก (OPD-IMC) และ การให้บริการแบบเยี่ยมบ้าน (outreach-IMC) มีข้อสรุปดังนี้

- อัตราการเข้าถึงการดูแลระยะกลางยังต่ำในบางโรค: ประมาณร้อยละ 10 ของผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง และประมาณร้อยละ 60 ของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก
- จำนวนครั้งที่ได้รับการดูแลระยะกลางเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เกณฑ์ 20 ครั้ง)
    - ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง: ได้รับบริการเฉลี่ย 11 ครั้ง/คน เบิกจ่าย 4,000–7,300 บาท/คน
    - ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: ได้รับบริการเฉลี่ย 10 ครั้ง/คน เบิกจ่าย 3,100–6,900 บาท/คน
    - ผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง: ได้รับบริการเฉลี่ย 9 ครั้ง/คน เบิกจ่าย 2,900–6,500 บาท/คน
    - ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก: ได้รับบริการเฉลี่ย 8 ครั้ง/คน เบิกจ่าย 2,400–7,400 บาท/คน
- ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย (คะแนน Barthel, ADL) เพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการได้รับการดูแลระยะกลาง การได้รับบริการน้อยครั้งสัมพันธ์กับคะแนน Barthel ที่ยังไม่ดี
- ระยะเวลารอคอยก่อนเข้าสู่บริการ IMC ส่งผลต่อผลลัพธ์การฟื้นฟู โดยผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับบริการ IMC ครั้งแรกภายใน 1 สัปดาห์หลังออกจากโรงพยาบาล มีโอกาสฟื้นตัวจนถึงเป้าหมาย (Barthel ≥18 คะแนน) สูงกว่าผู้ที่ต้องรอนาน
- การดูแลระยะกลางเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก ซึ่งหากมีการบริการร่วมกับการผ่าตัดและผ่าตัดเร็ว จะทำให้อัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น และ ค่าใช้จ่ายลดลง
- หน่วยบริการมีอัตราการเบิกจ่ายแตกต่างกัน
    - คลินิกเอกชนมีอัตราเบิกจ่ายสำหรับการดูแลระยะกลางสูงสุดในทุกโรค เฉลี่ย 6,600–7,600 บาท/คน โดยเป็นการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD-IMC) และ/หรือเยี่ยมบ้าน (outreach-IMC) เฉลี่ย 20–23 ครั้ง/คน
    - โรงพยาบาลศูนย์มีอัตราเบิกจ่ายต่ำสุด เฉลี่ย 1,900–3,200 บาท/คน โดยให้บริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD-IMC) เฉลี่ย 5–9 ครั้ง/คน
    - สถานพยาบาลภาครัฐยังมีข้อจำกัดในการเบิกจ่ายค่าบริการแบบผู้ป่วยใน (IPD-IMC) ที่ต่ำกว่าต้นทุนการรักษาจริง

การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC)

- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประมาณการณ์เป็นร้อยละ 2.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด (ประมาณ 3.4 แสนคน) โดยมีค่าใช้จ่ายจริงตามเกณฑ์การเบิกจ่ายปัจจุบัน เฉลี่ยราว 13,000-15,000 บาท/คน/ปี โดยเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง (ผ้าอ้อม) เป็นค่าใช้จ่ายหลัก กว่าร้อยละ 80
- ควรพัฒนาระบบจัดซื้อรวมระดับประเทศ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองของภาครัฐต่อบริษัทผู้ผลิต และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยรวมและเปิดให้มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ที่จะนำไปสู่การลดภาระรายจ่ายครัวเรือนและสร้างความยั่งยืนของระบบบริการผู้มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
- การจัดสรรงบประมาณปัจจุบัน ยังครอบคลุมความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไม่รอบด้าน มีการขยายชุดสิทธิประโยชน์ถึงผู้ป่วยสมองเสื่อม แต่ยังขาดมาตรฐานการดูแลและการติดตามผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว
- ควรพัฒนากระบวนการคัดกรองและประเมินสิทธิ์เข้ารับบริการ LTC ให้ครอบคลุมมิติสุขภาพร่างกาย จิตใจ และการรับรู้ โดยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดเสริม เช่น Modified Thai Frailty Index, Charlson Comorbidity Index, CGA, MOCA หรือ MMSE ร่วมกับ Barthel Index เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
- ระบบ LTC มีผลเชิงบวกต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ทั้งในกลุ่มที่ผ่าน IMC และที่เข้าสู่ระบบโดยตรง โดยผู้ผ่าน IMC มีค่าเฉลี่ย Barthel Index (BI) เพิ่มจาก 5.31-5.58 เป็น 6.23-6.85 หลังการดูแล ส่วนกลุ่ม LTC โดยตรงก็มีแนวโน้มดีขึ้นเช่นเดียวกัน
- การเสริมศักยภาพท้องถิ่นเป็นกุญแจสำคัญของระบบ LTC ที่ยั่งยืน จำเป็นต้องพัฒนาแนวทางปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่ชัดเจน พร้อมส่งเสริมการจัดตั้งรูปแบบการดูแลระยะยาวแบบสถาบันในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจากภาคเอกชน
- ควรสร้างกลไกสนับสนุนผู้ดูแล โดยจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์จำเป็น เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และชุดทำแผล ผ่านงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกองทุนหมู่บ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพและความต่อเนื่องของการดูแลผู้สูงอายุในระบบ LTC

บทสรุปผู้บริหาร

ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long-term care: LTC) มีการผลักดันและขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เป้าประสงค์หลักคือการชะลอและป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งระบบ LTC มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตามบริบทสภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรของประเทศในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในอนาคต นอกจากระบบ LTC ในปีงบประมาณ 2564 สปสช. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายการดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC) ซึ่งเป็นระบบกึ่งกลางที่เชื่อมการดูแลจากระยะเฉียบพลัน (Acute) ก่อนเข้าสู่การดูแลระยะยาว (LTC) โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ใน 4 กลุ่มโรค ซึ่งถือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเติมเต็มช่องว่างของการบริการ ลดภาระงานในระบบการดูแลระยะยาว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และทำให้เกิดระบบในการบริการและการดูแลอย่างครอบคลุมและไร้รอยต่อ (Seamless)

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดในเชิงของโครงสร้างและงบประมาณ ระบบการบริการ LTC และ IMC ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการด้านการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ยังไม่สามารถทำได้จริง ความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมของแนวทางการให้บริการในแต่ละกลุ่มโรค ส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้สูงอายุผู้รับประโยชน์และเป็นการเพิ่มภาระงานแก่เจ้าหน้าที่หน้างาน ความไม่ทั่วถึงในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์ เช่น แผ่นรองซับ ไม้ค้ำยัน รถเข็น จากข้อจำกัดด้านการเบิกจ่ายงบประมาณยังคงเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาในทุกพื้นที่ นอกจากนั้น การกระจุกตัวของบุคลากรทางแพทย์และบุคลากรเฉพาะทาง รวมถึงประเด็นการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังคงต้องเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ ทรัพยากรคนและงบประมาณ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในพัฒนาระบบ IMC และ LTC และระบบที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน (Sustainability) ความเพียงพอ (Adequacy) ความเป็นธรรม (Fairness) และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) รวมถึงการแสวงหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) อย่างสมบูรณ์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบบริการและระบบ LTC และความคาบเกี่ยวกับระบบอื่น (IMC & Palliative care) ในประเทศไทย และศึกษารูปแบบการเงินการคลังที่ใช้ในการสนับสนุนระบบ LTC และ IMC ในประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบระบบ IMC และ LTC กับกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO framework) และแนวคิดระดับสากลอื่น รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ IMC และ LTC และระบบที่เกี่ยวข้อง ของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน ครอบคลุม และสอดคล้องกับระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

จากผลการศึกษาแบ่งเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC) และ การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC)

- กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาตั้งเป้าหมายการเข้าถึงการดูแลระยะกลางอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากที่สุด
- กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรมีกลไกติดตามและสนับสนุนให้เกิดการดูแลตามจำนวนครั้งที่กำหนดทั้งจากหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีระบบกระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้าระบบการดูแลระยะกลางให้เร็วที่สุด เช่น ภายใน 1 สัปดาห์หลังกลับบ้าน และศึกษาปัจจัยที่ทำให้สถานพยาบาลไม่สามารถให้การดูแลระยะกลางได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด
- สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ควรพัฒนา Thai DRG ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยใน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือความซับซ้อนสูงที่ต้องการการดูแลระยะแรกแบบผู้ป่วยใน รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อดูแลแบบผู้ป่วยในที่เหมาะสม เช่น มีการประเมิน Barthel index ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันทั้งตอนเข้าโรงพยาบาลและก่อนกลับบ้าน
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณากลไกสนับสนุนทางการเงินสำหรับสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล) ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน

การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC)

- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรปรับวิธีการเบิกจ่ายของการดูแลระยะยาวจากเหมาจ่ายเท่ากันทุกคนเป็นแบบจ่ายตามตามระดับความต้องการการดูแล เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้งบแบบผสม (blended financing) จาก สปสช.–อปท.–กองทุนสุขภาพตำบล–ภาคเอกชน สำหรับการดูแลระยะยาว
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) ควรพัฒนาระบบจัดซื้อรวมระดับประเทศ/ระดับเขตหรือจังหวัด เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวต้องแบกรับต้นทุนเอง
- กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันการศึกษา ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้ดูแล (Caregiver) และผู้จัดการการดูแล (Care Manager) อย่างเป็นระบบ โดยปรับโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นคงในการทำงาน โดยอาจนำมาตรการจ้างงานผู้ดูแลภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้เป็นแนวทาง และมีระบบสนับสนุนสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยในรายที่จำเป็น
- เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข และ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดการคัดกรองสิทธิรับบริการ LTC ที่ครอบคลุมทั้งสมรรถภาพร่างกาย การรับรู้ และภาวะจิตสังคม โดยการใช้ Barthel Index ร่วมกับการประเมินด้านอื่น เช่น

Frailty Index, Charlson Comorbidity Index, Comprehensive Geriatric Assessment, MOCA หรือ MMSE เพื่อให้การประเมินเป็นธรรมและตอบสนองความต้องการ

- เสนอให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของนโยบายการดูแลระยะยาวแบบสถาบันและกลไกการเงิน เพื่อลดการพึ่งพาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจากภาคเอกชน
- เสนอให้พิจารณาพัฒนาแหล่งงบประมาณสำหรับการดูแลระยะยาว โดยศึกษาการปรับใช้ระบบประกันดูแลระยะยาวแบบผสมสาธารณะ-เอกชน (mixed public-private LTC insurance) เช่น CareShield Life ในสิงคโปร์ [1, 2] เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดต้นทุนส่วนบุคคล[3] พิจารณาความเป็นไปได้ของกลไกร่วมจ่าย (cost sharing) ระหว่างผู้รับบริการกับกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ/อปท. โดยปรับอัตราตามความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้รับบริการ (mean-test approach)[4, 5] เพื่อเพิ่มทรัพยากรสำหรับบริการอื่นๆ และสนับสนุนความยั่งยืนของงบประมาณ อย่างไรก็ตามยังต้องยึดหลักการที่ต้องปกป้องกลุ่มเปราะบางไม่ให้ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

สารบัญ

สาระสำคัญ ..... **ก**

บทสรุปผู้บริหาร ..... **ค**

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ..... **จ**

สารบัญ ..... **ช**

สารบัญภาพ ..... **ฌ**

สารบัญตาราง ..... **ญ**

บทที่ 1 บทนำ **1**

1. ที่มาและความสำคัญ 1

2. วัตถุประสงค์ 2

บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย **3**

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 8

2. การขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 8

3. ตารางการดำเนินงาน 10

บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม **11**

1. ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (INTERMEDIATE CARE: IMC) และระยะยาว (LONG TERM CARE: LTC) ในประเทศไทย 11

2. รูปแบบการจัดสรรงบประมาณในระบบ IMC และ LTC ของประเทศไทย 15

2.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 15

2.2 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care: IMC) 17

2.3 กองทุนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care) 19

2.4 กองทุนการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 20

3. การเปรียบเทียบการดำเนินงานของระบบ IMC และ LTC กับกรอบแนวคิดของประเทศต่างๆ 20

3.1 ขอบเขตของการให้บริการ (Care model) 20

3.2 รูปแบบการบริการและความครอบคลุมของระบบ LTC ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับแนวคิดของ WHO 28

3.3 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณบริการ LTC ในต่างประเทศ 32

บทที่ 4 ผลการศึกษา **37**

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 37

1.1 ระบบการดูแลระยะกลาง (IMC) 37

1.1.1 การเข้าถึงบริการดูแลระยะกลาง (IMC) ..... Error! Bookmark not defined.
1.1.2 ผลลัพธ์ด้านการฟื้นฟูของผู้ป่วยดูแลระยะกลาง (IMC) 39
1.1.3 สถานการณ์ทางด้านการเงิน และอัตราการเบิกจ่ายของระบบดูแลระยะกลาง (IMC) 43
1.2 ระบบบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 45
1.2.1 ผลลัพธ์ด้านการดูแลระยะยาว (LTC) 45
1.2.2 สถานการณ์ทางด้านการเงิน และอัตราการเบิกจ่ายของระบบดูแลระยะยาว (LTC) 47
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 50
ข้อมูลลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 50
1. ประสบการณ์ในการพัฒนากลไกทางการเงิน และรูปแบบการเบิกจ่ายในระยะแรกของระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว 51
2. ปัจจัยสนับสนุน 52
3. ปัญหาและอุปสรรค 54
4. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พ.ศ. 2568 57
สรุปผลช่องว่างของการให้บริการ IMC และ LTC 57
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
บทสรุป 66
เอกสารอ้างอิง 66
ภาคผนวก 71
ข้อสรุปจากการจัดอภิปรายกลุ่ม 77
1. การปรับรูปแบบการจ่าย (Payment reform) 77
2. การปรับรูปแบบบริการ (Model of care) 79

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

ภาพที่ 1 การจำลองเชิงโครงสร้าง 3 มิติ ในการขับเคลื่อนนโยบายระบบการดูแลระยะยาว 4
ภาพที่ 2 แผนภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (4) 13
ภาพที่ 3 ผังการดำเนินไปของผู้ป่วยภายหลังเข้าสู่การดูแลผู้ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 15
ภาพที่ 4 จำนวนและร้อยละผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค จากระยะฉับพลันที่ได้รับบริการ IMC (จำแนกตามรายโรค) และ/หรือ LTC ในปีงบประมาณ 2566-2568 (เดือนพฤศจิกายน) (ที่มา: ฐานข้อมูล IMC และ LTC สปสช. เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568) 38
ภาพที่ 5 ความครอบคลุมของการดูแลระยะกลาง ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2568 (พฤศจิกายน) แยกตามรายโรค 39
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนครั้งที่ได้รับการดูแลระยะกลาง และคะแนน ADL จำแนกตามรายโรค 40
ภาพที่ 7 ร้อยละผู้ป่วย IMC ที่สามารถฟื้นฟูจนมีคะแนน ADL ถึง 20 (ภายใน 6 เดือน หลังพ้นระยะฉับพลัน) 41
ภาพที่ 8 ร้อยละผู้ป่วย IMC ที่สามารถฟื้นฟูจนมีคะแนน ADL ถึง 20 (ภายใน 6 เดือน หลังพ้นระยะฉับพลัน) จำแนกตามเขตสุขภาพ 41
ภาพที่ 9 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเข้ารับบริการดูแลระยะกลาง จำแนกตามประเภทสถานพยาบาล จำแนกตามรายโรค 42
ภาพที่ 10 ร้อยละผู้ป่วย IMC ที่สามารถฟื้นฟูจนมีคะแนน ADL ถึง 20 (ภายใน 6 เดือน หลังพ้นระยะฉับพลัน) จำแนกตามประเภทสถานพยาบาล 42
ภาพที่ 11 อัตราการเบิกจ่ายจริงเฉลี่ยต่อรายที่เข้ารับบริการ IMC ปี 2567 จำแนกตามรายโรค 43
ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการเบิกจ่ายจริงเฉลี่ย, จำนวนครั้งที่ได้รับการดูแลระยะกลาง และร้อยละการฟื้นฟูจนมี ADL ถึง 20 คะแนน จำแนกตามรายโรค 44
ภาพที่ 13 อัตราการเบิกจ่ายจริงเฉลี่ยและร้อยละของผู้ป่วย IMC ที่สามารถฟื้นฟูจนมีคะแนน ADL ถึง 20 ภายใน 6 เดือนหลังพ้นระยะฉับพลัน จำแนกตามรายโรคและประเภทสถานพยาบาล 45
ภาพที่ 14 แสดงจำนวนผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ LTC ปีงบประมาณ 2565-2567 46
ภาพที่ 15 แสดงคะแนน ADL เฉลี่ยของผู้ที่เข้าสู่ระบบ LTC ที่ผ่าน IMC (ซ้าย) และไม่ผ่าน IMC (ขวา) 47
ภาพที่ 16 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำแนกตามผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ในปี 2567[6] 47
ภาพที่ 17 การจัดสรรงบประมาณกองทุน LTC สำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง (ปี 2567) 48
ภาพที่ 18 ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายต่อปีและความครอบคลุมด้านการบริการ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาว (LTC) 50

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 1 ประเด็นศึกษาและวิธีการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย 4
ตารางที่ 2 บทบาทหน้าที่ และรายละเอียดการสัมภาษณ์เชิงลึกในแต่ละพื้นที่ 6
ตารางที่ 3 รายละเอียดและแผนการดำเนินของโครงการ 10
ตารางที่ 4 ความครอบคลุมของบริการระบบ LTC เปรียบเทียบกับแนวคิดของ WHO 29
ตารางที่ 5 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณบริการ LTC ในประเทศต่างๆ 32
ตารางที่ 6 แสดงผู้ให้ข้อมูล (key informant) 50
ตารางที่ 7 การให้รหัสสำหรับผู้ให้ข้อมูล 51

บทที่ 1 บทนำ

1. ที่มาและความสำคัญ

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในอนาคตอันใกล้[6] การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการด้านการดูแลระยะยาว (Long-term care: LTC) ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ[7] เนื่องจากผู้สูงอายุจำนวนมากต้องเผชิญกับภาวะพึ่งพิง อันเนื่องมาจากความเสื่อมถอยของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทำให้ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสุขภาพและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) ซึ่งได้ริเริ่มโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่สูงขึ้น[8] โดยมุ่งให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้โดยไม่ล้มละลายทางการเงิน แต่ระบบ LTC ในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ความครอบคลุมของบริการที่ยังไม่ทั่วถึงในระดับประเทศ ความไม่ชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุและครอบครัว โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ความไม่เพียงพอและไม่ยั่งยืนของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการขาดกลไกทางการเงินการคลังที่ชัดเจนและมั่นคงในระยะยาว[8] เพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต นอกจากนี้ ระบบ LTC ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมประเด็นสุขภาพสำคัญบางประเด็นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ เช่น ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ (frailty), กลุ่มอาการสูงอายุ (geriatric syndrome) และปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องในระยะยาว[8] การขาดการบูรณาการของบริการเหล่านี้กับระบบ LTC นอกจากจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นการเพิ่มภาระต่อครอบครัวและระบบบริการสุขภาพในภาพรวม ด้วยเหตุนี้ การพัฒนารูปแบบการเงินการคลังและการจัดบริการ LTC ที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดบริการและกลไกทางการเงินของ LTC ตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO-framework) และนำมาเปรียบเทียบกับบริบทเฉพาะของประเทศไทย จะช่วยให้สามารถระบุช่องว่างทางนโยบาย จุดแข็ง และจุดอ่อนของระบบ LTC ในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ LTC ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และสามารถบูรณาการเข้ากับระบบ UHC ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวที่มีคุณภาพและอย่างยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ลดภาระต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสุขภาพและสวัสดิการของประเทศในระยะยาว

2. วัตถุประสงค์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริการ และสถานการณ์การเงินการคลังของระบบการดูแลระยะกลาง (IMC) และระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้กรอบวิเคราะห์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) มุ่งเน้นประเมินงบประมาณและกลไกการจัดสรรค่าใช้จ่าย

บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย

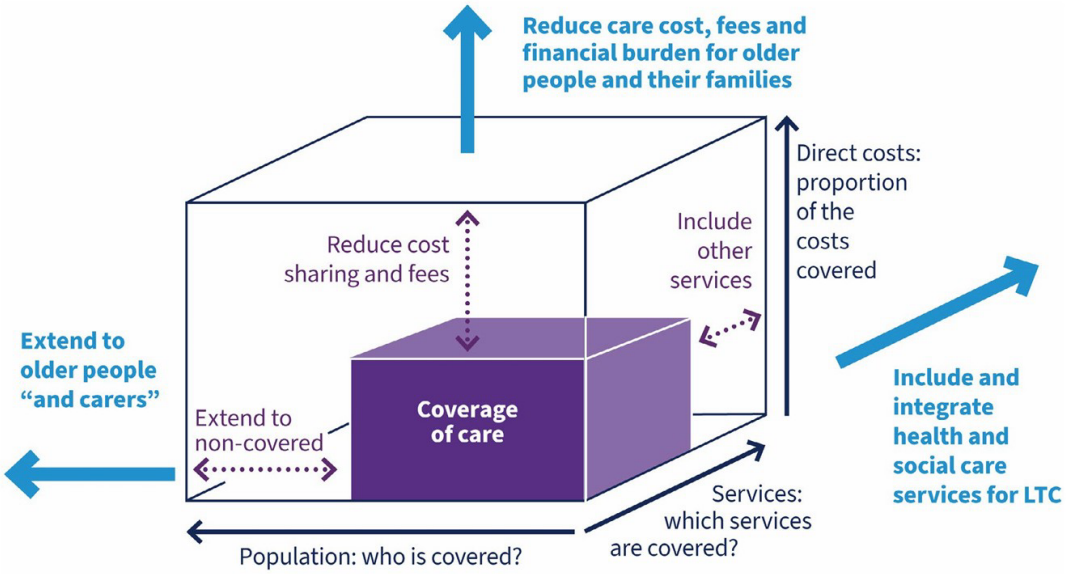
การศึกษานี้เป็นการวิจัยภายใต้กรอบแนวคิดของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งได้อธิบายเป็นภาพจำลองเชิงโครงสร้าง 3 มิติ ในการขับเคลื่อนนโยบายระบบการดูแลระยะยาว (LTC) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดความครอบคลุมของบริการ LTC ในบริบทของระบบสุขภาพแห่งชาติ (รูปที่ 1)[9] โดยกรอบแนวคิดนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงลูกบาศก์ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยน (trade-offs) ระหว่างตัวแปรด้านนโยบายที่สำคัญ 3 มิติ ได้แก่

1. มิติด้านประชากร (Population) กล่าวถึงการขยายการเข้าถึงบริการ LTC ไปยังกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ดูแล (carers)

2. มิติด้านบริการ (Services) กล่าวถึงการขยายขอบเขตของบริการที่ครอบคลุมในระบบ LTC ให้หลากหลายและบูรณาการมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการบริการสุขภาพ บริการสังคม หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่ซับซ้อนของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มิติด้านต้นทุน (Costs) กล่าวถึงระดับความคุ้มครองด้านการเงิน ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่รัฐหรือระบบสุขภาพสามารถรองรับได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจากการดูแลระยะยาวที่ตกอยู่กับประชาชนและครอบครัว การลดค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจ่ายเอง (out-of-pocket payments) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ

ทั้งสามมิตินี้มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ การขยายความครอบคลุมของ ประชากรจำเป็นต้องมาพร้อมกับการพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองได้อย่างเพียงพอ ขณะเดียวกัน การเพิ่มบริการหรือการขยายกลุ่มเป้าหมายจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนและภาระทางการเงินของระบบสุขภาพ หากเน้นขยายบริการโดยขาดกลไกทางการเงินที่มั่นคง อาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนและกระทบต่อความยั่งยืนของระบบได้ ในขณะที่หากควบคุมต้นทุนมากเกินไปโดยไม่ขยายการคุ้มครองด้านประชากรหรือบริการ ก็อาจนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและคุณภาพของการดูแล ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสามมิตินี้จึงสะท้อนถึงกระบวนการ จัดลำดับความสำคัญ (prioritization) และสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน (trade-offs) ซึ่งผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการขยายความครอบคลุมประชากร การตอบสนองต่อความต้องการบริการ และการรักษาความมั่นคงทางการเงินของระบบสุขภาพ การศึกษานี้จึงจะประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มประชากรที่ควรได้รับสิทธิประโยชน์ LTC (2) กลไกและระดับความครอบคลุมด้านการเงินการคลัง และ (3) สิทธิประโยชน์ด้านบริการที่เหมาะสม ภายใต้บริบทของระบบสุขภาพแห่งชาติ



ภาพที่ 1 การจำลองเชิงโครงสร้าง 3 มิติ ในการขับเคลื่อนนโยบายระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care: LTC) เพื่อมุ่งสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC)

ตารางที่ 1 ประเด็นศึกษาและวิธีการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย

ประเด็น	ประเด็นศึกษา	วิธีการศึกษา
ประชากร (Population)	- ความครอบคลุมของกลุ่มประชากรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ IMC และ LTC ในประเทศไทย และ ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีการสนับสนุน IMC และ LTC ที่ชัดเจนและครอบคลุม และความคาบเกี่ยวของ LTC กับ IMC	- ทบทวนวรรณกรรมตามกรอบการประเมิน WHO Framework และตัวอย่างประเทศที่มี LTC อย่างครอบคลุม รวมไปถึงข้อมูลด้านหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของผู้ป่วยที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ LTC & IMC ในประเทศไทย - วิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ใช้บริการ IMC ในประเทศไทย ความแตกต่างด้านการเข้าถึงบริการเปรียบเทียบระหว่างเขตสุขภาพ หรือ SES ของผู้รับบริการจากฐานข้อมูล Disability portal สปสช. - ทบทวนวรรณกรรมเปรียบเทียบผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ LTC, IMC ของประเทศไทยและต่างประเทศ - ค้นหาผู้ที่อาจเข้าไม่ถึงเข้าบริการ IMC และ LTC ในประเทศไทยจากเอกสารวิชาการและ ฐานข้อมูล Disability portal และ LTC ของ สปสช.
	- การขยาย LTC ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุและผู้ดูแล	- ศึกษาความเป็นไปได้หรือกลไกที่จะสนับสนุนให้เกิดการขยายสิทธิประโยชน์ IMC และ LTC ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้อง ด้วยการทบทวนเอกสารและจัดกระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประเด็น	ประเด็นศึกษา	วิธีการศึกษา
การบริการ (Service)	- รูปแบบของการบริการ IMC และ LTC ที่มีอยู่ในประเทศไทย (formal care and informal care) - การเปรียบเทียบรูปแบบบริการ IMC และ LTC ในต่างประเทศ	- ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบบริการในปัจจุบัน (หลักฐานวิชาการของประเทศไทย) - ทบทวนวรรณกรรมเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบบริการในประเทศไทยและต้นแบบในต่างประเทศเพื่อค้นหาช่องว่างของรูปแบบบริการในประเทศไทย
	- ความครอบคลุมของบริการด้านสุขภาพและบริการด้านสังคม	- วิเคราะห์ความครอบคลุมของการให้บริการ setting ของบริการ กระบวนการทำงานระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น และ ผู้ให้บริการ (LTC providers)
งบประมาณ (Financing model)	- แหล่งเงินทุนและการจัดสรรเงินของระบบ LTC, IMC และ palliative care ในประเทศไทย	- ทบทวนเอกสารงบประมาณของภาครัฐ และ วิเคราะห์ที่มาของแหล่งงบประมาณ บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณ ของระบบ LTC, IMC และ palliative care ในปัจจุบัน ผ่านฐานข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสุขภาพ เช่น ระบบ Disability (IMC), ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และระบบ MIS (ICD10: Z51.5 palliative care)
	- ปัญหาความซับซ้อนในการเบิกจ่ายงบประมาณ	- ทบทวนเอกสารงบประมาณของภาครัฐ และ ศึกษากลไกการจัดสรรงบประมาณสำหรับ ระบบ LTC, IMC และ palliative care จากเอกสารรายงานจากต่างประเทศร่วมกับการรวบรวมข้อมูลจากการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	รูปแบบการจ่าย IMC และ LTC ในต่างประเทศ	- ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษารูปแบบการจ่ายสำหรับ IMC และ LTC จากบทเรียนของต่างประเทศ - จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในบริบทประเทศไทย
(Financial burden)	- ขอบเขตค่าใช้จ่ายของระบบ LTC, IMC และ palliative care ในประเทศไทย ทั้งในด้านตัวผู้ป่วยและครอบครัว/ผู้ดูแลผู้ป่วย	- ทบทวนข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านการเงินที่ครอบคลุมในปัจจุบัน ด้วยกระบวนการทบทวนเอกสารนโยบาย/สิทธิประโยชน์ และ การรวบรวมข้อมูลจากการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
	- กลไก / แนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและผู้ให้การดูแล (Carers)	- ศึกษาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ต้องจ่ายเอง (Out-of-pocket expenditure) และ ตัวอย่างมาตรการที่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อ ระบบ LTC, IMC และ palliative care ด้วยวิธีการทบทวนเอกสารรายงานนโยบายต่างประเทศ

คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) การทบทวนเอกสารแนวทางการดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC) และระยะยาว (Long-term care: LTC) ของหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก สหภาพยุโรป เป็นต้น บทความวิชาการ รวมทั้งเอกสารและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลระยะกลาง (IMC) และระยะยาว (LTC) ในประเทศไทย ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ป่วยจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านการจัดสรรงบประมาณ และผู้มีประสบการณ์ดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการงบประมาณ ในชุมชนตัวอย่าง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC รางวัลชนะเลิศในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (สัมภาษณ์ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2568)

2. เทศบาลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร JICA ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2550-2560 (สัมภาษณ์ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2568)

3. เทศบาลตำบลนายม และ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (สัมภาษณ์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568)

4. กลุ่มงานกายภาพบำบัด (งาน IMC) โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (สัมภาษณ์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2568)

5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน โรงพยาบาลพิมลราชและเทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (สัมภาษณ์ ณ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2568)

ตารางที่ 2 บทบาทหน้าที่ และรายละเอียดการสัมภาษณ์เชิงลึกในแต่ละพื้นที่

	ประเภทบุคคล	บทบาท	ประเด็นข้อคำถาม
1.	ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) - นายกเทศมนตรี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)	เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารงบประมาณของพื้นที่ โดยเฉพาะงบประมาณจาก สปสช. (กองทุนสุขภาพตำบล)	● กระบวนการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณเป็นอย่างไร ● ปัจจุบันการบริหารงบประมาณ เพื่อดูแลผู้สูงอายุระยะยาวมีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ อย่างไร ● การทำงานร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพเป็นอย่างไร ● อุปสรรคในการเบิกจ่าย หรือการใช้เงินมีอะไรบ้าง ● ข้อเสนออื่นๆ ด้านความยั่งยืนของงบประมาณการดูแลผู้สูงอายุ
2.	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายพัสดุของ อบต. หรือเทศบาล	เป็นผู้ดูแลขั้นตอนทางเอกสารการเบิกจ่ายและการตรวจสอบงบประมาณ	● ข้อจำกัดในการเบิกจ่ายมีอะไรบ้าง ● มีการจ่ายค่าตอบแทน caregiver อย่างไร

	ประเภทบุคคล	บทบาท	ประเด็นข้อคำถาม
			• มีการจัดการบัญชี LTC อย่างไร (บัญชี LTC ถูกแยกหรือรวมกับบัญชีอื่นๆ) • มีการตรวจสอบหรือติดตามผลการใช้งบหรือไม่ อย่างไร
3.	ผู้อำนวยการ รพ.สต. หรือ ผู้จัดการ LTC (Care manager)	เป็นผู้รับผิดชอบบริหารแผนการดูแลและร่วมจัดทำแผนใช้งบกับ อปท.	• งบที่ได้รับเพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ • มีขั้นตอนการเสนอแผนใช้งบ หรือของบจาก อปท. อย่างไร • มีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
4.	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) หรือ อสม. ที่ปฏิบัติงานจริง	เป็นผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนจากงบ LTC โดยตรง	• ได้รับค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงอย่างไร เพียงพอหรือไม่ • มีสิ่งใดที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนและควรมีการสนับสนุนเพิ่มเติม • งบประมาณที่จัดสรรลงมาถูกใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร เพียงพอหรือไม่

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ภายหลังจากกระบวนการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตาม Six-step framework ของ Braun and Clark's[10] สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมกับการสกัดเนื้อหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม (content analysis) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ประกาศ กฎหมาย ระเบียบของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ หลักฐานทางวิชาการเพื่อใช้ตรวจสอบลักษณะสามเส้า (Methodological triangulation) เนื่องจากวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีการที่มีความยืดหยุ่น คณะผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อทำให้การสัมภาษณ์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น[10, 11]

สำหรับกระบวนการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ที่มีการถอดแบบคำต่อคำ (Verbatim) ใช้วิธีการซึ่งประกอบไปด้วย

1. การทำความคุ้นชินกับข้อมูล (Familiarizing with data)
2. การสร้างรหัส (Generating initial codes)
3. การสำรวจสาระสำคัญและกำหนดแนวทางหลักจากเนื้อหา (Searching for themes)
4. การทบทวนแนวทางหลัก (Reviewing themes)
5. การระบุชื่อแนวทางหลัก (Defining and naming themes)
6. การวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเพื่อจัดทำรายงาน (Final analysis and producing report)

2. การขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงการวิจัยนี้ได้ขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Institutional Review Board: SIRB) ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาความเพียงพอของงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ (สำหรับสังคมผู้สูงอายุ): การดูแลระยะยาว (Long-term care: LTC) และการดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC)” โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- เลขอนุมัติโครงการ COA: 549/2025
- ชื่อหัวหน้าโครงการ: ดร.ณิชากร วรขจิต
- ระยะเวลาโครงการ: 7 เดือน
- วันที่อนุมัติ: 29 มิถุนายน 2568
- วันหมดอายุของการอนุมัติ: 28 มิถุนายน 2569

หนังสืออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2 WANGLANG Rd. BANGKOKNOI
BANGKOK 10700

Tel. +66 2419 2667-72
Fax. +66 2411 0162

Siriraj Institutional Review Board

Certificate of Approval

COA no. Si 549/2025

Protocol Title (English)	:	Ensuring adequate financing for evolving health needs (for aging societies): Long-term care (LTC) & Intermediate care (IMC)
Protocol Title (Thai)	:	การศึกษาความเพียงพอของงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ (สำหรับสังคมผู้สูงอายุ): การดูแลระยะยาว (Long-term care: LTC) และการดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC)
SIRB Protocol No.	:	541/2568(IRB4)
Principal Investigator/Affiliation	:	Nichakorn Worakajit, Ph.D. / Siriraj Health Policy Unit
Research site	:	Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Duration of research	:	7 months
Approval date	:	June 29, 2025
Expired date	:	June 28, 2026

This is to certify that Siriraj Institutional Review Board is in full compliance with international guidelines for human research protection such as the Declaration of Helsinki, the Belmont Report, CIOMS Guidelines and the International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP)

(Emeritus Prof. Naraporn Prayoonwiwat, M.D.)
Chairperson

- 4 JUL 2025
date

(Prof. Apichat Asavamongkolkul, M.D.)
Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital

- 7 JUL 2025
date

Approval includes :

1. SIRB submission form, Version 2 dated 25 Jun 2025
2. Participant information sheet
   - Executive, Version 2 dated 25 Jun 2025
   - Elderly caregiver, Version 2 dated 25 Jun 2025
3. Informed consent form, Version 1 dated 5 Jun 2025
4. Interview guide
   - Executive, Version 1.0 dated 5 Jun 2025

หน่วยพิมพ์โรงพยาบาลศิริราช 2341/3,000 แผ่น/พ.ค.57/92667/Mat.10023252/3060/Mo.

3. ตารางการดำเนินงาน

ตารางที่ 3 รายละเอียดและแผนการดำเนินของโครงการ

	รายละเอียด	มิย.		กค.		สค.		กย.		ตค.		พย.		ธค.	
1	ขออนุมัติจริยธรรมในคน														
2	ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาต้นแบบการให้บริการในต่างประเทศ และข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก และทบทวนตัวแปรจากฐานข้อมูลในประเทศไทย														
3	ทบทวนวรรณกรรมรูปแบบบริการ ระบบการเงินการคลังและสิทธิประโยชน์ในประเทศไทย														
4	ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการระบบ LTC ในพื้นที่ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 4.1 เทศบาลตำบลเขารูปช้าง 4.2 เทศบาลตำบลบางสีทอง 4.3 เทศบาลเมืองพิมลราช 4.4 อบต.ห้วยไร่/ เทศบาลตำบลนายม จ.อำนาจเจริญ														
5	ขอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ														
6	สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำผลการศึกษาเบื้องต้น														
8	จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) และบทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)														

บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม

1. ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care: IMC) และระยะยาว (Long term care: LTC) ในประเทศไทย

การจัดแบ่งระบบการดูแลผู้ป่วย IMC และ LTC สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของการดูแล และกลุ่มประชากรผู้ได้รับประโยชน์ โดยลักษณะของการบริการระหว่าง IMC และ LTC นั้นมีความแตกต่างกัน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้นเป็นกลุ่มที่มีระดับของความสามารถในการดูแลตนเองลดลง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดจากสภาวะความเจ็บป่วย ในขณะที่กลุ่ม IMC นั้นเป็นกลุ่มผู้ที่เกิดการเจ็บป่วยหรือกลุ่มที่ออกจากการดูแลระยะวิกฤตซึ่งยังไม่สามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ และมักเป็นผลจากภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท

ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

ผู้ป่วยระยะกลางในประเทศไทยนั้นได้มีการกำหนดนิยามว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ผ่านพ้นระยะวิกฤตและมีอาการคงที่ แต่ยังมีความผิดปกติของร่างกายในบางระบบอวัยวะซึ่งส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวัน[12] จุดประสงค์ของการดูแลคือฟื้นฟูสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยให้ดีขึ้นในระยะต่อเนื่องระหว่างระยะวิกฤตให้พร้อมสำหรับการดูแลต่อที่บ้าน และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้ง[13] เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วยเข้ารับบริการนั้น ปัจจุบันได้มีการกำหนดว่า ผู้ป่วยต้องเป็นผู้ที่มีค่าดัชนีบาร์เธลเอดีแอล น้อยกว่า 15 คะแนน หรือตั้งแต่ 15 คะแนนแต่มีความบกพร่องหลายระบบร่วมด้วย (Multiple comorbidities) ซึ่งเป็นผู้ทีมีประวัติทางสุขภาพดังนี้[14]

1) ภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดที่ไม่รุนแรง (Fragility fracture hip)
2) การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง (Spinal cord injury หรือ SCI)
3) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) (รหัสโรค ICD10 I60-I64)
4) สมองบาดเจ็บ (Traumatic brain injury) (รหัสโรค ICD10 S061-S069)

และได้มีข้อเสนอสำหรับกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุของความบกพร่องที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มโรคที่ได้เสนอเพิ่มเติมนั้นยังไม่จัดเป็นกลุ่มโรคที่เป็นเกณฑ์สำหรับการดูแลระยะกลาง (13)

1) Brain dysfunction (Non-traumatic)
2) Neurological condition (Motor neuron disease, GBS, Multiple sclerosis)
3) Amputation of limb
4) Orthopaedic conditions
5) Hip and knee replacement
6) Cardiac and Pulmonary disorders

7) Major multiple trauma
8) Major multiple trauma without brian trauma
9) Burn

ความบกพร่องหลายระบบร่วมกัน (Multiple comorbidities) นั้นต้องมีความบกพร่องอย่างน้อย 2 ระบบขึ้นไป ได้แก่

1) ปัญหาการกลืน (Swallowing problem)
2) ปัญหาในการสื่อสาร (Communication problem)
3) ปัญหาการเคลื่อนไหว (Mobility problem)
4) ปัญหาปริชานและการรับรู้บกพร่อง (Cognitive and perception problem)
5) ปัญหาทางลำไส้และกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Bowel and bladder problem)

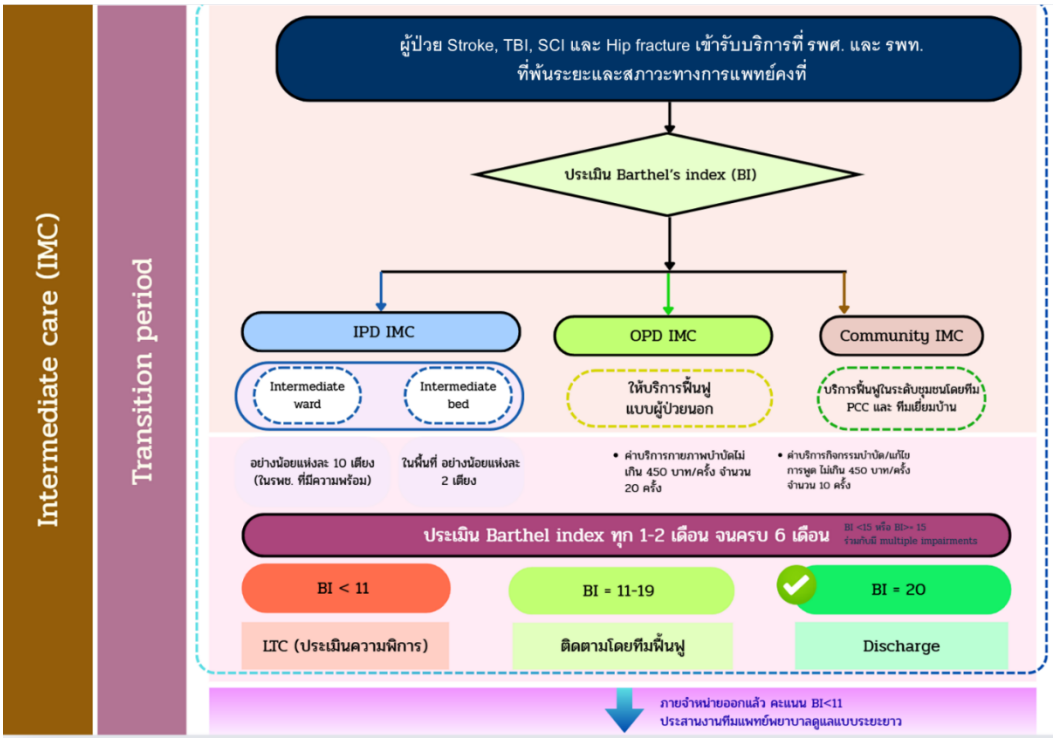
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับลักษณะบริการที่ผู้ป่วย IMC จะได้รับนั้นจะเป็นไปตามที่ระบุในประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์[14] และประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง[15] ครอบคลุมถึงการฝึกการเคลื่อนไหว และทำกิจวัตรประจำวัน กายภาพบำบัด การแก้ไขการพูด การทำกายอุปกรณ์เสริม/เทียม การปรับสภาพแวดล้อม เป็นต้น บริการที่จะได้รับนั้นผู้ป่วยจะถูกดูแลแบบบูรณาการโดยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ อายุรแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมด้านการฟื้นฟูสภาพ นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ นักจิตวิทยา และเภสัชกร[12]

ประเภทของการให้บริการ IMC สามารถจำแนกได้ตามความถี่ของการบริการ ดังนี้

1) Intermediate ward ให้บริการฟื้นฟูอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมงและอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ อย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2) Intermediate bed ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูเฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง (ขั้นต่ำ) อย่างน้อยสัปดาห์และ 3 วัน โดยจะให้บริการที่โรงพยาบาลชุมชน (พื้นที่ระดับอำเภอ)

หรือ แบ่งตามประเภทของบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข[15]

1) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
2) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลางแบบผู้ป่วยนอก
3) บริการฝังเข็ม หรือ บริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระยะกลาง



ภาพที่ 2 แผนภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (4)

จากภาพที่ 2 ได้แสดงถึงแสดงถึงผังการดำเนินไปของผู้ป่วยภายหลังเข้าสู่ระบบการดูแลระยะกลาง (Patient journey) โดยเริ่มต้นจากกลุ่มที่มีประวัติทางการแพทย์ดังที่ได้อธิบายข้างต้น จากนั้นกลุ่มดังกล่าวจะได้รับการประเมินเกณฑ์บาร์เธลเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทบริการ จากนั้นผู้ป่วยจะได้รับบริการตามสภาวะโรคของตนเองต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือนและได้รับการประเมินเมื่อครบกำหนด หากผู้ป่วยมีการฟื้นฟูจนมีค่าดัชนีบาร์เธลเกิน 20 คะแนนผู้ป่วยจะถูกจำหน่ายออกจากระบบ IMC (Discharge) และจะไม่ได้รับการติดตามสุขภาพต่อ หากผู้ป่วยมีค่าดัชนีบาร์เธลต่ำกว่า 20 คะแนนจะได้รับการติดตามโดยทีมฟื้นฟูต่อเนื่อง หรือ กรณีที่ดัชนีบาร์เธลต่ำกว่า 11 ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อเข้าระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงต่อไป[12]

ระบบการดูแลผู้ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

การกำหนดนิยามผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้ใช้ดัชนีบาร์เธลในการวัดความสามารถในการพึ่งพาตนเองในชีวิตประจำวัน โดยนิยามหลักตามที่ได้ระบุในคู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข[16] และ เอกสารแนบท้ายประคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น[17] ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงว่า ผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นๆ ที่มี คะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความต้องการบริการด้านสาธารณสุข[17] ได้แก่

1) กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกิน หรือ การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง

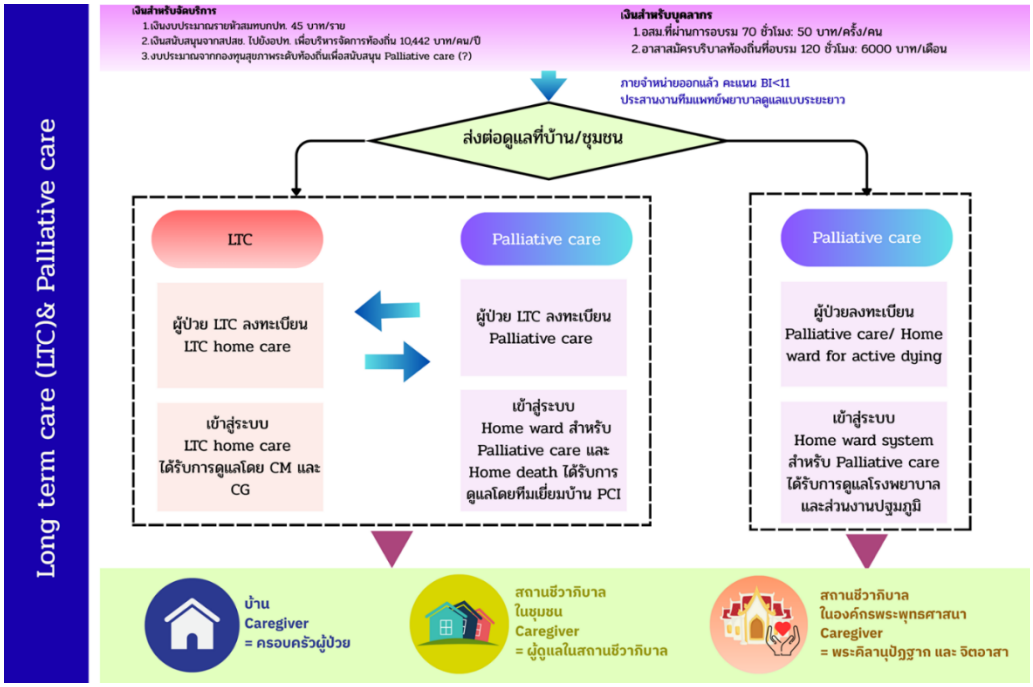
2) กลุ่มที่ 2 มีนิยามตามกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง
3) กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง
4) กลุ่มที่ 4 เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายชีวิต

ประโยชน์ของการใช้นิยามที่อ้างอิงถึงความรุนแรงของภาวะพึ่งพิงที่มีต่อการดำรงชีวิตประจำวันนั้น สามารถใช้ในการจัดจำแนกกลุ่มเพื่อให้ได้รับความถี่การในการดูแลได้อย่างเหมาะสม ร่วมถึงการออกแบบชุดสิทธิประโยชน์บริการ Long Term Care ซึ่งสามารถจัดแบ่งประเภทของชุดสิทธิประโยชน์บริการ Long Term Care ตามลักษณะของบริการที่ได้รับ[17] ได้แก่

1. บริการด้านการแพทย์ (Health service) เช่น บริการการตรวจคัดกรอง ประเมินความต้องการ ดูแล บริการเยี่ยมบ้าน บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, บริการ กายภาพบำบัด, บริการกิจกรรมบำบัด และอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการแพทย์ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ สปสช. กำหนด

2. บริการด้านสังคม (Social service) เช่น บริการช่วยเหลืองานบ้าน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน, บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือทางสังคม, กิจกรรมนอกบ้าน และอื่น ๆ

จากภาพที่ 3 ได้แสดงถึงผังการดำเนินไปของผู้ป่วยภายหลังเข้าสู่ระบบการดูแลระยะยาว (Patient journey) โดยในภาพได้แสดงถึงกรณีที่ผู้ป่วยได้จัดเข้าสู่ระบบการดูแลระยะยาวในสถานพยาบาล (Institutional Long term care) และจะได้รับการส่งต่อ (Discharge) จากโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเข้าสู่การดูแลในชุมชน ซึ่งอาจจะเป็นที่พักอาศัยของผู้ป่วยหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Community Long term care) ผู้สูงอายุจะต้องได้รับการลงทะเบียนในระบบ LTC home care และได้รับการติดตามดูแลโดย Care giver ซึ่งอาศัยแผนการดูแล (Care plan) เป็นแผนปฏิบัติการ ภายใต้การกำกับดูแลโดย Care manager[16]



ภาพที่ 3 ผังการดำเนินไปของผู้ป่วยภายหลังเข้าสู่การดูแลผู้ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการดูแลระยะประคับประคอง

2. รูปแบบการจัดสรรงบประมาณในระบบ IMC และ LTC ของประเทศไทย

"หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (Universal Health Coverage - UHC) เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีกรอบเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2573[18] โดยประเทศไทยมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมและมีกฎหมายรองรับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545[19] และได้กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุน ประสาน และกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้ชื่อ "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น" หรือ "กองทุนตำบล" จากประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2549 โดยวัตถุประสงค์ของกองทุนตามประกาศฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2561 สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท[20] ได้แก่

1) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ
   วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ
3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นหรือหน่วยงานที่ดูแลดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นหรือหน่วยงานที่ดูแลดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด
4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (1) เป็นเงินที่จัดสรรตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการในชุมชน ปัจจุบันได้รับจำนวน 45 บาทต่อคน ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปีงบประมาณนั้น ๆ (2) เป็นเงินสมทบจาก อปท. และ (3) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฯ เช่น ดอกเบี้ย เงินบริจาค เป็นต้น นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติตามข้อ (1) แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมและสำนักงานเห็นชอบจะได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดย อปท. ไม่ต้องสมทบเงินเข้ามา ค่าบริการ LTC จะสามารถจ่ายได้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเท่านั้น

ข้อกำหนดสัดส่วนการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ คิดคำนวณอัตราการสมทบเงินใช้เกณฑ์รายได้ของ อปท. ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนของปีที่ผ่านมา มาเป็นฐานในการคิดของแต่ละ อปท. ดังนี้[20]

1) องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ต่ำกว่า 6 ล้านบาท
2) องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท
3) องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตำบล สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่า 20 ล้านบาท และ
4) เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

2.2 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care: IMC)

ระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง “Intermediate care” (IMC) เป็นระบบกึ่งกลางที่เชื่อมการดูแลจากระยะเฉียบพลัน (Acute) ก่อนเข้าสู่การดูแลระยะยาว (Long term care; LTC) โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ โดยค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ได้มาจากกองทุนความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[21] ค่าบริการฟื้นฟูฯ ต่อผู้มีสิทธิหนึ่งท่านเท่ากับ 17.23 บาท แบ่งออกเป็น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ไม่เกิน 8 บาทต่อผู้มีสิทธิ และจ่ายตามผลงานบริการ 9.23 บาทต่อผู้มีสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<u>กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด</u>

- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในชุมชนที่จำเป็น 2 รายการ ได้แก่ กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด
- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น เพื่อการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility : O&M)
- อุปกรณ์เครื่องช่วย สำหรับคนพิการตามรายการที่ สปสช. กำหนด 9 รายการ ได้แก่ ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม ไม้เท้าอลูมิเนียม แบบสามขา ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ด้วยสายยืดหยุ่นชนิดมี

ด้าม ไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้ เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ รถสามล้อโยกมาตรฐานสำหรับคนพิการ และ แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม

<u>จ่ายตามผลงานบริการ</u>

- ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ (ไม่ซ้ำกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด)
- ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) กรณีสมองบาดเจ็บ (Traumatic brain injury) หรือการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal Cord injury) เฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการเห็น การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ เคลื่อนไหว และบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ จ่ายตามผลงานบริการตามรายการบริการ (Fee Schedule) ให้กับหน่วยบริการ
- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่นๆ จ่ายตามระบบ Point system with celling ของรายการบริการ (Fee Schedule) ให้กับหน่วยบริการ
- กรณีพื้นที่ที่ไม่มีกองทุนฟื้นฟูฯระดับจังหวัด ให้เพิ่มครอบคลุมบริการ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการตามรายการที่ สปสช. กำหนดให้กองทุนฟื้นฟูฯระดับจังหวัดดำเนินการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ เห็น, การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว, และค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่ให้บริการในชุมชน

เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าบริการต้องเป็นผู้ป่วยระยะกลางที่พ้นระยะวิกฤตที่มีสภาวะทางการแพทย์คงที่ และ เป็นผู้ป่วยที่มีค่า Barthel Score หรือ ADL น้อยกว่า 15 หรือ ค่า Barthel Score หรือ ADL เท่ากับหรือมากกว่า 15 แต่มี Multiple impairment ร่วมด้วย โดยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 3 รายการ ได้แก่

1. บริการกายภาพบำบัดรวมไม่เกิน 20 ครั้ง กรณีหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะ ด้านกายภาพบำบัด เมื่อให้บริการครบจำนวนครั้งที่กำหนด ให้ส่งต่อตามระบบปกติ
2. บริการกิจกรรมบำบัด
3. แก้ไขการพูด

ทั้งนี้ รายการที่ (2) และ (3) รวมไม่เกิน 10 ครั้ง โดย 3 กิจกรรมเป็นการจัดบริการแบบผู้ป่วยนอกหรือในชุมชน ภายในระยะเวลา 6 เดือน จากวันจำหน่ายผู้ป่วยในและครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด อัตราจ่ายให้บริการในหน่วยบริการ ตามจริงไม่เกิน 150 บาทต่อครั้ง การให้บริการนอกหน่วยบริการ ตามจริงไม่เกิน 450 บาทต่อครั้งและเมื่อสิ้นสุดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลางแล้วผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ และค่า Barthel ADL index เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ จะจ่ายอีก 3,000 บาท/ราย ค่าฟื้นฟู โดยผู้ประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขาที่ตรงกับกิจกรรมบริการ จ่ายตามจริงไม่เกิน 450 บาทต่อครั้ง ค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม

สำหรับการให้บริการที่บ้านหรือที่พักอาศัยของผู้ป่วยระยะกลาง ในกรณีผู้รับบริการมีข้อจำกัดในการเดินทางมารับบริการที่หน่วยบริการ จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) รายใหม่ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง การจ่ายตามรายการอัตรา (Fee schedule) อัตราจ่าย 150 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 20 ครั้ง หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน บันทึกค่า BI ทุกครั้งจ่ายเพิ่มเติม 1000 บาท เมื่อให้บริการผู้ป่วยรายเดิมครบ 20 ครั้ง ในหน่วยบริการเดียวกัน ค่าบริการการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว (Independent Living) จากเดิมรายละ 9,000 บาท ปรับเป็น 11,000 บาท

2.3 กองทุนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care)

การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เคลื่อนไหวได้ อาจมีปัญหาการกินหรือขับถ่ายเล็กน้อยหรืออาจมีปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มที่ 2 เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อยมาก อาจมีปัญหาการกินหรือขับถ่ายหรือมีอาการป่วยรุนแรง และ กลุ่มที่ 4 เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต โดยในแต่ละกลุ่มจะถูกประเมินและวางแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) 1 ครั้งต่อปี โดยผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care manager: CM) จากนั้นคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารอื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นหรือผู้แทน (เช่น โรงพยาบาลอำเภอ) และสาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทน จะทำหน้าที่อนุมัติโครงการตามแผนการดูแลรายบุคคลที่หน่วยจัดบริการเสนอขอรับการสนับสนุน ซึ่งอัตราค่าบริการ LTC เป็นอำนาจดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ LTC ที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ฯ โดยมีลักษณะของการให้บริการแบบเหมาจ่ายต่อรายต่อปีตามแผนการดูแลรายบุคคล ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้บริการเกิดประโยชน์ทางสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไว้ด้วยแล้ว เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น โดยหน่วยที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนค่าบริการ LTC ได้แก่ หน่วยบริการ สถานบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน[20] โดย สปสช. ได้อนุมัติเพิ่มงบประมาณการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจาก 6,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 10,442 บาทต่อคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งรวมค่าบริการสำหรับผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care) (ผู้ป่วยสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะปานกลาง/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย) และสถานชีวาภิบาล เข้าร่วมด้วย[20]

การให้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ได้แก่ เยี่ยมบ้าน Home visits และสนับสนุนองค์ความรู้พื้นฐานการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลพยาบาลเฉพาะ โดย Care Giver ทีมพยาบาล อาสาสมัคร จิตอาสา มีการจัดสภาพแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ และประเมินผลการดูแลและปรับแผนการดูแลรายบุคคลอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ทำงานร่วมกับ หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นคู่สัญญากับ สปสช. นอกจากนั้นยังมีการจัดหาอุปกรณ์ทางการ

แพทย์และเครื่องช่วยที่จำเป็นตามสภาพผู้สูงอายุพึ่งพิง อาทิเช่น ที่นอนลม ชุดออกซิเจน เตียงปรับระดับ ชุดดูดเสมหะ

นอกเหนือจากการสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ สปสช. ยังได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการสำหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver: CG) ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘[22] ซึ่งสะท้อนบทบาทของระบบ LTC ในการสร้างการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามระดับการอบรม ดังนี้

- จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน สำหรับ CG ที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 70 ชั่วโมง
- จ่ายไม่เกิน 6,000 บาท/เดือน สำหรับ CG ที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 120 ชั่วโมง
- จ่ายไม่เกิน 9,000 บาท/เดือน สำหรับ CG ที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 420 ชั่วโมง

2.4 กองทุนการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)

"กองทุนการดูแลแบบประคับประคอง" หรือ "e-claim Palliative Care" หมายถึง ระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ที่ดำเนินการโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยกำหนดให้โรงพยาบาลสามารถเบิกค่าบริการ e-claim ได้ในกรณีที่ดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 6 เดือน และผู้ป่วยเสียชีวิตโดยสามารถเบิกได้สูงสุด 9,000 บาท ในปี พ.ศ. 2567[23, 24] ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงบประมาณให้การดูแลต่อเนื่องโดยการโอนย้ายงบค่าบริการ e-claim ไปยังกองทุนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (LTC) โดยการให้บริการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ได้แก่ การให้ออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ร่วมกับการติดตามอาการตามความเหมาะสม การทำแผล และชุดทำความสะอาด การให้ยากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น / การให้ยา Morphine การให้คำแนะนำญาติในการสังเกตอาการผิดปกติ และการดูแผู้ป่วย การประเมินอาการผู้ป่วยเมื่อมีการปรับการรักษา บริการให้ยืมอุปกรณ์ราคาสูง เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องให้ยา เตียงผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ โดยการให้บริการของโรงพยาบาล ชุมชน / สถานชีวาภิบาล โดยศักยภาพของหน่วยบริการต้องตรงตามเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการของกองทุนนั้นๆ

3. การเปรียบเทียบการดำเนินงานของระบบ IMC และ LTC กับกรอบแนวคิดของประเทศต่างๆ

3.1 ขอบเขตของการให้บริการ (Care model)

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการให้บริการ (Care model) ของระบบ IMC และ LTC มีขอบเขตของการให้บริการที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ สำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลขอบเขตของการให้บริการของระบบ IMC และ LTC ในประเทศไทย และต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเทศที่มีรูปแบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ประเทศไทย

- **การให้บริการของระบบ IMC ของประเทศไทย[25]**

การให้บริการของระบบ IMC เน้นให้บริการผู้ป่วยประมาณช่วง 6 เดือนแรก หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยเฉียบพลัน (acute phase) เรียกว่า “ช่วง Golden Period” เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วและมากที่สุด เนื่องจากสมองและร่างกายมีศักยภาพในการซ่อมแซมสูงสุดในช่วงเวลานี้ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสกลับมาใกล้เคียงกับปกติได้สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะพิการถาวร และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ตลอดจนช่วยลดภาระของครอบครัวและสังคม

สถานที่ที่ให้บริการดูแลสุขภาพของระบบ IMC ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

1. หอผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care Ward: IMC Ward) เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือ โรงพยาบาลที่มีบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีจุดประสงค์เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ผ่านพ้นภาวะวิกฤตแล้ว แต่ยังมีอาการคงที่และมีความบกพร่องทางร่างกายบางส่วน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพ
2. เตียงสำหรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Intermediate Care Beds) จัดตั้งอยู่ในหอผู้ป่วยระยะกลาง หรือ ใน Intermediate Care Unit หรือ IMC Ward หรือ Step-down Unit สำหรับรองรับผู้ป่วยที่อาการหนักเกินไปสำหรับหอผู้ป่วยทั่วไป (general ward) แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องนอนห้อง ICU
3. รักษาฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก (OPD visit) เป็นการฟื้นฟูหรือรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้อง admit เข้าหอผู้ป่วย ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยและญาติไม่ยินยอม admit แพทย์จะทำการส่งต่อไปที่งานกายภาพบำบัด ซึ่งการนัดรักษาฟื้นฟูแบบ OPD visit คือ นัด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ในช่วง 6 เดือนแรกหลังเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยเฉียบพลัน โดยจะรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือจนกว่าผู้ป่วยมี BI=20
4. การบริการเยี่ยมบ้านในชุมชน เป็นบริการในกรณีผู้ป่วยที่ยังมีความบกพร่องทางกายแต่ไม่สามารถมารับบริการแบบผู้ป่วยนอกได้ จะได้รับบริการเยี่ยมบ้านในรูปแบบของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีนักกายภาพบำบัดและทีมสหสาขาวิชาชีพให้บริการร่วมกับพยาบาล และเจ้าหน้าที่ของ Primary Care Unit; PCU หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยการออกให้บริการเยี่ยมบ้านในชุมชน และการติดตามฟื้นฟูอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือนในช่วง 6 เดือนแรก หรือดูแลให้ BI=20 ภายใน 6 เดือน (สูงสุดจำนวน 20 ครั้ง)

การให้บริการครอบคลุมเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลด้านการใช้ยา และการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) บาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง (Traumatic brain injury) บาดเจ็บทางไขสันหลัง (Spinal cord injury) และกระดูกสะโพกหัก (Hip fracture) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่

จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู โดยผู้ให้บริการ คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายเน้นเฉพาะการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักแก้ไขการพูด โดยมีระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการระบบ IMC แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิ 30 บาท) สำหรับผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งแบบ IMC Ward แบบ OPD visit และการบริการเยี่ยมบ้านในชุมชน 2) สวัสดิการข้าราชการ ให้บริการทั้งแบบ IMC Wards และ OPD visit โดยค่าบริการสามารถเบิกได้ตามจริง ภายใต้หมวด 14 ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู และ 3) ประกันสังคม ครอบคลุมการเบิกค่าบริการทางกายภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟูตามค่าใช้จ่ายจริง

- **การให้บริการของระบบ LTC ของประเทศไทย[26]**

การให้บริการของระบบ LTC เป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (dependent) โดยมีคะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel Activities of Daily Living: ADL) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน และต้องได้รับการอนุมัติแผนการดูแลระยะยาวรายบุคคล (Care Plan) จากคณะอนุกรรมการ LTC และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ที่ให้บริการดูแลสุขภาพของระบบ LTC ในประเทศไทย มีจุดเน้นสำคัญที่การดูแลในระดับชุมชน โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อติดตาม ดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ รวมถึงการให้บริการถึงบ้าน (Home visit) และบริการชุมชน (Community-based care) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย ลดภาระการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การให้บริการมุ่งเน้นการจัดบริการดูแลสุขภาพที่บ้านและในชุมชน โดยยึดตามแผนการดูแลรายบุคคล (Individual Care Plan) ที่กำหนดตามความต้องการและสภาพปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งการให้บริการดังกล่าวครอบคลุมถึงการดูแลแบบต่อเนื่อง การจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการประเมินผลการดูแลเป็นระยะ และการปรับแผนการดูแลให้สอดคล้องกับสภาวะของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) Care plan 2) Care giver 3) Care manager โดยผู้ให้บริการ คือ บุคลากรสาธารณสุข และ Care giver ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการระบบ LTC แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งครอบคลุมผู้รับบริการทุกสิทธิการรักษา โดยสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในฐานะหน่วยดำเนินงานและผู้บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น งบประมาณดังกล่าวจัดสรรตามจำนวนผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ในอัตราเหมาจ่าย 10,442 บาทต่อคนต่อปี และ 2) งบประมาณจากการบูรณาการท้องถิ่น ที่

นำมาใช้สนับสนุนการจ้างงานผู้ดูแล (Caregiver) เพื่อให้การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในชุมชน

(2) ประเทศสิงคโปร์[27]

ประเทศสิงคโปร์มีกรอบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางและระยะยาว (Intermediate and Long-Term Care: ILTC) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health: MOH) และหน่วยงาน Agency for Integrated Care (AIC) ซึ่งระบบ ILTC เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูหรือการดูแลระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจุดเน้นสำคัญของระบบ ILTC คือ การบูรณาการและเชื่อมโยงบริการด้านสุขภาพและสังคม ระหว่างโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟู ชุมชน และบ้านพักผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับการดูแลได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูหลังการรักษาในโรงพยาบาล การดูแลที่บ้าน หรือการเข้าพักในศูนย์ดูแลระยะยาว นอกจากนี้ ระบบ ILTC ยังมี AIC ทำหน้าที่ประสานงานด้านการดูแล (Care Coordinators) และเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ เพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ทำให้สามารถวางแผนการรักษาและติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ระบบ ILTC จึงเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานแบบเชื่อมโยงกันอย่างบูรณาการ (Integrated Care) ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยลดภาระของระบบสาธารณสุขโดยรวม

การให้บริการระบบ ILTC ครอบคลุม 4 ประเภท ได้แก่ 1) บริการที่บ้าน (Home-Based Care Services) เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้รับการดูแลที่บ้าน เพื่อลดการเข้าพักในโรงพยาบาลและสนับสนุนการอยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัย 2) บริการศูนย์ดูแลกลางวัน (Day Care Services) บริการนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสามารถเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ในเวลากลางวันและกลับบ้านในตอนเย็น เพื่อช่วยลดภาระของครอบครัวและส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย 3) บริการสุขภาพจิตในชุมชน (Community Mental Health Services) มุ่งเน้นดูแลผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน และ 4) บริการชุมชน (Community-Based Care) เป็นบริการในระดับชุมชนเพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อาศัยในบ้านและชุมชนได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผู้ให้บริการ คือ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ผู้ดูแล (Care giver) และ ผู้ให้บริการด้านสังคม (Social care)

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของสิงคโปร์ในระบบ ILTC ประกอบด้วย **1) Long-Term Care Insurance** ได้แก่ ElderShield และ CareShield Life เป็นประกันภัยสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระยะยาว **2) Subsidies สำหรับบริการ ILTC** โดยรัฐบาลสิงคโปร์ให้เงินอุดหนุน (Subsidy) แก่ผู้สูงอายุที่ใช้บริการ ILTC โดยคำนวณตามรายได้ครัวเรือนของผู้สูงอายุ และครอบคลุมบริการหลายประเภท เช่น Intermediate and Long-Term Care (ILTC) Services Subsidy หรือ Home Caregiving Grant (HCG) หรือ Interim Disability Assistance Programme for the Elderly (IDAPE)

(3) ประเทศญี่ปุ่น

- **การให้บริการของระบบ IMC ของประเทศญี่ปุ่น[28]**

ประเทศญี่ปุ่นมีการให้บริการของระบบ IMC ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างการรักษาเฉียบพลันในโรงพยาบาลและการฟื้นฟูหรือการดูแลระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากการกลับเข้ารักษาซ้ำ และสนับสนุนการกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านหรือชุมชนอย่างปลอดภัย โดยรูปแบบหลักของการให้บริการ IMC แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่

1. การดูแลในโรงพยาบาลเฉพาะช่วงการเปลี่ยนผ่าน (Only in the hospital in the care transition period) เป็นบริการที่จัดในโรงพยาบาล ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านการดูแล จากการรักษาเฉียบพลันไปสู่การฟื้นฟูหรือการดูแลต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันก่อนออกจากโรงพยาบาล
2. การดูแลหลังการออกจากโรงพยาบาลจนถึง 30 วัน (Transition care intervention at discharge and until 30 days of discharge) เป็นการติดตามและให้บริการต่อเนื่องหลังผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ในช่วง 30 วันแรก บริการอาจรวมถึงการเยี่ยมบ้าน การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การฟื้นฟูทางกายภาพ และการติดตามอาการ เพื่อป้องกันการกลับเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลซ้ำ และสนับสนุนการปรับตัวของผู้ป่วยและครอบครัว
3. การดูแลที่บ้าน (Interventions provided at home) เป็นบริการ IMC ที่ถูกจัดที่บ้านของผู้ป่วย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ กิจกรรมได้แก่ การฟื้นฟูทางกายภาพ การพยาบาล การดูแลส่วนบุคคล และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันที่บ้านและชุมชนได้อย่างปลอดภัย
4. บริการในโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์หลังการรักษาเฉียบพลัน (Community hospitals and facilities after the completion of acute phase care) เป็นบริการที่จัดในโรงพยาบาลชุมชนหรือศูนย์ฟื้นฟู หลังจากผู้ป่วยเสร็จสิ้นการรักษาเฉียบพลันในโรงพยาบาลหลัก โดยเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การปรับตัวกับกิจวัตรประจำวัน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับไปอยู่บ้าน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบบูรณาการและลดภาระของโรงพยาบาลหลัก

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ IMC ในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการผ่านระบบประกันสุขภาพ (Health Insurance) ประชาชนทุกคนในญี่ปุ่นต้องอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพแบบบังคับ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาและการฟื้นฟูบางส่วน โดยสำหรับ IMC ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยจะถูกคำนวณตามอัตราร่วมจ่าย (co-payment) โดยทั่วไปผู้ป่วยจ่าย 10–30% ของค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอายุและรายได้ของแต่ละบุคคล

- **การให้บริการของระบบ LTC ของประเทศญี่ปุ่น[29]**

ประเทศญี่ปุ่นมีการให้บริการของระบบ LTC โดยออกแบบเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุ 40–64 ปี ที่มีโรคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับช่วงวัย (age-related diseases) โดยระบบนี้มีทั้งบริการที่บ้านและบริการในศูนย์หรือสถานพยาบาล เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยรูปแบบหลักของการให้บริการ LTC แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) บริการที่บ้าน (In-Home Services) เป็นบริการที่สนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่บ้าน และ 2) บริการในสถานพยาบาลและศูนย์ดูแลระยะยาว (LTC Facilities) โดยผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลมากกว่าการอยู่บ้าน สามารถเข้าถึงบริการในศูนย์ดูแลระยะยาวและโรงพยาบาลชุมชนได้ เช่น Day Care Service, Outpatient Rehabilitation, Short-Term Admission, Special Facilities และ Intensive Care Home ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีอิสระในการใช้ชีวิตได้มากที่สุด และสนับสนุนการอยู่ร่วมกับครอบครัวหรือในชุมชน พร้อมกับมีการดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อมีความจำเป็น โดยผู้ให้บริการ คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีม Social welfare และทีมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (municipal officials) ดังนั้น ระบบ LTC ของญี่ปุ่น สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง สำหรับดูแลผู้สูงอายุจากที่บ้านหรือในศูนย์ LTC ทั้งในด้านสุขภาพ กิจวัตรประจำวัน และสังคม ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรือในชุมชนได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ LTC ในประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการผ่านระบบ Long-Term Care Insurance (LTCI) ซึ่งเป็นระบบประกันสำหรับผู้สูงอายุของญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาว ทั้งที่บ้านและในสถานพยาบาล LTC Facilities โดยการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Municipalities) ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนหลักมาจาก 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) รัฐบาลกลาง (Central Government) ประมาณ 25% ของงบประมาณ LTCI 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Municipalities / Local Governments) ประมาณ 25% ของงบประมาณ LTCI และ 3) เบี้ยประกันของผู้สูงอายุ (Premiums from Insured Persons) ประมาณ 50% ซึ่งผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบ LTCI จะจ่ายเบี้ยประกันรายเดือนตามอายุและระดับรายได้

(4) สหราชอาณาจักร

- **การให้บริการของระบบ IMC ของสหราชอาณาจักร[30]**

การให้บริการของระบบ IMC ของสหราชอาณาจักร เป็นระบบบริการที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยที่มีความต้องการการฟื้นฟูหรือการดูแลระยะกลางหลังจากการรักษาเฉียบพลันในโรงพยาบาล หรือเพื่อป้องกันการเข้ารักษาในโรงพยาบาลซ้ำ โดยเน้นการอยู่ร่วมในชุมชนและส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ป่วย ซึ่งระบบ IMC แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ดังนี้ 1) การดูแลระยะกลางบนเตียง (Bed-based Intermediate Care) เป็นบริการที่ให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวในเตียงโรงพยาบาลระยะกลาง (Intermediate Care Hospital) หลังจากการรักษาเฉียบพลัน ซึ่งมุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย 2) การดูแลตอบสนองต่อวิกฤต (Crisis Response Care) เป็นบริการที่ออกแบบเพื่อป้องกันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล

ฉุกเฉิน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพจะเข้าประเมินและจัดการผู้ป่วยในช่วงวิกฤต เช่น การติดตามอาการฉุกเฉิน การให้ยา หรือการเยี่ยมบ้านอย่างเร่งด่วน เพื่อลดภาระโรงพยาบาลและสนับสนุนผู้ป่วยให้ฟื้นตัวในบ้านหรือชุมชนได้ 3) การดูแลระยะกลางที่บ้าน (Home-based Intermediate Care) เป็นบริการ IMC ที่จัดให้ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าเยี่ยม ซึ่งบริการประกอบด้วย การฟื้นฟูทางกาย การดูแลสุขภาพทั่วไป การช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน และการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันในบ้านได้อย่างปลอดภัย และ 4) การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) ซึ่งการฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของ IMC ครอบคลุมทั้งการฟื้นฟูร่างกาย สมรรถภาพการเคลื่อนไหวและกิจวัตรประจำวัน โดยบริการสามารถจัดในศูนย์ฟื้นฟู โรงพยาบาลระยะกลาง หรือที่บ้านก็ได้ เพื่อส่งเสริมการกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนและลดความเสี่ยงในการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาล

การให้บริการของระบบ IMC ออกแบบมาเพื่อให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มอาการที่แพทย์เห็นว่าการเข้ารับบริการ IMC จะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและการปรับตัวกลับสู่ชีวิตประจำวัน โดยไม่ได้จำกัดเพียงผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ครอบคลุมทั้งผู้สูงอายุที่ฟื้นตัวจากโรคเฉียบพลัน หลังการผ่าตัด หรือผู้ที่ต้องการการดูแลและฟื้นฟูเพื่อป้องกันการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลซ้ำ โดยทั่วไประยะเวลาให้บริการ IMC จะอยู่ที่ประมาณ 6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เพียงพอสำหรับการประเมินสมรรถภาพของผู้ป่วย วางแผนการฟื้นฟู และติดตามความก้าวหน้าของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และกิจวัตรประจำวัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาและรูปแบบการให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความเห็นและนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ประเมินทรัพยากร ความพร้อมของชุมชน และความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย เพื่อให้แน่ใจว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม

ในสหราชอาณาจักร การให้บริการของระบบ IMC เป็นส่วนหนึ่งของ National Health Service (NHS) ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพและการฟื้นฟูต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่ายหลักในการให้บริการด้านสุขภาพของ IMC จะถูกสนับสนุนโดย NHS ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูและดูแลต่อเนื่องได้โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายตรง ระบบนี้เน้นการให้บริการแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้ง การฟื้นฟู การดูแลทั่วไป และการสนับสนุนที่บ้าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีบริการเสริม เช่น การดูแลส่วนบุคคลหรือบริการที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง อาจต้องมีการจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกับหน่วยงานสวัสดิการชุมชน (Social Care)

- **การให้บริการของระบบ LTC ของสหราชอาณาจักร[31]**

การให้บริการของระบบ LTC ของสหราชอาณาจักร มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะยาว โดยเฉพาะผู้ที่มีความซับซ้อนด้านโรคและต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพและกิจวัตรประจำวัน โดยระบบนี้ครอบคลุมหลายรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในบ้านหรือชุมชนได้อย่างปลอดภัย ระบบ LTC ของสหราชอาณาจักร มีบริการหลัก 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) การดูแลที่บ้าน (Home-Based Care) เป็นการให้บริการผู้ป่วยที่ยังสามารถอยู่บ้านได้ แต่ต้องการการสนับสนุนด้านกิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟู เช่น การดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

2) บ้านพัก (Care Homes) เป็นการให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถอยู่บ้านได้อย่างปลอดภัย หรือมีความต้องการการดูแลต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้งการดูแลกิจวัตรประจำวัน (Residential Care Homes) และการมีพยาบาลดูแลและให้บริการสุขภาพ (Nursing Homes) ครอบคลุมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลสุขภาพ และการสนับสนุนด้านสังคม และ 3) การดูแลแบบผสมผสาน (Integrated Care) เป็นการลดรอยต่อระหว่าง Health Care และ Social Care เพื่อให้บริการต่อเนื่องและครบวงจร โดยเน้นผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนด้านโรคหลายระบบ และต้องการการดูแลทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิการ ซึ่งระบบนี้มักใช้กับผู้ที่ได้รับ NHS Continuing Care ซึ่งเป็นบริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะยาวและต่อเนื่องจาก NHS ดังนั้น ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิการ ลดความจำเป็นในการเข้ารักษาโรงพยาบาลซ้ำ และสนับสนุนคุณภาพชีวิตในชุมชนได้

ระบบ LTC มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนผู้ดูแลหลัก (Carer) ที่อยู่เบื้องหลังการดูแลผู้ป่วย หรือเรียกว่า Carer Support เป็นการสนับสนุนผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ผ่านการระบุผู้ดูแลอย่างชัดเจน (Identification of Carers) เพื่อให้ได้รับสิทธิและการสนับสนุน และมีการติดตามสุขภาพกายและใจของผู้ดูแล (Monitoring Carer Health and Well-being) เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและป้องกันความเหนื่อยล้าหรือภาวะ Burnout เป็นการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายมาจาก 2 แหล่งหลัก ได้แก่ 1) National Health Service (NHS) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นบริการด้านสุขภาพ (Health Care Services) เช่น การตรวจรักษาและติดตามอาการ การให้ยาและการพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมบำบัด โดยผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายตรง (free at point of delivery) สำหรับบริการด้านสุขภาพเหล่านี้ และ 2) รัฐบาลท้องถิ่น (Local Authority) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นบริการด้านสังคม (Social Care) เช่น การช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน (อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร) การดูแลที่บ้าน (Home Care) การสนับสนุน Carers และบริการชุมชน โดยผู้ป่วยรายอาจต้องร่วมจ่ายตามรายได้หรือทรัพย์สินที่มีอยู่ของตนเอง ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ายเงิน (Payment Models) แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การจ่ายตามผลลัพธ์ (Outcome-Based Payment) คือ การจ่ายเงินขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย และ 2) การจ่ายแบบผสม (Blended Payments) คือ การผสมระหว่าง Outcome-Based Payment และ Pay-Per-Visit โดยผู้ให้บริการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนครั้งของการเยี่ยมและตามผลลัพธ์ของผู้ป่วย ซึ่งช่วยสร้างความสมดุลระหว่างการสนับสนุนการให้บริการและคุณภาพผลลัพธ์ เพื่อให้บริการมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแลได้อย่างเหมาะสม

จะเห็นได้ว่า ขอบเขตของการให้บริการระบบ IMC และ LTC ในแต่ละประเทศมีรูปแบบการจัดบริการที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องระดับการบูรณาการ แหล่งเงินทุน และรูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะเฉพาะของระบบ IMC และ LTC ของแต่ละประเทศ ทำให้แต่ละประเทศมีแนวทางการดูแลที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและโครงสร้างระบบสาธารณสุขของตนเอง อย่างไรก็ตาม ระบบ IMC และ LTC ของทุกประเทศมีจุดร่วมที่สำคัญคือ การมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย และการดูแลอย่างต่อเนื่องหลัง

การเจ็บป่วยหรือการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายคือช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนหรือบ้านของตนเองได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

3.2 รูปแบบการบริการและความครอบคลุมของระบบ LTC ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับแนวคิดของ WHO

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดแนวทางของรูปแบบการบริการหลัก (core interventions) ของระบบการดูแลระยะยาว (LTC) โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ดูแลอย่างรอบด้าน โดยได้แบ่งการดูแลเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) กลุ่มการดูแลด้านสุขภาพ (Health care needs) ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง การประเมิน และการจัดการปัญหาสุขภาพที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการลดความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (functional ability) 2) กลุ่มการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care needs) โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการตายในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต ครอบคลุมการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานทั้งทางกาย จิตใจ และ 3) กลุ่มการดูแลทางสังคม (Social care and support needs) เพื่อช่วยลดข้อจำกัดและเพิ่มศักยภาพการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ผ่านการสนับสนุนการทำกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living: ADL) และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม[9]

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าสามารถเปรียบเทียบรูปแบบการบริการของประเทศไทยกับแนวทาง core interventions ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ดังตารางที่ 4 โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจัดระดับความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุน LTC ออกเป็น 3 สถานะ ได้แก่ สถานะสีแดง (O) หมายถึง ความครอบคลุมน้อยที่สุด โดยในด้านดังกล่าวยังไม่มีสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจนในระบบ LTC ของไทยหรืออาจมีเพียงคำแนะนำในเชิงแนวทางเท่านั้น (ซึ่งอาจครอบคลุมอยู่ในสิทธิสุขภาพอื่นๆ เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)) สถานะสีเหลือง (O) หมายถึง ความครอบคลุมในระดับปานกลาง โดยมีการให้คำแนะนำและมีการประเมินคัดกรอง แต่ยังไม่มีระบบการดูแลรักษาที่ชัดเจนหรือครอบคลุม และสถานะสีเขียว (O) หมายถึง ความครอบคลุมสูงสุด โดยในด้านนั้นมีทั้งการให้คำแนะนำ การประเมินคัดกรอง และการดูแลรักษา ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการจัดบริการอย่างเป็นระบบและมีอยู่จริงในสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุน LTC

* ในตารางแสดงถึง การอ้างอิงข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่การเงิน, CM และ CG ในจังหวัดนนทบุรี, สงขลา และอำนาจเจริญ

ตารางที่ 4 ความครอบคลุมของบริการระบบ LTC เปรียบเทียบกับแนวคิดของ WHO

WHO package	สิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุน LTC*	สถานะ*	หมายเหตุ	ความครอบคลุมในสิทธิสุขภาพอื่นๆ *(5-7)*
Health care				
- Cognitive decline (ภาวะสมองเสื่อม)	มี	(32)	- ร้อยละ 40 ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองพบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (Ref:ประกาศตัวชี้วัดปี 66)	- UC
- Limited mobility (จำกัดการเคลื่อนไหว)	มี	(7)	- มีการคัดกรองผู้สูงอายุติดเตียงและทำกายภาพบำบัด โดยพยาบาลวิชาชีพ	- UC - กองทุนตำบล - กองทุนฟื้นฟู
- Falls (การหกล้ม)	มี	(7), *	- มีเฉพาะให้คำแนะนำเรื่องสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการหกล้มโดย CG	- UC - กองทุนตำบล
- Physical inactivity and sedentary behavior (พฤติกรรมเนือยนิ่ง)	มี	(7), *	- มีเฉพาะการให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายโดย CG	- UC - กองทุนตำบล
- Unhealthy diet and substance abuse (การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมและการใช้สารเสพติด/สารที่เป็นอันตราย)	มี	(7), *	- มีเฉพาะการให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการ (สิทธิ UC มีคลินิก NCD, ให้คำแนะนำเลิกบุหรี่ สุรา และโครงการอาหารสุขภาพ)	- UC - กองทุนตำบล
- Malnutrition (ภาวะทุพโภชนาการ)	มี	(7), *		
- Eye conditions and visual impairment (โรคตาและความบกพร่องทางการมองเห็น)	ไม่ครอบคลุม		- กองทุน LTC โดยตรงไม่มีการดำเนินการด้าน eye และ ear care สิทธิดังกล่าวจะครอบคลุมในสิทธิบัตรทอง (1), สิทธิ	- UC

WHO package	สิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุน LTC*	สถานะ*	หมายเหตุ	ความครอบคลุมในสิทธิสุขภาพอื่นๆ *(5-7)*
- Ear diseases and hearing impairment (โรคหูและความบกพร่องทางการได้ยิน)	ไม่คลอบคลุม		ข้าราชการ และประกันสังคม โดยครอบคลุมการรักษาโรคตาและหู เช่นการผ่าตัดต้อกระจกและการตรวจรักษาโรคหูพื้นฐาน และมีการสนับสนุนแว่นสายตา เครื่องช่วยฟังให้กับผู้พิการหรือผู้สูงอายุบางกลุ่ม	- กองทุนฟื้นฟู ครอบคลุมแว่นตาและเครื่องช่วยฟัง
- Depressive symptoms and anxiety (อาการซึมเศร้าและความวิตกกังวล)	มี	(7), *	- มีการประเมินและป้องกันภาวะซึมเศร้า แต่ไม่มีวิธีการดูแลรักษาที่แน่ชัด	- UC มีคลินิกสุขภาพจิตแต่ไม่ทั่วถึง
- Polypharmacy (การใช้ยาหลายขนานร่วมกัน)	ไม่คลอบคลุม		- มีเฉพาะการเตือนให้ทานยาตามแพทย์สั่ง	- ไม่มี
- Pain (ความเจ็บปวด)	มี	*	- มีการให้ยาแก้ปวดและชุดปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นตาม CP ในบางพื้นที่อาจมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยลงเยี่ยมบ้านเป็นอาสาสมัคร (ซึ่งไม่ได้ค่าตอบแทน)	- UC การรักษาในรพ.
- Urinary and faucal incontinence (ภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่)	มี	(7, 33)	- มีการประเมินบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ มีการแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 5 ชิ้น/วัน, แผ่นรองซับการขับถ่าย 1 ชิ้น/วัน, แผ่นเสริมซึมซับ 2 ชิ้น/วัน	- UC การรักษาในรพ.
- Skin pressure injury (แผลกดทับ)	มี	(7), *	- มีการดูแลรักษา/ ทำความสะอาด ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ โดยพยาบาลวิชาชีพ	- UC การรักษาในรพ.
- Infections (การติดเชื้อ)	ไม่คลอบคลุม		- ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา	- UC รักษาในรพ.
- Oral diseases (โรคทางช่องปาก)	มี	*	- มีเฉพาะการให้คำแนะนำเบื้องต้นเรื่องการแปรงฟันและการดูแลช่องปากเบื้องต้น	- UC - กองทุนตำบล
Palliative care				
- Physical (การดูแลทางกาย)	มี	(7, 33), *		

WHO package	สิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุน LTC*	สถานะ*	หมายเหตุ	ความครอบคลุมในสิทธิสุขภาพอื่นๆ *(5-7)*
- Psychological, social and spiritual (การดูแลทางจิตใจ)	มี	(7, 33), *	- มีการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เช่น ที่นอนลม ชุดให้ออกซิเจน มีอาสาบริบาลท้องถิ่น ช่วยดูแลในระดับพื้นฐาน (การดูแลสุขภาพ-จิตใจ-สังคม) แต่ไม่ใช่ผู้ให้บริการ PC โดยตรง หากผู้ป่วยมีอาการซับซ้อน (เช่น หายใจลำบาก) ต้องส่งต่อให้ทีมแพทย์ในโรงพยาบาล	กองทุนเฉพาะกิจ PC, งบ e-Claim ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
Social care and support				
Older people				
- Support and assistance in ADL and IADL (ช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันพื้นฐานและซับซ้อน)	มี	(7, 33)	- มีเฉพาะการประเมิน ADL และการดูแลตามระดับความพึ่งพิง	- ไม่มี
- Participation in community and social life (การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม)	มี	*	- มีการแนะนำให้เข้าร่วมโครงการต่างๆของพื้นที่ ซึ่งขึ้นกับความเข้มแข็งของ อปท. เช่น การทำกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แต่ไม่ถูกบรรจุเป็น สิทธิบริการของงบกองทุน LTC	- กองทุนตำบล กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
- Accessibility and transport (การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการเดินทาง)	ไม่คลอบคลุม		- บางพื้นที่มี Service รับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณของกองทุน LTC	- กองทุนฟื้นฟู มีอุปกรณ์ รถเข็น
- Provision of assistive products (อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก)	มี	(7), *	- พื้นที่ส่วนใหญ่จัดยืมอุปกรณ์การช่วยเหลือมาจากรพสต. เช่น เตียงคนไข้ รถเข็นผู้ป่วย ซึ่งไม่ได้ใช้งบกองทุน LTC ในการจัดซื้อ	- กองทุนฟื้นฟู มีอุปกรณ์ รถเข็น
Carers				
- Psychosocial support (การสนับสนุนของผู้ดูแล)	มี	(7, 33)	- มีการจัดอบรม CG 70 ชม. และค่าตอบแทน CG 50 บาท/ชม. (1,500 - 2,000 บาท/เดือน) แต่การดูแลเชิงลึกด้านจิตใจและสังคมของผู้ดูแลยังไม่มีแนวทาง	- กองทุนตำบล มีจัดอบรม อสม.

WHO package	สิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุน LTC*	สถานะ*	หมายเหตุ	ความครอบคลุมในสิทธิสุขภาพอื่นๆ *(5-7)*
- Respite care (การดูแลชั่วคราว)	ไม่คลอบคลุม		- ไม่มีการดำเนินงานในเรื่องการดูแลทดแทนชั่วคราวของผู้ดูแล	- ไม่มี

3.3 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณบริการ LTC ในต่างประเทศ

ระบบการเงินการคลังของการดูแลระยะยาว (LTC) ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น นโยบายภาครัฐ ระบบภาษี และสัดส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 5 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณบริการ LTC ในประเทศต่างๆ

ประเทศ	กฎระเบียบและนโยบาย	การจัดเก็บรายได้เพื่อสนับสนุนระบบ LTC	รูปแบบการเงินการคลัง	ร้อยละของค่าใช้จ่ายดูแลระยะยาวที่จ่ายโดยตรงจากผู้ใช้ (Out-of-Pocket)	ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ใช้จ่ายด้านการดูแลระยะยาว
จีน[34, 35]	แผนยุทธศาสตร์หมายเลข 80 *Guiding Opinions on Piloting the Long-term care Insurance system* นำร่อง 20 พื้นที่	เงินสมทบของผู้สูงอายุในลักษณะประกันสังคม (Social insurance) และกองทุนรวม (Pooled fund) แยกตามพื้นที่เมืองและชนบท	ระบบประกันสังคม + การกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น	ไม่มีข้อมูล (NR)	0.5%
เกาหลีใต้[36, 37]	*the Integrated*	ระบบประกัน LTCI บริหารโดย	1) Public LTCI 2) Community-	home care: 15% /	1.1% (ปี 2021)

ประเทศ	กฎระเบียบและนโยบาย	การจัดเก็บรายได้เพื่อสนับสนุนระบบ LTC	รูปแบบการเงินการคลัง	ร้อยละของค่าใช้จ่ายดูแลระยะยาวที่จ่ายโดยตรงจากผู้ใช้ (Out-of-Pocket)	ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ใช้จ่ายด้านการดูแลระยะยาว
	Community Care Assistance Act ผ่านปี 2024 และจะเริ่มบังคับใช้มีนาคม 2026	*National Health Insurance Service (NHIS)*	based care (ผู้ให้บริการเอกชนตามสัญญา)	institutional care: 20%	
สิงคโปร์[1]	*CareShield Life and Long-Term Care Act* (2019)	*CareShield Life* (universal plan), *MediSave* (การออมบังคับตามรายบุคคล) และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ทดสอบตามรายได้)	รูปแบบผสมระหว่างรัฐและเอกชน เช่น Nursing homes, Day care, Community mental health	20–40% ขึ้นกับรายได้และประเภท LTC	0.9% (ปี 2016, LTCI Public 0.1%)
ญี่ปุ่น[38, 39]	*LTC Insurance Act* บริหารโดยเทศบาลภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข	LTCI Premiums, ภาษี, Co-payment	Social insurance (2 แบบ): (1) การบริการเป็นสิ่งของ (in-kind) เช่น home-visit, rehab, day-care (2) การจัดการผ่าน care managers	10–30% ขึ้นกับรายได้	2.3% (ปี 2017)
ออสเตรเลีย[40, 41]	*New Aged Care Act* (เริ่ม	ไม่มี LTCI ระบบผสม (Hybrid)	รัฐบาลท้องถิ่น (รัฐ/เขต) ดูแล nursing		1.2% (ปี 2021)

ประเทศ	กฎระเบียบและนโยบาย	การจัดเก็บรายได้เพื่อสนับสนุนระบบ LTC	รูปแบบการเงินการคลัง	ร้อยละของค่าใช้จ่ายดูแลระยะยาวที่จ่ายโดยตรงจากผู้ใช้ (Out-of-Pocket)	ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ใช้จ่ายด้านการดูแลระยะยาว
	1/11/2025) + *Support at Home Program*	โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณและผู้รับบริการร่วมจ่ายตามรายได้	homes ส่วน home care ดูแลโดยรัฐบาลท้องถิ่น	4–25% ขึ้นกับประเภทบริการและรายได้	
ฝรั่งเศส[42]	Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)	ภาษี 70%: ภาษีจากการทำงาน, ภาษีรายได้ และภาษีมรดก	ระบบผสม Public + Private (APA + ประกัน LTCI เอกชนเสริม)	30%	1.7%
เยอรมนี[43]	Social Security Code Book XI (SGB XI)	เงินสมทบจากนายจ้างและลูกจ้าง 63% และกองทุนสมทบจากภาครัฐ	ระบบผสม Public LTC (Soziale Pflegeversicherung) + Private LTC (PPV)	24%	2.5%
สเปน[44]	*Promotion of Personal Autonomy and Care for Dependent Persons Act (SAAD)* ปี 2006	ภาษีกลางและภาษีท้องถิ่น โดยเทศบาลรับผิดชอบส่วนใหญ่ (57%) และรัฐบาลกลาง (21%)	ระบบผสม Public LTC + Private LTC (สมัครใจ)	21%	0.9%
โครเอเชีย[45]	Social Welfare Act	เงินอุดหนุนจากรัฐและเทศบาล และกองทุนจาก	ระบบผสม Public model	10%	1%

ประเทศ	กฎระเบียบและนโยบาย	การจัดเก็บรายได้เพื่อสนับสนุนระบบ LTC	รูปแบบการเงินการคลัง	ร้อยละของค่าใช้จ่ายดูแลระยะยาวที่จ่ายโดยตรงจากผู้ใช้ (Out-of-Pocket)	ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ใช้จ่ายด้านการดูแลระยะยาว
		สหภาพยุโรป (EU social fund)			
เดนมาร์ก (46)	*Social Services Act* 1998 (แก้ไข 2019)	ภาษีรายได้ส่วนกลางและภาษีท้องถิ่น (municipal taxes)	ระบบผสม Public model	10%	1.95%
สวีเดน (5)	*Social Services Act* การดูแลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง	ระบบภาษีระดับชาติและเทศบาล	ระบบภาษีแบบ universal LTC (รัฐ/เทศบาลร่วมรับผิดชอบ)	5%	0.17%

จากข้อมูลพบว่าหลายประเทศมีกฎหมายและนโยบายสนับสนุนการดูแลระยะยาว (LTC) ที่แตกต่างกันตามบริบท ระบบเงินทุนครอบคลุมตั้งแต่ประกันสังคม (จีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น) เงินออมภาคบังคับรายบุคคลและเงินอุดหนุนจากรัฐ (สิงคโปร์) ไปจนถึงระบบภาษีและระบบผสมจากภาครัฐและเอกชน (ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สเปน, เดนมาร์ก, สวีเดน, ออสเตรเลีย) ค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้เอง (Out-of-Pocket: OOP) แตกต่างกันตั้งแต่ 0.17% (สวีเดน) ถึง 40% (สิงคโปร์) ขึ้นกับรายได้และประเภทบริการ โดยเอเชียมักเน้นระบบประกัน LTC และการจัดการโดยรัฐ/เทศบาล ส่วนยุโรปและออสเตรเลียเน้นระบบผสมที่รัฐสนับสนุนงบประมาณและผู้ใช้ร่วมจ่าย บางประเทศมีการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นเพื่อดูแล Nursing homes หรือ Home care ทำให้รูปแบบบริการและการจัดสรรงบประมาณมีความหลากหลายตามโครงสร้างการเงินและนโยบายของแต่ละประเทศ

จากการทบทวนพบว่า ปัจจัยความสำเร็จของระบบ LTC ประกอบด้วยการมีกฎหมายและนโยบายที่เข้มแข็งและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ (Regulation and policy supports) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสูงวัย การกระจายอำนาจและทรัพยากรจากส่วนกลางไปสู่หน่วยงานปกครองท้องถิ่น

(Decentralization to municipalities) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความใกล้ชิดกับประชาชน รวมถึงการจัดหาทรัพยากรทางการเงินที่เหมาะสมผ่านการผสมผสานแหล่งที่มาของเงิน (Appropriate revenue collection) เช่น การร่วมจ่ายตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Mean-test copayment) ดังที่เห็นในประเทศเดนมาร์ก หรือการปรับอัตราเงินสนับสนุนให้เหมาะกับพื้นที่ (Dynamic financing mechanism) อีกทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน (Out-of-pocket) ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมด้านการเข้าถึงบริการ ขณะเดียวกัน ระบบ LTC ที่ยั่งยืนยังควรเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น กรณีของเอสโตเนียที่ส่งเสริมการจ้างแรงงานหญิงที่ว่างงานมาฝึกเป็นนักบริบาล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการดูแล และเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงทางสังคมให้กับชุมชน

บทที่ 4 ผลการศึกษา

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

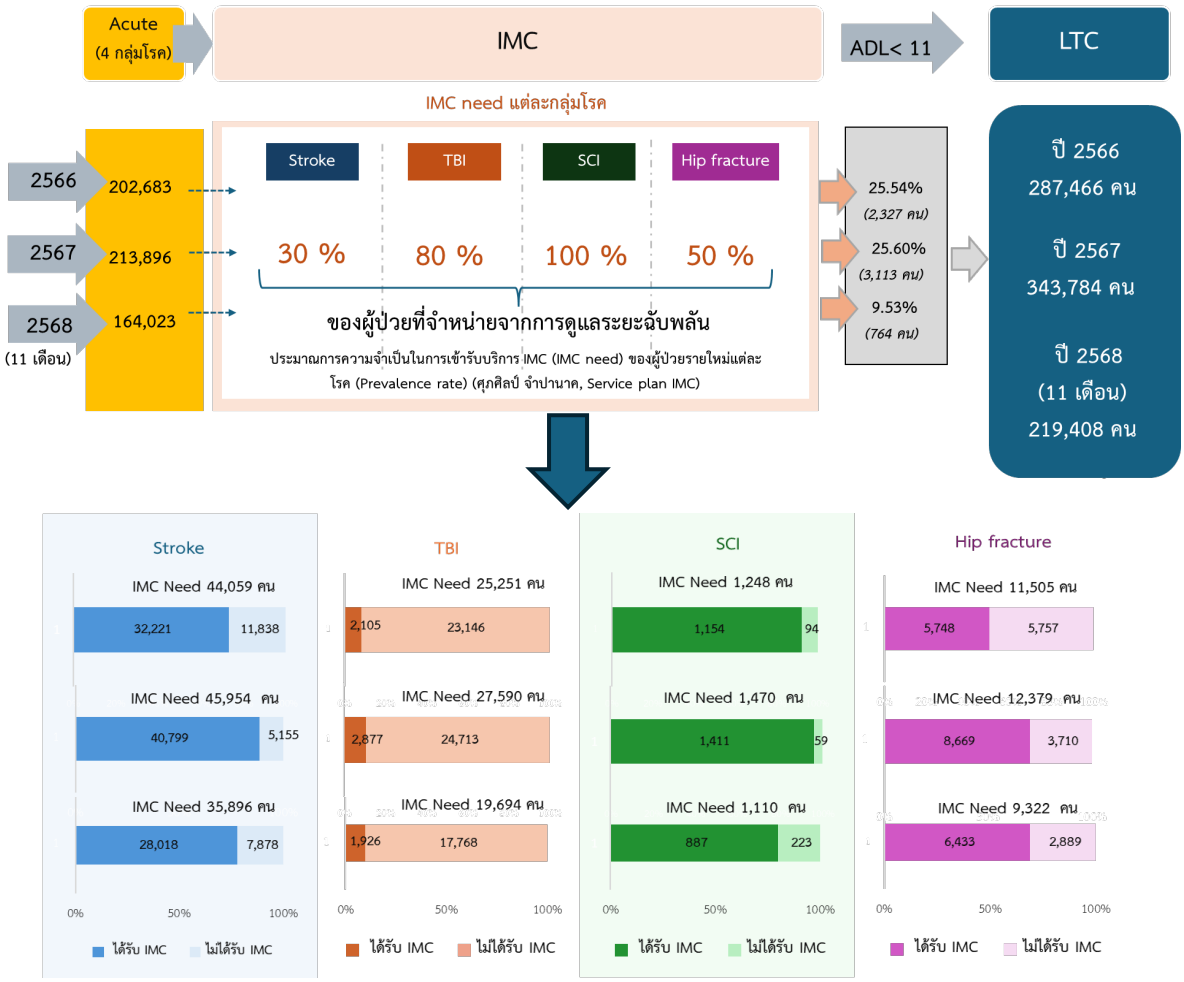
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณกับจากฐานข้อมูลผู้ป่วยจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลระยะกลาง (IMC) และระยะยาว (LTC) ในประเทศไทย สามารถจำแนกประเด็นออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเข้าถึงบริการ, ผลลัพธ์การฟื้นฟูของผู้ป่วยและผู้มีภาวะพึ่งพิง และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการเงินการคลังของทั้งสองระบบ ดังนี้

1.1 ระบบการดูแลระยะกลาง (IMC)

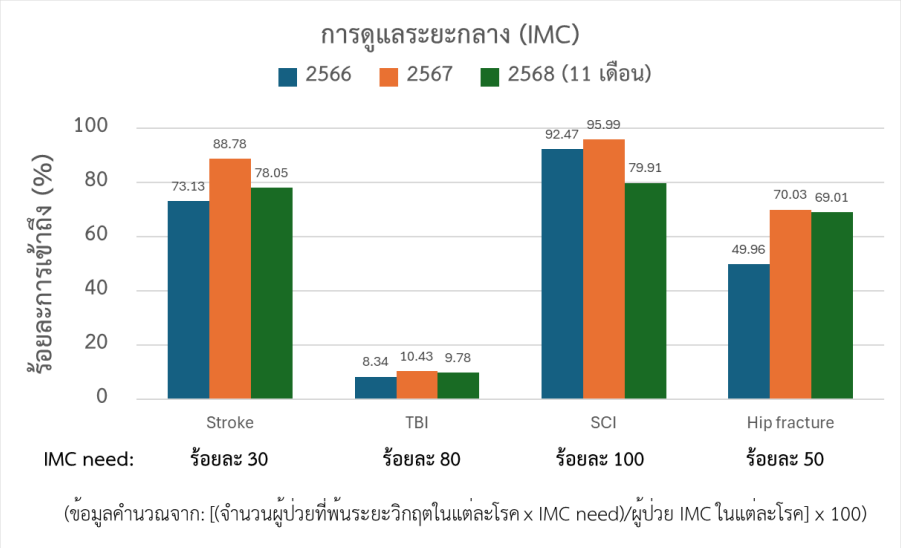
1.1.1 การเข้าถึงบริการดูแลระยะกลาง (IMC)

จากข้อมูลรายงานระบบบริการดูแลระยะกลาง (IMC) และระบบการดูแลระยะยาว (LTC) ของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (รูปที่ 4) พบว่า ในปีงบประมาณ 2566–2568 มีผู้ป่วยจากภาวะฉับพลัน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke), การบาดเจ็บที่สมอง (TBI), การบาดเจ็บไขสันหลัง (SCI) และกระดูกสะโพกหัก (Hip fracture) เข้าสู่ระบบ IMC รวมราว 200,000-220,000 คนต่อปี โดยสัดส่วนความจำเป็นในการเข้ารับบริการ IMC (IMC need) ในแต่ละโรคใช้ข้อมูลประมาณการจากแผนพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Service Plan IMC)[47] ได้แก่ Stroke ร้อยละ 30, TBI ร้อยละ 80, SCI ร้อยละ 100 และ Hip fracture ร้อยละ 50 ซึ่งสะท้อนความรุนแรงและความจำเป็นด้านการฟื้นฟูที่ไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มโรค เมื่อพิจารณาการเข้าถึงบริการจริง พบว่าผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (SCI) เข้าถึงบริการสูงที่สุด (ร้อยละ 79.91–95.99) ขณะที่ผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (TBI) เข้าถึงบริการต่ำที่สุด (ร้อยละ 8.34–10.43) (รูปที่ 5) เมื่อเทียบกับ IMC need ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นกลุ่มที่ได้รับบริการ IMC มากที่สุดทุกปี โดยในปี 2567 มีผู้รับบริการ 40,779 คน จาก IMC need ทั้งหมด 45,954 คน

หลังการฟื้นฟูผ่านระบบดูแลระยะกลาง (IMC) พบว่ามีผู้ป่วยราวร้อยละ 25 ของผู้ป่วยทั้ง 4 กลุ่มโรคที่ยังมีคะแนน ADL ต่ำกว่า 11 คะแนน และต้องส่งต่อเข้าสู่ระบบดูแลระยะยาว LTC (2,327 คนในปี 2566 และ 3,113 คนในปี 2567) ขณะเดียวกันยังมีผู้พึ่งพิงที่เข้าสู่ระบบดูแลระยะยาว LTC โดยไม่ผ่าน IMC ราว 300,000 คนต่อปี สะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของระบบดูแลระยะกลาง IMC ในการเชื่อมต่อการฟื้นฟูระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน ซึ่งมีศักยภาพในการช่วยบรรเทาภาระของระบบการดูแลระยะยาว LTC



ภาพที่ 4 จำนวนและร้อยละผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค จากระยะฉับพลันที่ได้รับบริการ IMC (จำแนกตามรายโรค) และ/หรือ LTC ในปีงบประมาณ 2566-2568 (เดือนพฤศจิกายน) (ที่มา: ฐานข้อมูล IMC และ LTC สปสช. เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568)

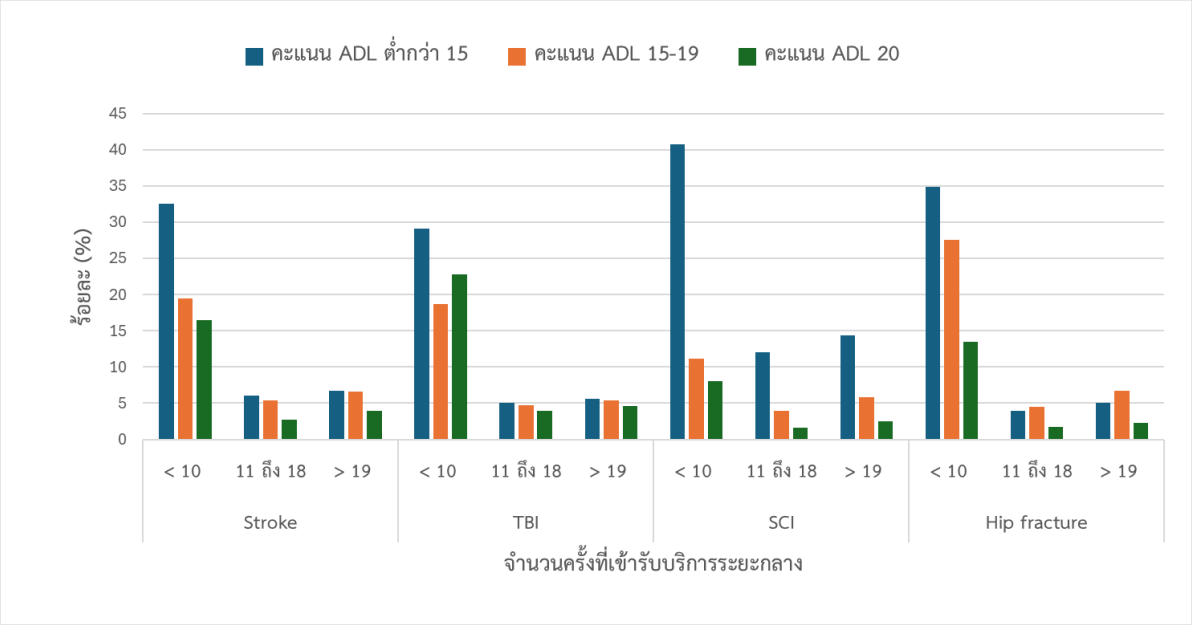


ภาพที่ 5 ความครอบคลุมของการดูแลระยะกลาง ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2568 (พฤศจิกายน) แยกตามรายโรค

1.1.2 ผลลัพธ์ด้านการฟื้นฟูของผู้ป่วยดูแลระยะกลาง (IMC)

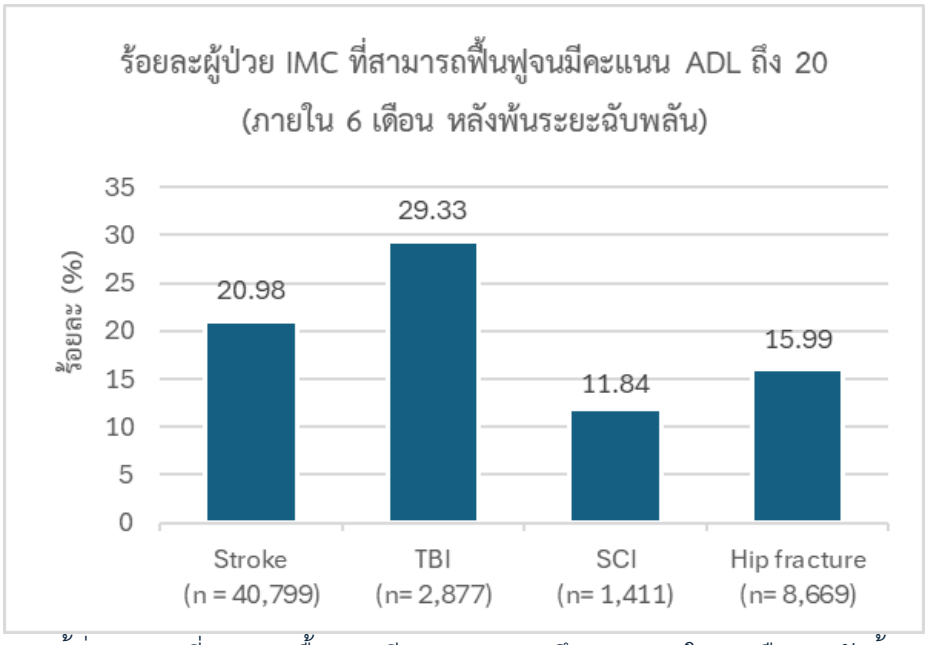
การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยดูแลระยะกลาง (Intermediate Care: IMC) เป็นระบบบริการที่มีบทบาทสำคัญในการลดภาระของระบบสุขภาพ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลในระบบ IMC ทั้ง 4 กลุ่มโรค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยระบบการดูแลที่มีความต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะทุพพลภาพจนไม่สามารถดูแลตนเองได้ และลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

จากข้อมูลการเข้ารับบริการดูแลระยะกลาง พบว่าแม้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะกำหนดให้สามารถเบิกจ่ายค่าบริการได้สูงสุด 20 ครั้งต่อปี แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ป่วย IMC ร้อยละ 33 ได้รับบริการน้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี โดยเฉลี่ยเพียง 8–10 ครั้งต่อคน และยังมีคะแนนความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) ต่ำกว่า 15 คะแนน (รูปที่ 6) ซึ่งสะท้อนว่าผู้ป่วยยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเพียงพอ และมีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ควรจะเป็น ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับบริการดูแลระยะกลางในจำนวนครั้งที่มากขึ้น หรือควรได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างครบถ้วน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และลดความเสี่ยงของการพึ่งพิงในระยะยาว

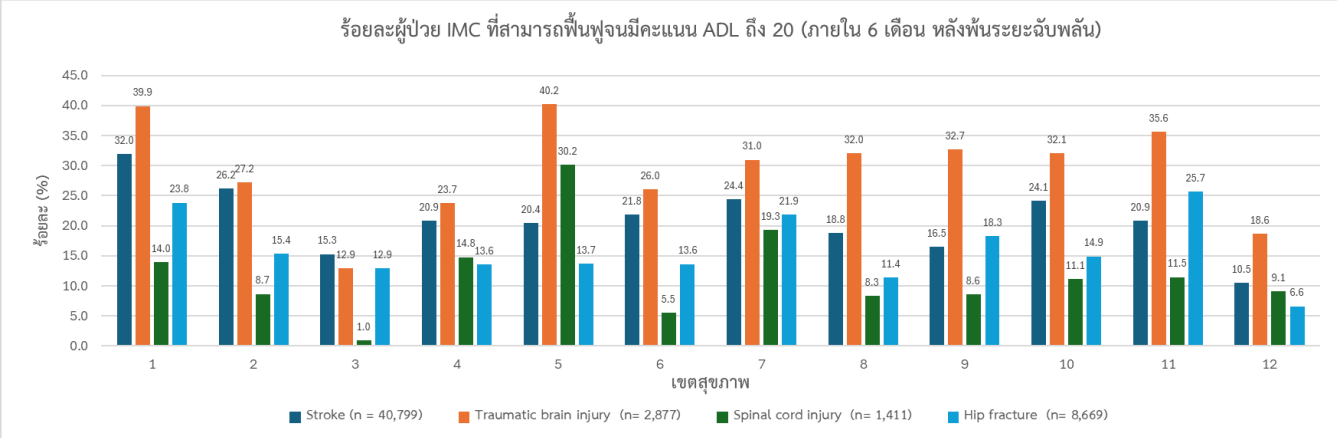


ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนครั้งที่ได้รับการดูแลระยะกลาง และคะแนน ADL จำแนกตามรายโรค

เมื่อพิจารณาผลการดูแลแยกรายโรค พบว่าสัดส่วนผู้ป่วยที่ฟื้นฟูจนมีคะแนน ADL เท่ากับ 20 ภายใน 6 เดือนหลังพ้นระยะฉับพลัน เฉลี่ยยังต่ำกว่าร้อยละ 30 ทุกกลุ่มโรค (ร้อยละ 21.0 ในโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke), ร้อยละ 29.3 ในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (TBI), ร้อยละ 11.8 ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (SCI) และร้อยละ 16.0 ในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก (Hip fracture) (รูปที่ 7)) เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 85 โดยพบว่าในเขตสุขภาพที่ 5 มีอัตราการฟื้นฟูมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 40.2 ในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (TBI) ขณะที่ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (SCI) เป็นกลุ่มที่ฟื้นฟูตามเป้าหมายได้ต่ำที่สุดทุกเขตสุขภาพ (รูปที่ 8) จึงควรพิจารณามาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น ขยายระยะเวลาการดูแลให้เหมาะสมกับความรุนแรงของโรค หรือพัฒนารูปแบบบริการดูแลแบบเข้มข้นสำหรับผู้ป่วยในในช่วงแรกหลังพ้นภาวะวิกฤต หรือเพิ่มการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด) ในการเยี่ยมบ้าน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการฟื้นตัวของผู้ป่วย



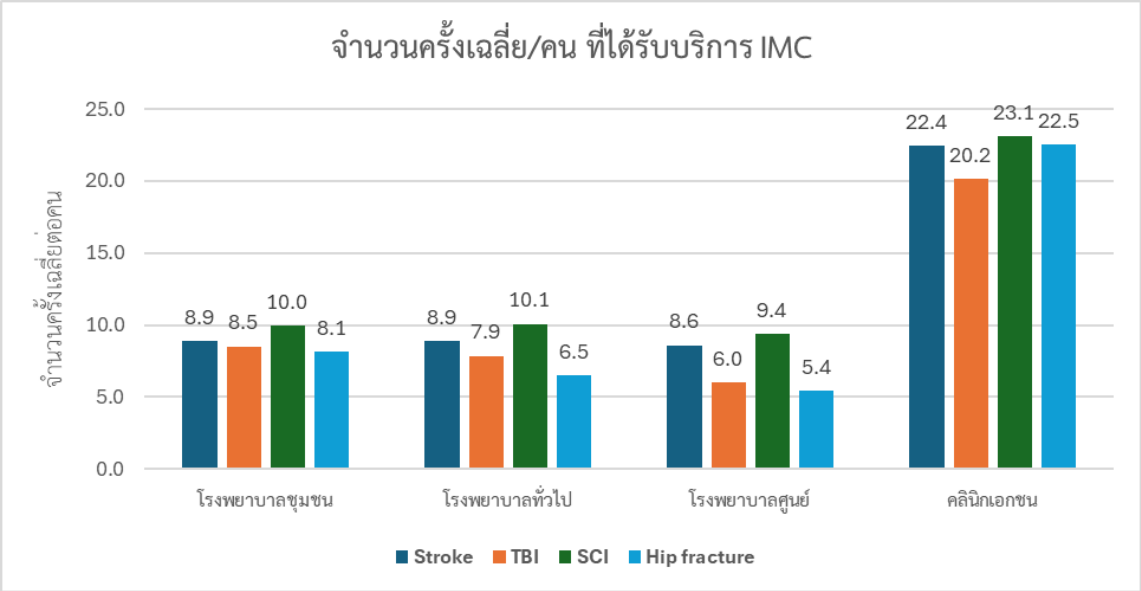
ภาพที่ 7 ร้อยละผู้ป่วย IMC ที่สามารถฟื้นฟูจนมีคะแนน ADL ถึง 20 (ภายใน 6 เดือน หลังพ้นระยะฉับพลัน)



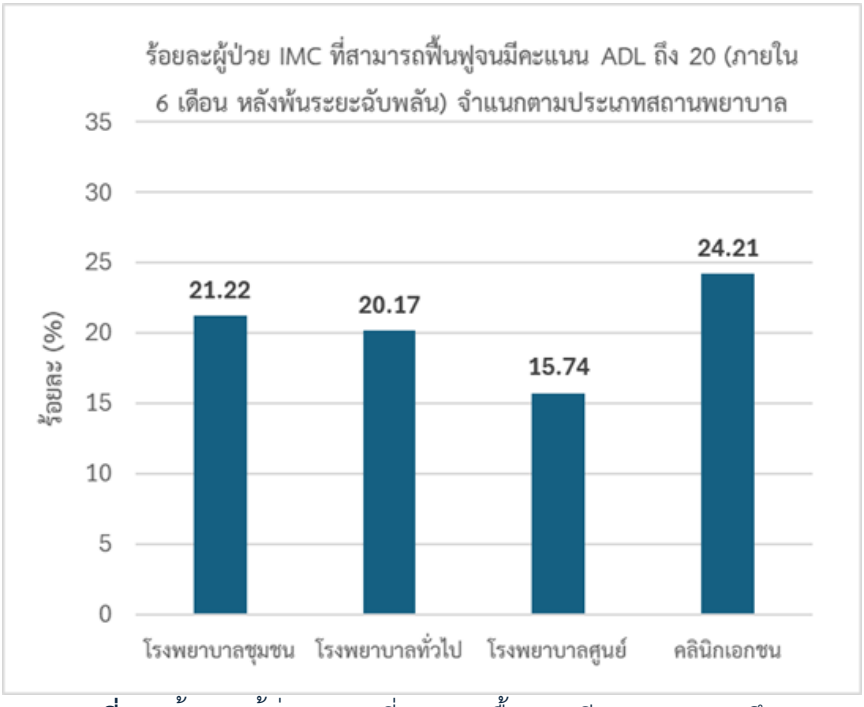
ภาพที่ 8 ร้อยละผู้ป่วย IMC ที่สามารถฟื้นฟูจนมีคะแนน ADL ถึง 20 (ภายใน 6 เดือน หลังพ้นระยะฉับพลัน) จำแนกตามเขตสุขภาพ

คลินิกเอกชนมีจำนวนครั้งเฉลี่ยต่อคนของการรับบริการ IMC สูงสุดในทุกกลุ่มโรค (20–23 ครั้งต่อคน) ขณะที่โรงพยาบาลทุกระดับมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 6–10 ครั้งต่อคน (รูปที่ 9) โดยกลุ่มโรคที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่นคือ ผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury) ซึ่งต้องการการฟื้นฟูต่อเนื่องมากกว่าโรคอื่น สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการให้บริการระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยคลินิกเอกชนอาจมีความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาในการให้บริการและสามารถให้บริการบ่อยครั้งในช่วงเวลาสั้น ซึ่งช่วยส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วย ขณะที่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปมีบทบาทหลักในการให้บริการระยะยาวในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ คลินิกเอกชนพบผลลัพธ์ผู้ที่ฟื้นฟูจน ADL เท่ากับ 20 คะแนน ในสัดส่วนสูงที่สุด (24.21%) รองลงมาคือ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ขณะที่โรงพยาบาลศูนย์มีร้อยละการฟื้นฟูต่ำสุดในทุกกลุ่มโรค (15.74%) (รูปที่ 10) สะท้อนว่าภาคเอกชนมีบทบาท

ในการเติมเต็มบริการดูแลระยะกลาง (IMC) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการฟื้นฟูดังกล่าวมีคุณภาพ จึงควรมีระบบการติดตามผลลัพธ์ทางคลินิก เช่น อัตราการเสียชีวิตหรืออัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำ (re-admission rate) ภายใน 1 ปี เป็นต้น



ภาพที่ 9 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเข้ารับบริการดูแลระยะกลาง จำแนกตามประเภทสถานพยาบาล จำแนกตามรายโรค



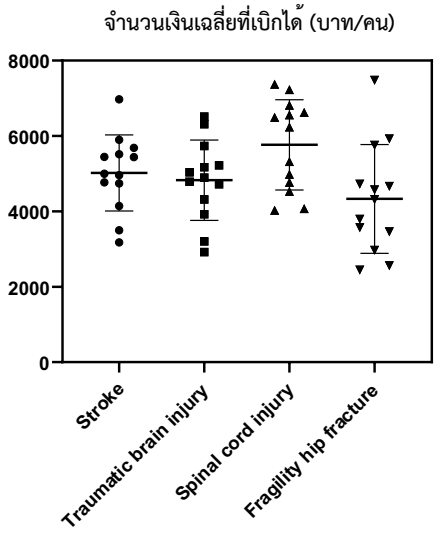
ภาพที่ 10 ร้อยละผู้ป่วย IMC ที่สามารถฟื้นฟูจนมีคะแนน ADL ถึง 20 (ภายใน 6 เดือน หลังพ้นระยะฉับพลัน) จำแนกตามประเภทสถานพยาบาล

ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนครั้งบริการ IMC ให้สอดคล้องกับความต้องการฟื้นฟูจริงของผู้ป่วย รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้การฟื้นฟูมีคุณภาพและต่อเนื่องมากขึ้น สามารถลดภาระต่อระบบดูแลระยะยาว (LTC) และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในระยะยาวได้อย่างแท้จริง

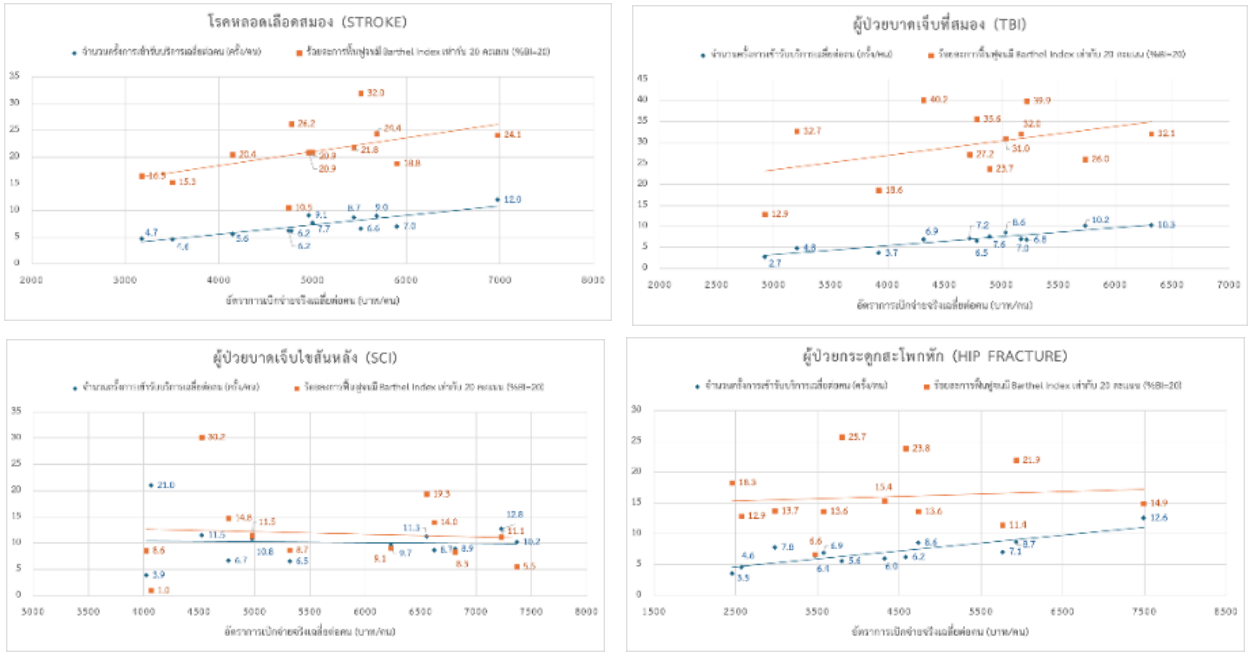
1.1.3 สถานการณ์ทางด้านการเงิน และอัตราการเบิกจ่ายของระบบดูแลระยะกลาง (IMC)

ผลการวิเคราะห์อัตราการเบิกจ่ายจริงของระบบการดูแลระยะกลาง (IMC) ในปีงบประมาณ 2567 พบว่างบประมาณที่มีการเบิกจ่ายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังได้รับบริการฟื้นฟูเฉลี่ย 11 ครั้งต่อคน มีอัตราการเบิกจ่ายอยู่ระหว่าง 4,000–7,300 บาทต่อคน ขณะที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับบริการเฉลี่ย 10 ครั้งต่อคน และมีอัตราการเบิกจ่าย 3,100–6,900 บาทต่อคน สำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง ได้รับบริการเฉลี่ย 9 ครั้งต่อคน มีอัตราการเบิกจ่าย 2,900–6,500 บาทต่อคน ส่วนผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักได้รับบริการฟื้นฟูเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ 8 ครั้งต่อคน แต่มีช่วงอัตราการเบิกจ่ายที่ค่อนข้างกว้าง อยู่ระหว่าง 2,400–7,400 บาทต่อคน (รูปที่ 11) ซึ่งถึงแม้จำนวนครั้งการรับบริการเฉลี่ยของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจะต่ำที่สุดในทั้ง 4 กลุ่มโรค แต่ยังถือว่ามีภาระค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องใช้สหสาขาวิชาชีพในการฟื้นฟูต่อเนื่อง

นอกจากนี้ พบว่าความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ซึ่งประเมินจากคะแนน Barthel Index (ADL) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการได้รับบริการดูแลระยะกลาง ขณะที่การได้รับบริการในจำนวนครั้งที่น้อยมีความสัมพันธ์กับคะแนน Barthel ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ (รูปที่ 12) สะท้อนว่าผู้ป่วยยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเพียงพอ

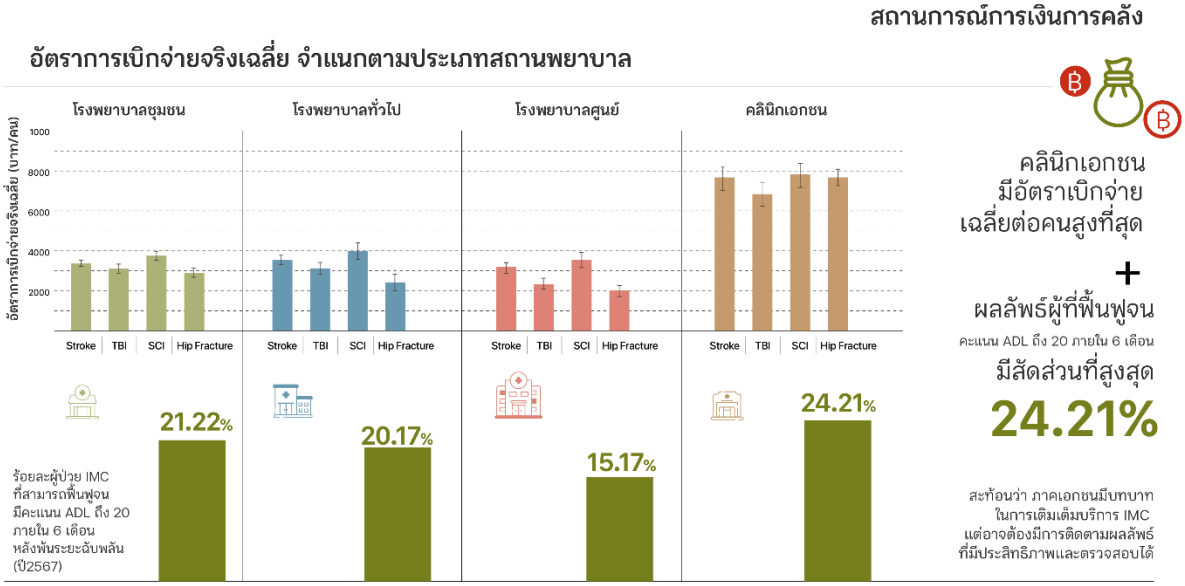


ภาพที่ 11 อัตราการเบิกจ่ายจริงเฉลี่ยต่อรายที่เข้ารับบริการ IMC ปี 2567 จำแนกตามรายโรค



ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการเบิกจ่ายจริงเฉลี่ย, จำนวนครั้งที่ได้รับการดูแลระยะกลาง และร้อยละการฟื้นฟูจนมี ADL ถึง 20 คะแนน จำแนกตามรายโรค

เมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายตามประเภทของสถานพยาบาล (รูปที่ 13) พบว่าโรคหลอดเลือดสมอง มีอัตราการเบิกจ่ายจริงเฉลี่ยสูงสุดที่คลินิกเอกชน จำนวน 7,509.54 บาท/คน และน้อยที่สุดที่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 3,185.09 บาท/คน การบาดเจ็บที่สมองมีอัตราการเบิกจ่ายจริงเฉลี่ยสูงสุดที่คลินิกเอกชน จำนวน 6,672.68 บาท/คน และน้อยที่สุดที่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 2,256.20 บาท/คน การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง มีอัตราการเบิกจ่ายจริงเฉลี่ยสูงสุดที่คลินิกเอกชน จำนวน 7,621.21 บาท/คน และน้อยที่สุดที่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 3,482.54 บาท/คน และ กระดูกสะโพกหัก มีอัตราการเบิกจ่ายจริงเฉลี่ยสูงสุดที่คลินิกเอกชน จำนวน 7,442.21 บาท/คน และน้อยที่สุดที่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 1,936.70 บาท/คน จากข้อมูลจะเห็นว่าคลินิกเอกชนมีอัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ยสูงกว่าสถานพยาบาลของรัฐทุกระดับในทุกกลุ่มโรค อยู่ระหว่าง 6,600–7,600 บาท/คน (เข้ารับบริการเฉลี่ย 20–23 ครั้ง/คน) ขณะที่โรงพยาบาลศูนย์มีอัตราเบิกจ่ายเฉลี่ยต่ำสุดระหว่าง 1,900–3,200 บาท/คน (เข้ารับบริการเฉลี่ย 5–9 ครั้ง/คน) โดยโรงพยาบาลศูนย์ได้รับการเบิกจ่ายในอัตราต่อครั้งของการรับบริการผู้ป่วยนอก (บาท/OPD visit) และยังไม่ครอบคลุมบริการ IMC แบบผู้ป่วยใน (IPD) ในขณะที่คลินิกเอกชนสามารถเบิกจ่ายตามจำนวนครั้งของการให้บริการจริง ทั้งในคลินิกและบริการฟื้นฟูเชิงรุกที่บ้าน ข้อมูลการเบิกจ่ายสอดคล้องกับผลลัพธ์ทางคลินิก โดยผู้ป่วยที่รับบริการจากคลินิกเอกชนพบผลลัพธ์ผู้ที่ฟื้นฟูจน BI=20 มีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 24.21) ขณะที่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์มีค่าเฉลี่ยที่ ร้อยละ 15.74-21.22 สะท้อนว่าภาคเอกชนมีบทบาทในการเติมเต็มบริการ IMC



ภาพที่ 13 อัตราการเบิกจ่ายจริงเฉลี่ยและร้อยละของผู้ป่วย IMC ที่สามารถฟื้นฟูจนมีคะแนน ADL ถึง 20 ภายใน 6 เดือนหลังพ้นระยะฉับพลัน จำแนกตามรายโรคและประเภทสถานพยาบาล

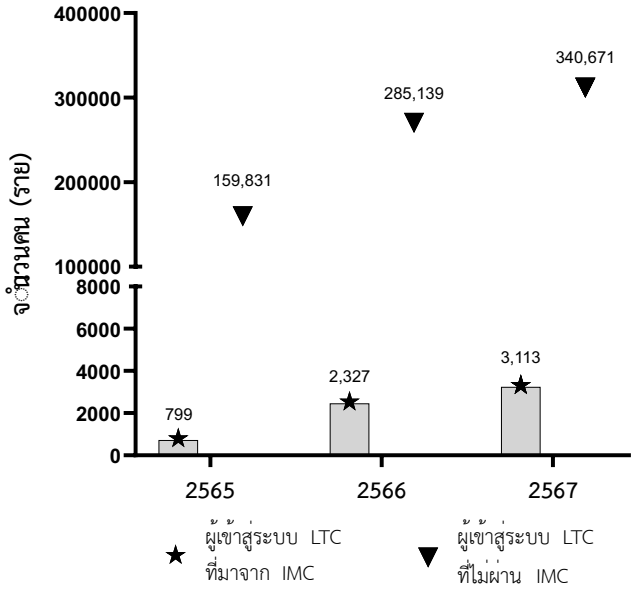
1.2 ระบบบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

1.2.1 ผลลัพธ์ด้านการดูแลระยะยาว (LTC)

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้ว ส่งผลให้ความต้องการบริการดูแลระยะยาว (Long-Term Care: LTC) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบ LTC จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ การสนับสนุนในการทำกิจวัตรประจำวัน และการสนับสนุนทางสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำกิจวัตรชีวิตประจำวันของผู้รับบริการอย่างยั่งยืน

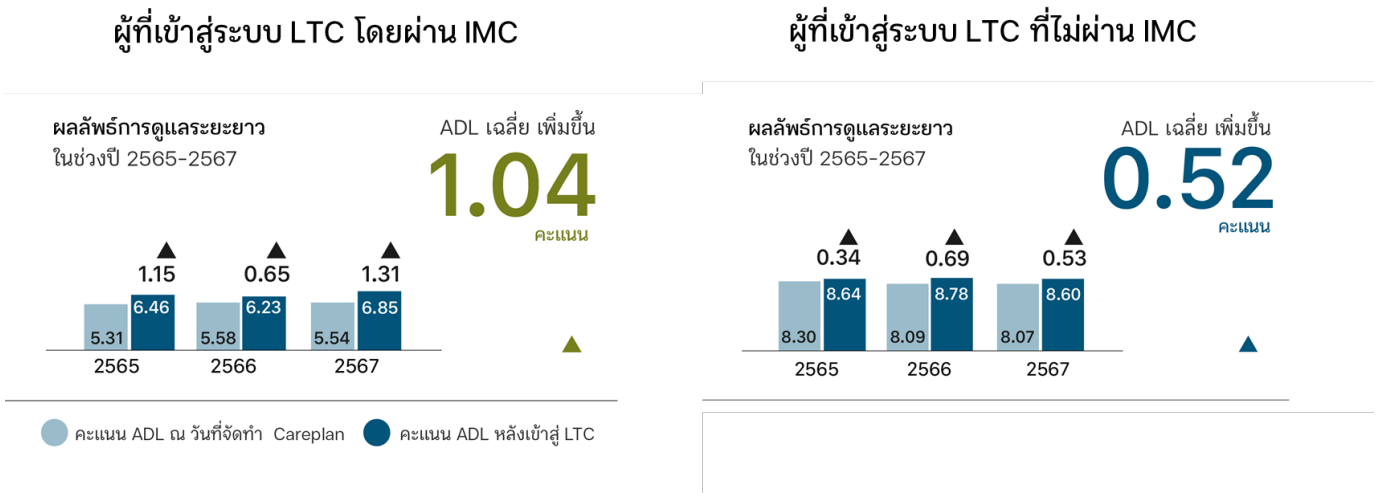
จากข้อมูลในระบบ LTC ปี 2565-2567 พบว่า จำนวนผู้ป่วย IMC ที่เข้าสู่ LTC มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า ในระยะเวลาเพียง 3 ปี (จาก 799 ราย ในปี 2565 เพิ่มเป็น 3,113 ราย ในปี 2567) ขณะเดียวกัน ผู้ป่วย LTC ใหม่ที่ไม่ได้ผ่าน IMC ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จาก 159,831 ราย (ปี 2565) เป็น 340,671 ราย (ปี 2567) สะท้อนถึงความต้องการบริการ LTC ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ภาระด้านบุคลากรและงบประมาณของระบบ LTC เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย (รูปที่ 14) และเมื่อพิจารณาจำนวนผู้ป่วยแยกรายโรคของ IMC ที่เข้าสู่บริการ LTC พบว่า จำนวนผู้ป่วยกลุ่ม Traumatic Brain Injury และกลุ่ม Spinal Cord Injury มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่มีจำนวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยกลุ่ม Stroke ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับผู้ป่วยกลุ่ม Fragility Hip Fracture ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกัน ซึ่งอาจสะท้อนถึงการขยายบริการ IMC ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีกระดูกหักจากภาวะเปราะบางมากขึ้น แนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มโรคเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด

(Super Aged Society) ซึ่งจะส่งผลให้ภาวะพึ่งพิงของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม อีกมุมมองหนึ่งคือ ระบบ IMC ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมสำคัญระหว่างการรักษาเฉียบพลันและการดูแลระยะยาว การลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายระบบ IMC รวมถึงการบูรณาการระบบส่งต่อผู้ป่วย และการพัฒนากระบวนการติดตามผลหลังการดูแล (Follow-up) อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลลัพธ์และปรับปรุงมาตรฐานแผนการดูแล (Care plan) จะช่วยลดภาระงานของระบบ LTC และสนับสนุนให้ผู้ป่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน



ภาพที่ 14 แสดงจำนวนผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ LTC ปีงบประมาณ 2565-2567

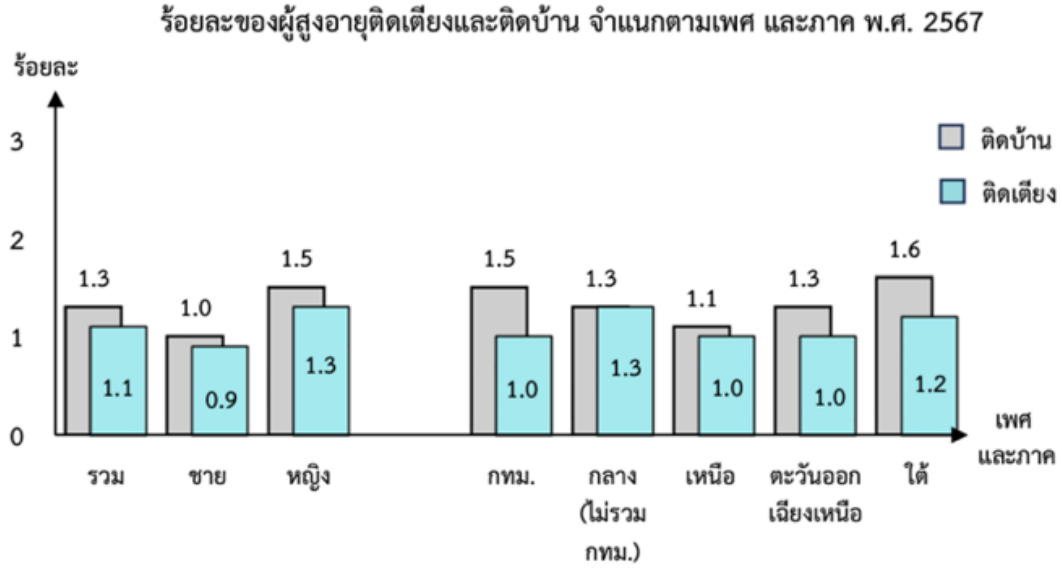
เมื่อพิจารณาคะแนน ADL เฉลี่ยของผู้ป่วย IMC ที่เข้าสู่ระบบ LTC ปี 2565–2567 พบว่า คะแนน ADL เฉลี่ย ณ วันที่จัดทำแผนการดูแล อยู่ระหว่าง 5.31–5.58 คะแนน และหลังการดูแลคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 6.23–6.85 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1.04 คะแนน ขณะที่คะแนน ADL เฉลี่ยของผู้ที่เข้าสู่ระบบ LTC ที่ไม่ผ่าน IMC มีค่าเพิ่มขึ้น 0.52 คะแนน ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เข้าสู่ระบบ LTC โดยผ่าน IMC มีการฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานในการทำกิจวัตรประจำวันได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ผ่าน IMC มาก่อน (รูปที่ 15) แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบ IMC จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถภาพและลดระดับการพึ่งพิงก่อนเข้าสู่ระบบ LTC แต่จากข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 14 พบว่าผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบ LTC โดยผ่าน IMC มีสัดส่วนค่อนข้างต่ำมาก คิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 1 ของผู้ที่เข้าสู่ระบบ LTC ทั้งหมด



ภาพที่ 15 แสดงคะแนน ADL เฉลี่ยของผู้ที่เข้าสู่ระบบ LTC ที่ผ่าน IMC (ซ้าย) และไม่ผ่าน IMC (ขวา)

1.2.2 สถานการณ์ทางด้านการเงิน และอัตราการเบิกจ่ายของระบบดูแลระยะยาว (LTC)

ข้อมูลในปี พ.ศ. 2567 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเท่ากับ ร้อยละ 2.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด (ประมาณ 333,650 ราย) แบ่งเป็นผู้สูงอายุติดบ้านร้อยละ 1.3 (182,350 ราย) และติดเตียงร้อยละ 1.1 (154,300 ราย) ตามลำดับ (รูปที่ 16)



ภาพที่ 16 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำแนกตามผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ในปี 2567[6]

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดอัตราเบิกจ่ายเฉลี่ยกองทุน LTC จำนวน 6,000 บาทต่อคนต่อปี (งบเพิ่มเติม 4,442 บาทต่อปี) รวมเป็น 10,442 บาทต่อคนต่อปี (เฉลี่ยไม่เกิน 870 บาทต่อเดือน) โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. เพื่อใช้ดำเนินงานดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงตามบริบทพื้นที่

ครอบคลุมค่าตอบแทนผู้ดูแล (CG) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง/ครุภัณฑ์ที่จำเป็นตามแผนการดูแล (Care Plan) และค่าใช้จ่ายการตรวจเยี่ยมโดย CM[48] อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการกองทุนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายจริงรายหมวดได้[49, 50] (รูปที่ 17) ทีมวิจัยจึงต้องประเมินงบประมาณจากเกณฑ์มาตรฐานของ สปสช.และกรมอนามัย โดยคำนวณจากจำนวนการใช้บริการตามมาตรฐานคูณราคากลาง



ภาพที่ 17 การจัดสรรงบประมาณกองทุน LTC สำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง (ปี 2567)

ผลการศึกษาความครอบคลุมและความเพียงพอของงบประมาณกองทุนการดูแลระยะยาว (Long-term Care: LTC) ของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเน้นการดูแลแบบบูรณาการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (patient-centered integrated care) (รูปที่ 18) พบว่า งบประมาณปัจจุบันยังไม่สามารถครอบคลุมความต้องการได้อย่างครบถ้วนทั้งในมิติด้านสุขภาพ ความต้องการด้านผู้ดูแลและบุคลากรสุขภาพ และความต้องการด้านสังคม

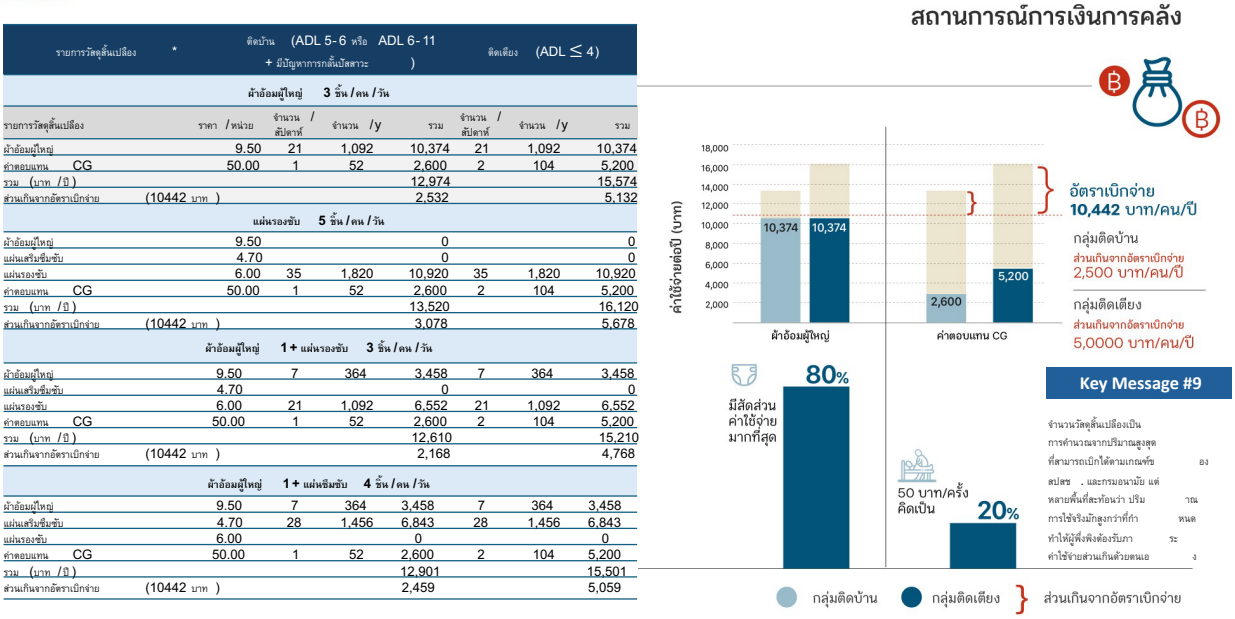
ในมิติด้านความต้องการด้านสุขภาพ (health care needs) งบประมาณกองทุน LTC ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ถูกใช้ไปกับค่าวัสดุสิ้นเปลือง โดยเฉพาะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งเป็นรายการหลักสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มติดบ้าน (ADL ≤ 4) รวมถึงผู้ที่มี ADL 5–6 หรือมากกว่า 6 ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[51] ผู้รับบริการมีการใช้ผ้าอ้อมเฉลี่ย 3 ชิ้นต่อวัน ในราคากลาง 9.5 บาทต่อชิ้น ส่งผลให้ค่าวัสดุสิ้นเปลืองรวมกับค่าตอบแทนผู้ดูแลอยู่ที่ประมาณ 13,000–15,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายของ สปสช. ประมาณ 3,000–6,000 บาท สะท้อนว่าภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนยังตกอยู่กับครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การแพทย์ และอาหารเสริมโภชนาการสำหรับผู้มีความต้องการ

เฉพาะ โดยการบริการนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงการจัดการภาวะใช้ยาหลายชนิด (polypharmacy) รวมถึงบริการสำหรับผู้มีปัญหาการได้ยิน การมองเห็น และโรคช่องปาก ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

ในมิติด้านความต้องการด้านผู้ดูแลและบุคลากร (care and workforce needs) ค่าตอบแทนผู้ให้บริการ LTC คิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลในอัตรา 50 บาทต่อชั่วโมง หรือในบางพื้นที่ใช้อัตราเหมาจ่ายเดือนละ 600–1,500 บาท[33] ซึ่งเมื่ออยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่จำกัด จะทำให้สัดส่วนค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นและลดสัดส่วนค่าวัสดุสิ้นเปลือง หากมีการปรับค่าตอบแทนผู้ดูแลเป็น 5,000–6,000 บาทต่อเดือนตามนโยบายการจ้างงานผู้ดูแล (CG) ปี 2568[52] ค่าใช้จ่ายรวมจะเพิ่มเป็นประมาณ 22,000–24,000 บาทต่อคนต่อปี สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายปัจจุบันถึง 12,000–14,000 บาท แม้จะเพิ่มต้นทุน แต่ช่วยเสริมแรงจูงใจ ความมั่นคง และความต่อเนื่องในการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง อย่างไรก็ตาม งบประมาณสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของผู้จัดการดูแล (Care Manager: CM) ยังอยู่ในระดับต่ำมาก บางพื้นที่ไม่มีงบรองรับ หรือเบิกได้เพียงปีละประมาณ 100 บาทต่อคน ซึ่งไม่ครอบคลุมค่าเดินทาง อีกทั้งยังไม่มีงบประมาณสำหรับการตรวจเยี่ยมและดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ นักกายภาพบำบัด และเภสัชกร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางการแพทย์

ในมิติด้านความต้องการด้านสังคม (social care and support needs) ระบบ LTC ของประเทศไทยครอบคลุมรูปแบบการดูแลในชุมชน ได้แก่ การดูแลที่บ้าน (home care) และศูนย์ดูแลกลางวัน (day care) แต่ยังไม่ครอบคลุมการสนับสนุนด้านการเดินทางเพื่อเข้ารับบริการสุขภาพ และยังขาดทางเลือกการดูแลแบบสถาบัน (institutional LTC) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและความซับซ้อนสูง ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนต้องพึ่งพาการดูแลจากภาคเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายสูง เกิดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึง ความต่อเนื่อง และคุณภาพของการดูแล

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า โครงสร้างงบประมาณปัจจุบันสะท้อนว่าค่าวัสดุสิ้นเปลืองเป็นภาระหลักของระบบ LTC และวงเงินที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการตามกรอบของ WHO จึงมีข้อเสนอให้พัฒนาระบบจัดซื้อรวมในระดับประเทศ เขต หรือจังหวัด เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองราคา เปิดทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ลดภาระของครัวเรือน และเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว



ภาพที่ 18 ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายต่อปีและความครอบคลุมด้านการบริการ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาว (LTC)

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลลักษณะผู้ให้ข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลมาจากพื้นที่วิจัย 3 จังหวัด (นนทบุรี อำนาจเจริญ และสงขลา) ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- **ผู้เกี่ยวข้องภายใน (internal stakeholder)** เช่น ผู้กำหนดนโยบาย/ผู้บริหารจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- **ผู้เกี่ยวข้องภายนอก (external stakeholder)** เช่น ผู้ดูแล (caregiver) ผู้จัดการการดูแลระยะยาว (care manager) และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ 6 แสดงผู้ให้ข้อมูล (key informant)

ลำดับ	พื้นที่วิจัย	จำนวนผู้ให้ข้อมูลโดยรวม (คน)	กลุ่มที่ 1 (คน)	กลุ่มที่ 2 (คน)	กลุ่มที่ 3 (คน)	กลุ่มที่ 4 (คน)
จังหวัดอำนาจเจริญ						
1	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	8	1	3	1	3
2	เทศบาลตำบลนายม	13	2	3	2	6
จังหวัดนนทบุรี						

ลำดับ	พื้นที่วิจัย	จำนวนผู้ให้ข้อมูลโดยรวม (คน)	กลุ่มที่ 1 (คน)	กลุ่มที่ 2 (คน)	กลุ่มที่ 3 (คน)	กลุ่มที่ 4 (คน)
1	เทศบาลเมืองพิมลราช	6	3	1	1	1
2	โรงพยาบาลพิมลราช	5	1	1	2	1
3	เทศบาลตำบลบางสีทอง	2	2	-	-	-
จังหวัดสงขลา						
1	เทศบาลตำบลเขารูปช้าง	7	2	2	2	1
รวม		**41**	**11**	**8**	**10**	**12**

หมายเหตุ กลุ่มที่ 1 คือ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกองทุนสำนักงานประกันสุขภาพพื้นที่ กลุ่มที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มที่ 3 คือ care manager กลุ่มที่ 4 คือ caregiver

ตารางที่ 7 การให้รหัสสำหรับผู้ให้ข้อมูล

ลำดับที่	ผู้แทนหน่วยงาน	รหัส
ผู้กำหนดนโยบายจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
1	เทศบาล A1 จังหวัด A	PC#1
2	เทศบาล B1 จังหวัด B	PC#2
3	เทศบาล A2 จังหวัด A	PC#3
4	องค์การบริหารส่วนตำบล B2 จังหวัด B	PC#4
Care manager		
5	บุคลากร CM จากโรงพยาบาล จังหวัด B	CH#1
6	บุคลากร CM จากโรงพยาบาล จังหวัด A	CH#2
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Intermediate care (IMC)		
7	บุคลากร IMC จากโรงพยาบาล จังหวัด B	FC#1
8	บุคลากร IMC จากโรงพยาบาล จังหวัด A	FC#2
เจ้าหน้าที่การเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบ LTC		
9	เจ้าหน้าที่การเงินจาก เทศบาลจังหวัด A	FO#1
10	เจ้าหน้าที่การเงินจาก เทศบาลจังหวัด B	FO#2
11	เจ้าหน้าที่การเงินจาก อบต. จังหวัด B	FO#3

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสามารถจัดจำแนกออกเป็น 4 ประเด็นหลัก 7 ประเด็นย่อย ดังนี้

1. ประสบการณ์ในการพัฒนากลไกทางการเงิน และรูปแบบการเบิกจ่ายในระยะแรกของระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว

ระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในไทยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดย Japan International Cooperation Agency (JICA) ผ่านโครงการนำร่องบริการสุขภาพ–สวัสดิการชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2551–2552/วาระ 2551–2555) ในจังหวัดต้นแบบ 4 จังหวัด ผลการศึกษาชี้ว่าจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากรัฐอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าการดูแลในครอบครัว จึงต่อยอดเป็นโครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงและกลุ่มอื่นที่ต้องการช่วยเหลือ เพิ่มพื้นที่นครราชสีมาและกรุงเทพฯ (วาระ 2556–2560)[26, 53] ต่อมาโครงการนำร่องได้ขยายสู่ระบบการดูแลระยะกลาง (IMC) สำหรับผู้ป่วยเฉียบพลัน โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฟื้นฟูฯ[54] ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่าช่วงเริ่มต้นทั้งสองโครงการยังขาดรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณและแนวทางการเบิกจ่ายที่ชัดเจน

หลังจัดวางโครงสร้างระบบดูแลระยะยาวช่วงปี 2559–2561 และประกาศนโยบาย LTC พบความไม่มั่นใจในการดำเนินงานและบริหารงบประมาณในพื้นที่ เจ้าหน้าที่การเงินมองว่าเป็นเรื่องใหม่ ขาดประสบการณ์ และกังวลว่าจะปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบการเงิน เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างการใช้งบประมาณสำหรับดูแลผู้สูงอายุกับระเบียบการเงินที่มีอยู่ของสถานพยาบาลแต่ละแห่งตั้งแต่เดิม บางพื้นที่มีเงินคงค้างภายในกองทุนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เพราะระเบียบการเงินของสถานพยาบาล เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาล ไม่สอดคล้องกับระเบียบ สปสช. ทำให้เกิดช่องว่างการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (PC#01 PC#03)

“คือในส่วนของท่านนายกเนี่ย จริงๆ แล้วอ่ะ พมจ. ที่ส่งงบประมาณมา 2-3 ปี แล้วก็ค่าตอบแทนเพียงแค่ 300 บาท ที่ให้กับอาสาสมัครเนี่ย ผมว่าจริงๆ แล้วมันก็ไม่พอด้วยแล้วที่เข้ามาปฏิบัติงานกับเรา จริงๆ แล้วท่านนายกท่านให้ความสำคัญ ท่านยังใช้งบเทศบาลต่อให้อีกปีกว่าๆ ในช่วงรอยต่อเนี่ย สตง. เข้าตรวจ แล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่บทบาทหน้าที่ ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเทศบาล เทศบาลขอเรียกเงินคืนเนี่ยเป็นปัญหาอุปสรรคที่แบบโครงการดีๆ ที่ทำมาดีแล้ว แต่ว่ามาติดในเรื่องของกฎระเบียบที่ทางส่วนกลางเขาออกมาก็เลยหยุดเพราะว่าโดนทักท้วง...”PC#01

“...LTC เรามีปัญหาในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าเราเป็นพื้นที่นำร่องนะคะตั้งแต่ปี 2559 พอหลักเกณฑ์ในการใช้เงินไม่ชัดเจนเนี่ย ผลก็คือเราไม่ได้มีการเบิกใช้จ่ายงบประมาณนะคะ แล้วก็มีการเอากลับมาที่เดิม แล้วก็คืนกลับไป ดำเนินการไปสักระยะหนึ่ง ด้วยเรื่องว่ามันมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในระยะเวลาที่ทำงานค่ะ พอปรับเปลี่ยนมาอีกขั้นนึงก็อาจจะต้องมีต้องใช้เวลาในเวลาในการที่จะศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดหลักเกณฑ์อีก ตรงนี้อาจจะมีผลในเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะทำให้ต่อเนื่องได้อะค่ะ...” PC#03

ปี 2561 สปสช. ออกประกาศเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นด้านการบริหารการเงิน ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ พ.ศ. 2561[55] มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อบริหารกองทุนระดับท้องถิ่นจากงบ สปสช. เงินสมทบ และค่าบริการดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) และโครงการที่เกี่ยวข้อง[55] และได้มีการปรับปรุงเนื้อหามาอย่างต่อเนื่องจนถึงประกาศฉบับล่าสุดในปี 2568 ที่ได้ครอบคลุมถึงกลไกทางการเงินและการบริหารจัดสรรงบประมาณระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [50]

ในด้านกำลังคนทางสุขภาพในระบบการดูแลระยะยาว ประกอบด้วย ผู้ดูแล(Care giver) และผู้จัดการการดูแลระยะยาว (Care manager) ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ภายใต้กระทรวงมหาดไทย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562)[56]

2. ปัจจัยสนับสนุน

2.1 ภาวะผู้นำและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น

ภาวะผู้นำและความร่วมมือระดับท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายดูแลระยะยาวซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วนได้แก่ จังหวัด อปท. ชุมชน และหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิซึ่งต้องช่วยกันออกแบบแนวทางและแผนการดูแลระยะยาวที่ครอบคลุมการดูแลทั้งด้านกายภาพบำบัด ทันตกรรม และโรคทางอายุรกรรมเพื่อให้เกิดการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างครอบคลุม

2.2 กลไกจิตอาสา

กลไกจิตอาสาเป็นกลไกที่ช่วยให้ระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และในบางพื้นที่ยังเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนให้สามารถดำเนินงานได้จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าผู้ดูแล (CG) จะได้รับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยแต่มองว่าเป็นงานที่ช่วยเหลือสังคม ซึ่งแม้ว่ากลไกจิตอาสานั้นจะเป็นกลไกสนับสนุนที่อาจจะช่วยลดต้นทุนของระบบบริการ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยลดการพึ่งพากลไกจิตอาสาเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ (PC#01 PC#03)

"...เงินส่วนตัวเลย (เงินที่มา support จิตอาสา) นอกจากมีวัสดุอุปกรณ์ ผู้สูงอายุที่มีฐานะหน่อยมาใช้บริการกับเรา อุปกรณ์ยังขาด เขาก็เห็นที่อื่นมาแล้ว เขาก็สนับสนุนซื้ออุปกรณ์ให้ อาสาสมัครของเรามีฐานะหน่อย อันนี้ขาดก็ซื้อให้ คือตัวระบบผมว่ามันติดมาตั้งแต่โควิด ตอนโควิดเนี่ย มันมีการหยุดชะงักไป 2 3 ปี แต่ว่าตัวจิตอาสายังเหมือนเดิมไหม ทำงานเหมือนเดิม จิตอาสาเหมือนเดิม ตัวอาสาตัวทีมของฝ่ายบริหารยัง support เหมือนเดิม แต่ว่าตัวของผู้มารับบริการคนใจบุญฐานะน่าจะถดถอย ในการที่จะบริจาค support มีปริมาณน้อยลง มีจำนวนน้อย เขาเคยซื้อข้าวมาให้ซื้อน้ำมันอะไรให้เนี่ย support แบบเนี่ยเราสังเกตได้ว่ามันมันน้อยลง มันเลยทำให้ระบบบางระบบที่จริงๆ แล้วมันมีความจำเป็น รัฐควรสนับสนุนได้ด้วยแล้ว จริงๆ รัฐควรสนับสนุนให้ได้แล้ว ควรที่จะทำได้โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...กระบวนการจิตอาสา ถ้าสามารถปรับไปเป็นแบบยั่งยืนด้วยเนอะ ปรับไปมีค่าตอบแทนพอสมควรให้กับคนที่ทำงานแบบไม่ยากเกินไป ผมว่าแบบนี้มันจะยั่งยืน และก็สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่...." PC#01

"...จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือ จิตอาสาค่ะ care giver ซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆ ที่ไม่ได้มีเหมือนเรานะคะ care giver ที่เราเจอกันเมื่อเช้า นักบริบาล หรือแม้แต่ อสม ที่อยู่ในบริบทในการทำงานของสาธารณสุขของเราค่ะ เค้ามีความเป็นจิตอาสาจริงๆ ค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องให้เขามาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการดูแลประชาชนในพื้นที่เนี่ย เราจะ

ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมนะคะ อย่างที่บอกค่ะ มันมีน้อยมากที่การทำงานแล้วไม่ได้ค่าตอบแทน แถมบางทียังต้องใช้จ่ายงบประมาณส่วนตัวด้วย ในเรื่องของการเดินทางค่าน้ำมัน หรือแม้แต่ค่าของหิ้วไปเยี่ยมประชาชนด้วยซ้ำ หลายๆ ครั้งนะคะ มันหาได้ยากมาก ซึ่งเรามองว่ามันเป็นจุดแข็งอีกจุดนึงที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นะคะ"PC#03

3. ปัญหาและอุปสรรค

3.1 ปัญหารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยใน

การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยในยังเป็นประเด็นท้าทายที่สำคัญ หลายพื้นที่มีการดูแลระยะกลางโดยจัดให้มีหอผู้ป่วยระยะกลางหรือจัดให้มีเตียงสำหรับการดูแลระยะกลาง แต่พื้นที่สะท้อนว่าการเบิกจ่ายยังเป็นปัญหาอุปสรรค เนื่องจากระบบยังไม่ได้แยกการจ่าย DRG สำหรับการดูแลระยะกลางโดยเฉพาะ การเบิกจ่ายในปัจจุบันจึงเบิกได้เป็น DRG สำหรับการดูแลระยะเฉียบพลัน ซึ่งหากมีวันนอนยาวจะทำให้ต้นทุนการให้บริการสูงกว่าการเบิกจ่ายได้จริง ประเด็นนี้จึงทำให้การดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยในได้รับผลกระทบจากทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อความสามารถในการจัดบริการ และ การสร้างแรงจูงใจของสถานพยาบาลที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม นอกจากนี้ ชุดสิทธิประโยชน์กำหนดให้สามารถเบิกจ่ายสำหรับการดูแลระยะกลางได้ 4 กลุ่มโรค ซึ่งยังมีผู้ป่วยบางกลุ่มนอกเหนือจาก 4 กลุ่มโรคที่อาจจะได้ประโยชน์จากการดูแลระยะกลางเช่นเดียวกัน เช่น กลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บทางสันหลังร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายประเภท (Spinal cord injury with multiple factor) เป็นต้น (FC#1)

"คือถ้ามองว่าปรับในส่วนเคสที่จำเป็นต้องฟื้นฟูต่อเนื่องบางทีโรคอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเหมือน spinal cord หรือว่าเป็น fracture แค่ hip อะไรอย่างงี้ แต่บางที fracture ส่วนอื่นๆ ที่เขาต้องเป็น multiple factor ทั้งหลายที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คือมันจะมีคนไข้บางกลุ่มอ่ะค่ะ เช่น กลุ่ม spinal cord บางที 6 เดือนยังไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ เขาพึ่งกลับมาสภาวะปกติ มันก็เป็นช่วงประคับประคอง แต่การที่จะเริ่มฝึกบางทีมันเริ่มที่เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 แล้ว มันก็จะต้องเทรนกำลังกล้ามเนื้อ กลุ่มที่พบปัญหาคือ กลุ่ม spinal cord แต่กลุ่ม fracture hip กลุ่มอะไรอย่างงี้บางทีมัน discharge ได้เร็วบางทีเราก็จบก่อน 6 เดือนก็มีค่ะ ใช่ บางทีเดือน 2 เดือนกลุ่มนี้เราก็จบก่อน คือมองว่ามันควรขยายเวลาได้" FC#1

"อุปกรณ์ คือตอนนี้เราก็จะไม่มีอุปกรณ์นะคะ เข้มข้นในเชิงของเราในตอนนี้ของเรา intensive เข้มข้นของเรา คือจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการฝึก แล้วเราก็จะมีนักกายภาพที่รับผิดชอบ IMC เลย เครื่องมือที่ทันสมัยก็จะมีเฉพาะเครื่อง PMS ค่ะ แต่อุปกรณ์อื่น เช่น โรบอท เรายังไม่มีค่ะ แต่เราจะใช้เวลา (ที่เพิ่มขึ้น) ให้การฝึก 1 เคส เพราะว่าจะเน้นการฝึกที่ intensive โปรแกรมจากการฝึกร่างกายของเขา เราขาดเรื่องเครื่องมืออยู่ค่ะ ส่วนมากบางทีมันเป็นเคสที่เราออกเยี่ยมบ้านด้วย" FC#1

"...(ก็เหมือนกับตอนนี้ก็คือ IMC Palliative ก็จะรวมอยู่ใน IPD ในการดูแล) ใช่ จะมีน้องที่ดูมาก่อนตั้งแต่ตอนเปิด IMC ก็จะมาดูตรงนี้ต่อ แต่ว่าไม่ได้แยกว่าเป็นวอร์ด IMC เลย มีเตียงประมาณ 3-4 เตียง มันยังไม่มีพยาบาลมาที่จะแบ่งมาให้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่นี่มีแค่ประมาณ 20 กว่าคนเองนะ เพราะแยก IPD OPD ER และงานเวช หมดแล้วค่ะ น้องคนอื่นต้องอยู่เวร ก็จะเยอะหน่อย เลยคิดว่าควรเพิ่มคน..." CH#02

3.2 ปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณการดูแลระยะยาว

แม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาระหว่างปี พ.ศ. 2567 – 2568 จะมีการเพิ่มเงินสนับสนุนต่อประชากรรายหัว จาก 6,000 บาท เป็น 10,442 บาท/คน/ปี[22, 53] ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของงบประมาณที่จัดสรรรายบุคคล

อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ได้มีการกล่าวถึงกลไกการเงินการคลังระดับท้องถิ่นภายหลังจากได้งบประมาณ สปสช. ว่ายังขาดแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินที่มีความคล่องตัว จึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงบประมาณจากกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นทางช่องทางหลักคือการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมมือกับคณะอนุกรรมการกองทุนผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อให้ง่ายต่อการออกระเบียบการบริหารจัดการเงินประจำศูนย์ฯ และได้มีข้อเสนอว่ายังต้องการให้หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น สปสช. พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการสนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องทางนโยบายตลอดระบบบริการ (FO#01 PC#01)

“...ตอนที่เจอปี 2562 ก็คือติดปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินนะคะ ไม่ค่อยมีตัวอย่างการเบิกจ่ายเงินที่เป็นค่าตอบแทน เพราะว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบ ไม่มีคำแนะนำให้ที่ชัดเจน หรือว่าไม่มีรูปแบบ ทีนี้ถามว่าตอนนั้นถ้าสิ่งที่เจ้าหน้าที่อยากได้คืออะไร เค้าบอกว่า ถ้าสมมติว่าทำออกมาเลยว่า เนี่ยเขียนโครงการลักษณะเนี้ย ร่างเป็นตัวอย่างโครงการออกมา เรามั่นใจว่าถูกต้องเนี่ย เค้าบอกว่าถ้า สปสช ทำแบบนี้ให้เค้าแล้วเค้ามั่นใจว่ามันจะสามารถไปต่อแบบที่ไม่ผิดเค้าจะกล้าทำเพราะอย่างน้อยก็คือไม่ต้องไปคิดรูปแบบเอง ก่อนหน้าเนี้ยถามว่าที่พิมลราชทำแบบบันทึกการดูแลมานั่นก็ออกแบบเองนะคะ ออกแบบมาจากต้นแบบเลย JICA นั่นแหละค่ะ เราเอามาทำแล้วเราก็เลยพยายามกระจายให้ที่อื่นๆ ว่าลองทำแบบนี้สิ คุณอาจจะบันทึกการดูแลได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนกับต้องออกแบบเอง แล้วทีนี้เค้าบอกว่าถ้าจะให้ทำถ้ามันมีมาแบบสำเร็จรูป คนจะกล้าลงมือทำมากขึ้นค่ะ เหมือนกับหลังๆ ที่เห็นคู่มือการดำเนินงาน เค้าก็จะเริ่มมีตัวอย่างมีตัวอย่างเข้ามาในแบบภาคผนวก ข. ค. อะไรอย่างเงี้ย พอมันเห็นตัวอย่ามันจะกล้าทำมากขึ้น...” FO#01

พอแบบทะลวงไปก่อนนำร่องไปก่อนแล้วมาโดนตรวจสอบแล้วก็ต้องมาตรวจกันทีหลังเนี่ย มันทำให้เรายุ่งยากจุกจิกจากที่เราจะทำงานก้าวต่อไปเนี่ยเลยมองว่าให้ระบบมันนิ่งก่อน ระบบนิ่งแปลว่าเบิกจ่ายได้แล้วมันชัดเจนแล้ว ระเบียบมันชัดเจนแล้วทำเลย แต่อะไรที่แบบยังไม่มั่นใจ ระเบียบยังก้ำกึ่งว่าทำได้ทำไม่ได้ เราจะคิดก่อน ไม่ใช่ว่าไม่ทำ แต่คิดก่อน ถามตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นก่อนว่ามันทำได้จริงหรือเปล่า แล้วการทำได้จริง คือทำแล้ว สตง. ลงไปตรวจหรือยัง ถ้าทำแล้ว สตง. ลงไปตรวจแล้วเนี่ย เดี๋ยวหยิบยก (ตัวอย่าง) มาทำเลย” PC#01

สำหรับกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง กลุ่ม 3 และ 4 ซึ่งมักได้รับผลจากปัญหาทางสุขภาพที่มีความรุนแรงอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพ เช่น โรคมะเร็ง หรือภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ การคำนวณงบประมาณสนับสนุนในอัตราปัจจุบันจึงไม่ครอบคลุมต้นทุนที่แท้จริงของโรคดังกล่าว โดยได้มีการสะท้อนถึงปัญหาว่า มีเงินไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กลุ่มนี้มักมีการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปในปริมาณที่มากกว่าปกติ เงินที่ได้จึงไม่พอจะสนับสนุนค่าผ้าอ้อมได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งงบประมาณที่มียังไม่ครอบคลุมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น ซึ่งในบางพื้นที่อาจแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการหมุนเวียนครุภัณฑ์จากหน่วยบริการปฐมภูมิมาใช้

“...(ทรัพยากร)อันที่ไม่พอ อันที่ไม่พอเนาะเหมือนวัสดุการแพทย์ที่ไม่พอ เช่นมันจะมีเป็นบางช่วงอ่ะค่ะที่มีผู้ติดเตียงที่แบบแผลกดทับอะไรที่แบบเยอะ ๆ เราไม่ได้ตั้งแผนไว้ ทีแรกเราตั้งไว้ไม่เยอะ แต่พอมาจริง ๆ อะคือแผลมันเริ่มเยอะ เราก็ใช้ของ รพ.สต. อันนี้คือค่อนข้างเยอะ บางคนนะเกินค่าหัว (หัวเราะ) เหมือนเคสที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นมะเร็งที่ทวารหนัก อันนี้คือถ่ายตลอดเวลา น่าจะเลยเป็นสักเกือบสองหมื่นแล้วเคสนี้

คือเขาใช้ของ ของ รพ.สต. เนื่องจากเราไม่ได้ตั้งงบไว้ มันไม่พอ อาจจะติดอยู่ที่การปรับเปลี่ยน care plan อาจจะยังไม่ครอบคลุม...” FO#02

“(งบครุภัณฑ์) อันนี้ก็ยังไม่มีของ รพสต. ก็จะมีของ อสม. เพราะว่าเราจะขอทำโครงการ หรือว่าของบก็คือเราจะซื้อพวกเครื่องวัดความดันให้ อสม. ในแต่ละหมู่บ้าน อันนี้คือเขาก็สามารถ(ยืม)นำไปใช้ได้ เพราะว่าส่วนใหญ่ CG เราเป็น อสม.” CH#01

“...เรายังไม่ได้วางแผนเรื่องของครุภัณฑ์ที่มันเสื่อมสภาพคือซ่อม การนำกลับมาใช้ใหม่คือ สมมุติว่ารถเข็นที่มันมันชำรุดครับ คือก็จะเอากลับไปเก็บที่ รพ.สต. แต่อาจจะมีบ้าง คนแบบสามารถซ่อมได้ แต่มันก็ไม่ได้มีแบบว่างบประมาณสนับสนุนไว้ชัดเจน สองคือเราทำงานรูปแบบศูนย์อยู่แต่ แต่มันไม่มีที่ตั้ง เราจะตั้งที่ทำการไว้ที่ รพ.สต. แต่มันจะไม่เป็นเหมือนสัดส่วน คือในภาพฝัน เราอยากจะมีแบบว่ามีสำนักงาน เป็นที่ปฏิบัติงานของ CG และเป็นที่เป็นศูนย์ยืมคืนวัสดุอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะ...” FO#02

3.3 ปัญหาค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการดูแลระยะยาว

เจ้าหน้าที่การเงินในทุกพื้นที่ได้มีการระบุถึงข้อจำกัดในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ดูแล (CG) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากสปสช. โดยได้ให้ข้อมูลว่า โดยปกติ CG จะได้รับค่าตอบแทนจากการดูแลผู้ป่วยรายเคส แตกต่างกับอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง และอบรมเพิ่มเติมอีก 50 ชั่วโมงรวมเป็น 120 ชั่วโมง ได้รับเงินเดือน 5,000 บาท และ 6,000 บาท ตามลำดับ[22] ค่าตอบแทน CG คิดตามความถี่การเยี่ยมที่ขึ้นกับความรุนแรงของเคส โดยกลุ่ม 3–4 เยี่ยมมากกว่า (8 ครั้ง/เดือน) จึงได้สูงกว่ากลุ่ม 1–2 (2 และ 4 ครั้ง/เดือน) แต่กลุ่ม 3–4 มีจำนวนน้อยและเสี่ยงเสียชีวิต ทำให้บางกรณีเบิกงบไม่ได้ ต้องถัวเฉลี่ยจากงบคงเหลือ อีกทั้งการเพิ่มเคสเพื่อเพิ่มรายได้ไม่เหมาะเพราะลดประสิทธิภาพการทำงานลง โดยรวมทุกพื้นที่พบว่า CG มีแนวโน้มได้ค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าการทำงานทั่วไป (ทั้งในรูปแบบเหมาจ่ายต่อเดือน และ คำนวณในอัตราต่อชั่วโมง) จึงควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนและสนับสนุนต้นทุนแฝง เช่น ค่าเดินทาง (*CH#01 PC#04 FO#03*)

“บางปีเราก็จะไม่ของบเพิ่มเราก็จะใช้งบเดิม เพราะว่าถ้ามันมาถัวเฉลี่ยงบที่ได้มา ก็คือมันไม่สามารถที่จะใช้หมด ก็คือค่าตอบแทนที่เราเบิกจ่ายก็แค่ 50 บาทต่อชั่วโมง แต่ละเคสก็ไม่เยอะ กลุ่ม 3 ก็ไม่เยอะ ทีนี้ถ้าคนไข้เสียชีวิตไปก็เคสหดแทน เคสหดแทนเราอาจจะหากลุ่ม 3 มาไม่ได้ เราอาจจะได้กลุ่ม 2 กับกลุ่ม 1 ทีนี้งบประมาณในการเบิกจ่ายมันก็จะน้อยลง” CH#01

“ถ้าจะปรับ (แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน CG) มันก็ต้องมาคุยในคณะกรรมการดำเนินการว่ารูปแบบจะเบิกจ่าย ยังไง เห็นที่อื่นเขาก็จะเบิกจ่ายเป็นรายเดือนใช่ไหมคะ เขาจะให้เป็นเหมือนเงินเดือน เป็นรายคาบ แต่ก็เหมือนมันมีข้อจำกัดที่ว่าส่วนใหญ่ CG เราก็เป็น อสม. แล้วก็มีบางคนก็เป็น สท. อะไรอย่างงี้ค่ะ ก็คือมันไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายให้เดือนละ 5,000 เหมือนนักบริบาลได้ เหมือนอย่างที่ ผอ.ว่า ก็เลยต้องตามรายเคส เราก็ต้องแก้ปัญหาอย่างนี้ไปก่อน ก็นอกจากว่าก็ต้อง ถ้าอยากได้ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เราก็ต้องหาเคสเข้ามาดูแลเพิ่มขึ้น” CH#01

"...ถ้าเป็นค่าตอบแทนที่ไม่ใช่รายกิจกรรมจะมีระเบียบรองรับจริงๆ ให้มันชัดเจนโดยไม่ต้องให้เราคลอดเองกำหนดเองเนี่ย อย่างเช่นว่าเค้าจ่ายให้เราเหมาจ่ายเลยอย่างน้อย 6,000 บาทเหมือนเงิน (ค่าตอบแทน) บริบาลน่าจะดีครับ ผมอยากให้เค้า (สปสช.) กำหนดให้เราได้เลยไหมว่าจ่ายเป็นรายเดือนได้เลย อย่างน้อย 6,000 บาท 7,000 บาท แล้วแต่ อาจจะกำหนดเป็นตอนนี้ ดูแลอยู่กี่รายแล้วก็ค่าตอบแทนเท่านี้ ตามความรับผิดชอบ ทำเป็นตารางเป็น list มาให้น่าจะดีมากกว่านี้ อันนี้เค้าให้เริ่มกำหนดเอง เราก็ไม่รู้ เราจะกำหนดเท่าไหร่ดี มันถึงจะเหมาะสม ผมว่า(แนวทางการคำนวณค่าตอบแทน) น่าจะขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในปัจจุบันนี้เลย เพราะว่าเงินเดือนนึงแค่นี้ เอาจริงๆ แต่ละคนมันไม่พอใช้อยู่แล้ว ถ้าเขาได้เพิ่มมาอีกสักนิดนึง มันก็จะเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเค้า ถ้าเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึง ผมว่าเค้าก็คงจะดีใจพอสมควรนะครับ" PC#04 FO#03

3.4 ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์: การไม่คงอยู่ของผู้ดูแล (CG) ในระบบและอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอ

ปัญหาทรัพยากรบุคคลปฐมภูมิยังแก้ไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากค่าตอบแทน CG ต่ำ ทำให้กำลังคนไม่พอและ CG อยู่ในระบบไม่นาน หลายคนย้ายไปเอกชน ลาออก หรือมาอบรมเพื่อดูแลครอบครัวแล้วออก อีกทั้ง โควตาอบรม CG ต่อปีจำกัด ทำให้ผลิตเพิ่มได้ยาก บางพื้นที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการให้ CM กระจายเคสพื้นที่ห่างไกลให้ CG เฉลี่ยกัน แต่ยังต้องมีมาตรการระยะยาว เช่น เพิ่มรอบการอบรม/ขยายโควตาจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม, ร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่ข่ายทำหลักสูตรสั้นเสริมศักยภาพ นอกจากนี้ยังพบข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ทำงานการเงินและบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น จึงมีข้อเสนอให้ เพิ่มอัตราจ้างงานธุรการ (บัญชี/สารบรรณ) ช่วยงานเอกสารของ อบต. / CM (CH#01 FO#02)

"CG ต้องการอบรมค่ะ ส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูแลอาการของเค้าต่างกัน ทีนี้ทักษะในการดูแล care giver เราก็ผ่านการอบรมมานานใช่ไหม ทักษะในการดูแลแผล หรือว่าอะไรต่างๆ เกี่ยวกับคนไข้ ก็บางอย่างมันก็ไม่ถูกต้อง มันมีช่วงนึงที่เป็นของโรงพยาบาลพื้นที่ B ที่เขาจัดอบรมฟื้นฟูของ CG แต่ก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะส่ง CG เราไปอบรมได้ทั้งหมด เพราะว่าเขาก็มีจำนวนจำกัดในการเข้ารับการอบรม คือพื้นที่เขาอาจจะให้ไปแค่ 2 คน 3 คนอะไรอย่างงี้นะคือพี่ก็อยากได้ CG เพิ่ม มันขาดแคลน คือหมู่บ้านพี่ไม่มี CG เลย ถ้าทีนี้ถ้าฝั่งนี้เขาจะข้ามไปฝั่งโน้น ก็คือในการเดินทางมันลำบาก" CH#01

"...คือเราก็พยายามเพิ่ม (Care giver) อยู่ ตอนนี้ก็เฉลี่ยประมาณหมู่ละ 2 คน อย่างพื้นที่พี่เนี่ย อีกคนนึงก็จะดูแล 11 คน จะมีติดเตียงซัก 2 คน อย่างเงี้ยค่ะ แต่มัน (ภาระงาน) ค่อนข้างหนัก เราก็จะพยายามเพิ่มหมู่ละ 2 แต่ว่ามันยังไม่ได้ หนึ่งด้วยด้วยหนึ่งหลักสูตร (หลักสูตรอบรมโดยกระทรวงสาธารณสุข) มันยังไม่เปิด แล้วก็ปีที่แล้วก็จะมี CUP สนับสนุนให้อบรมเงี้ยค่ะ เนื่องจากมันต้องมีงบประมาณเนาะ แต่ของเราไม่ได้ตั้งไว้สำหรับ CG อบรม บางทีก็ไม่พอนอกจากว่าทาง CUP ช่วยอบรมให้ค่ะ ถ้าถามว่าตอน ตอนนี้ของพื้นที่ B น่ะคือลาออกคนนึง แต่ก่อนเขามี 9 คนก็ลาออกก็เหลือ 8 ค่ะ" FO#02

4. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พ.ศ. 2568

จากการสัมภาษณ์ผู้กำหนดนโยบายจาก สปสช. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 19 ปี ได้ให้ข้อมูลล่าสุดว่า ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมระบบการดูแลระยะยาว (Long-

Term Care: LTC) ประมาณ 7,422 แห่ง (จากทั้งหมดกว่า 7,759 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 95.66 ที่อยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ) [1] จากสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มมีระบบ LTC อย่างเป็นรูปธรรม (พ.ศ. 2559-2561) ผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองว่า ปัญหาเรื่องของการรักษาคุณภาพบริการ และ ปัญหาเรื่องการคงอยู่ของ CG ในระบบ นั้นเป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นคุณภาพบริการในรูปผลลัพธ์การดำเนินงาน (Quality of care) นั้นยังขึ้นอยู่กับบริบทความพร้อมซึ่งอาจมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ (Geographical variation) อีกทั้งจากสมดุลของทรัพยากรมนุษย์ที่มีการลดลงของ CG จากระบบ LTC เปรียบเทียบกับขีดความสามารถในการผลิต CG นั้นจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สอดคล้องกับข้อค้นพบใน*ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่พบจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*

ปัญหาที่เกิดขึ้นนำไปสู่การประกาศนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พ.ศ. 2568 [2] มีเจตนารมณ์หลักเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน CG รายใหม่ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในลักษณะจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อมาหนุนเสริมการปฏิบัติงานของ CG ที่มีอยู่เดิมที่มักเป็นอสม. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับค่าป่วยการอยู่แล้ว ในกลุ่มผู้ที่เป็นทั้งอสม. หรือเจ้าหน้าที่ อปท. จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม สปสช. มีความตั้งใจว่าจะของบประมาณจากสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นค่าตอบแทน CG ภายใต้กองทุน LTC อย่างชัดเจนในปีงบประมาณ 2570 เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน และ CG ในระบบทุกคนได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ จะมีการกำกับติดตามผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายอย่างต่อเนื่องสำหรับการประเมินความพร้อมของระบบบริการและกองทุนสุขภาพ พร้อมทั้ง สปสช. จะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน CG ในระยะยาว

“ข้อ ๕ การจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามข้อ ๔ ให้นำหลักเกณฑ์การจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำหนดกิจการที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มาบังคับใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับประกาศนี้” [2]

“ข้อ ๗ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่มีสิทธิรับค่าจ้างตามประกาศนี้จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการเป็นการประจำ” [2]

ความยืดหยุ่นของนโยบายนี้คือการมอบอำนาจให้แก่ อปท. ในการสรรหาผู้ที่มีความประสงค์ในการเข้ามาเป็น CG รายใหม่ และระบุเรื่องสมรรถนะไว้อย่างกว้างว่าผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มี

ภาวะพึ่งพิง หรือ หลักสูตรอื่นที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 ชั่วโมง ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นสามารถจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการได้เองตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยต้องทำเรื่องขอใช้หลักสูตรการอบรมไปยังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข [3] อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้เป็นนโยบายใหม่ที่เพิ่งมีการประกาศใช้ จึงยังไม่พบปัญหา อุปสรรคของนโยบายที่ชัดเจน ในการสัมภาษณ์กลุ่ม CG ที่เป็นอสม. ได้ความกังวลถึงความเป็นไปได้เชิงนโยบายว่า นโยบายนี้จะมาช่วยแก้ไขปัญหาค่าตอบแทนของ CG ได้จริงหรือไม่ ซึ่งมองว่า สปสช. ควรมีการประชาสัมพันธ์นโยบายต่อกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงนโยบายนี้ไม่มีผลครอบคลุมต่อการจ่ายค่าตอบแทน CG ในเขตกรุงเทพมหานคร สปสช. กับสภากรุงเทพมหานคร จึงควรปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหาภาวะพึ่งพิงของกรุงเทพมหานครต่อไป

สำหรับข้อเสนอแนะเชิงวิจัย (Gap of research) ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลได้มีความคิดเห็นว่า ควรมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้แหล่งงบประมาณอื่นนอกเหนือจากการบริหารจัดการเงินภาษีประชาชน เพื่อนำมาสนับสนุนระบบ LTC และ ควรมีการศึกษาทบทวนเรื่องต้นทุนต่อหน่วยบริการ (LTC unit costing) ว่าควรกำหนดเพิ่มจาก 10,442 บาท/คน/ปี เป็นในอัตราเท่าใด เพื่อเป็นข้อมูลที่ผู้กำหนดนโยบายสามารถนำมาใช้วางแผนไม่ให้เกิดผลกระทบงบประมาณที่มากเกินไป เท่าทันต่อความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ และบริบทการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบยิ่งยวด ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนของกองทุนสุขภาพภาครัฐในอนาคต

สรุปผลช่องว่างของการให้บริการ IMC และ LTC

- **<u>IMC ในมิติด้านประชากร</u>**

  • ประกาศฯ IMC ยังไม่ครอบคลุมโรคหรือภาวะสุขภาพอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับ IMC เช่นกัน เช่น Cardiovascular disease, COPD เป็นต้น

  • ระยะเวลาการฟื้นฟู 6 เดือน อาจไม่เหมาะสมในผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น การบาดเจ็บทางสมอง เสนอให้ขยายในบางกลุ่มให้ครอบคลุมถึง 1 ปี

  • สิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ ยังไม่ให้สิทธิประโยชน์ของการให้ IMC ในชุมชน

  • ขาดระบบบูรณาการการทำงานระหว่างแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักโภชนาการ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ IMC โดยเฉพาะในชุมชน

- **<u>IMC ในมิติด้านบริการ</u>**

  • ระบบการส่งต่อและการบันทึกข้อมูลยังไม่มีมาตรฐานและรูปแบบที่สอดคล้องกันทั่วประเทศ จึงส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดเพื่อการดูแลรายบุคคลหรือการวางแผนเชิงระบบได้

  • IMC ยังอยู่ในช่วงนำร่องในบางพื้นที่ ยังไม่มีการขยายอย่างเป็นระบบ และยังไม่มีระบบติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนในระดับพื้นที่ เช่น รพช.บางแห่งยังไม่มีแนวทางในการบริหารจัดการเตียง IMC (IMC ward) และการรับผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลศูนย์

  • ขาดเกณฑ์ชัดเจนในการจำแนกบริการ ยังไม่มีแนวทางชัดเจนว่า ผู้ป่วยแบบใดควรได้รับฟื้นฟูแบบใด (ใน รพ., นอก รพ., หรือเยี่ยมบ้าน)

- **<u>IMC ในมิติด้านงบประมาณ</u>**

  • ขาดการสนับสนุนงบประมาณ Intermediate Care แบบผู้ป่วยใน ไม่มีการเบิกจ่ายกรณี IPD-IMC ทั้งที่นโยบายแนะนำให้มี IMC bed/ward

  • ส่วนการจ่าย OPD- IMC มีอัตราที่ไม่ครอบคลุมในกรณีที่ยังต้องการการฟื้นฟูต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือนสปสช. ควรพิจารณาการจ่ายแบบ episode-based payment โดยเฉพาะในกรณีของ IMC เช่น การมี DRG ของ IMC แยกออกจาก DRG สำหรับการรักษาแบบ acuteสปสช. อาจพิจารณาการจ่ายแบบ bundled payment ในกรณีที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่องที่ รพช./สถานพยาบาลอื่นๆ

- **<u>LTC ในมิติด้านประชากร</u>**

  • เกณฑ์การเข้าถึงบริการ LTC จำกัดเพียงบางกลุ่ม เน้นคะแนน ADL ซึ่งไม่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย ทำให้ในหลายพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการอย่างเหมาะสม จึงเกิดช่องว่างระหว่างนโยบายกับความต้องการประชาชน (ทำให้ผู้ที่มีความพิการหรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ เข้าไม่ถึงบริการ)

  • ครอบครัว/ญาติที่ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ได้รับสิทธิ์โดยตรงในการเบิกของใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์

• การถูกจำกัดด้วยกรอบอัตรากำลังคน จากข้อกำหนดการตั้ง “ศูนย์ดูแลระยะยาว” ทำให้ไม่สามารถจ้างงานสหสาขาวิชาชีพได้

- **<u>LTC ในมิติด้านบริการ</u>**

  • แม้จะมีงบกองทุน LTC สนับสนุน แต่ อปท. ยังขาดศักยภาพในการให้บริการโดยตรง

  • ยังไม่มีระบบสนับสนุนที่ยั่งยืนสำหรับผู้ดูแล (caregiver) และข้อมูลจากโรงพยาบาล หน่วยบริการ และ อปท. ยังไม่เชื่อมโยงกัน

  • มาตรฐานการเยี่ยมบ้านไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและศักยภาพของบุคลากรในแต่ละพื้นที่ ทำให้คุณภาพบริการต่างกัน

- **<u>LTC ในมิติด้านงบประมาณ</u>**

  • พื้นที่หลายแห่ง โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากเห็นว่านโยบายไม่ชัดเจน ไม่แน่ใจในกฎระเบียบ รวมถึงข้อจำกัดจำนวนและภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน

  • ควรมีนโยบายที่ระบุถึงแนวทางการบริหารงบประมาณผ่านการคำนวนค่าตอบแทนตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วย

  • พื้นที่หลายแห่ง โดยเฉพาะส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังเข้าใจว่าสิทธิของผู้ที่ได้รับบริการ LTC คือเฉพาะผู้ป่วยในสิทธิ UCS เท่านั้น

  • อัตราค่าตอบแทนของนักอาสาบริบาล (CC) และผู้ดูแล (CG) มีความแตกต่างกันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และเกิดการเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่

  • การขาดแคลนงบประมาณและการจัดสรรที่ไม่ครอบคลุม

  - งบประมาณที่จัดสรรให้ CG และ CC ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อัตราค่าตอบแทน ไม่สะท้อนความเป็นจริง/ต้นทุนการดำเนินงานจริง ต้องพึ่งพา out-of-pocket payments เช่น ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวในการดูแลผู้ป่วย และ CG หลายรายไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการ เนื่องจากตัวแทน อปท. หลายแห่ง ไม่สามารถจัดบริการ LTC ได้

  - งบประมาณสำหรับจัดซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปน้อยเกินไป (งบ 6,000 บาททำให้มีเพียงพอใช้แค่ 1 เดือน ทั้งที่ในความเป็นจริงผู้ป่วยต้องใช้ไปตลอดปี)

  - นโยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจฯ ด้วยอัตราจ้าง 5,000-6,000 บาท/เดือน อาจจะไม่สามารถจูงใจให้คนทำงานได้ และไม่แน่ใจเรื่องความยั่งยืน หรือการสร้าง career path ได้

  • บางพื้นที่ไม่สามารถหา CG มารับงานได้ หรือ CG ที่มาทำไม่มีความต่อเนื่อง เกิดปัญหา turn overate สูง เนื่องจากหน่วยงานอื่นให้ค่าจ้างมากกว่า บางส่วนเห็นว่าสัญญาจ้างแค่ 1 ปีไม่มีความยั่งยืน

  • อสม. ไม่สามารถรับเงินได้จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ทำให้ อสม. มีภาระงานเพิ่ม โดยที่ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC)

- กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาตั้งเป้าหมายการเข้าถึงการดูแลระยะกลางอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากที่สุด
- กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรมีกลไกติดตามและสนับสนุนให้เกิดการดูแลตามจำนวนครั้งที่กำหนดทั้งจากหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีระบบกระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้าระบบการดูแลระยะกลางให้เร็วที่สุด เช่น ภายใน 1 สัปดาห์หลังกลับบ้าน และศึกษาปัจจัยที่ทำให้สถานพยาบาลไม่สามารถให้การดูแลระยะกลางได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด
- สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ควรพัฒนา Thai DRG ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยใน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือความซับซ้อนสูงที่ต้องการการดูแลระยะแรกแบบผู้ป่วยใน รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อดูแลแบบผู้ป่วยในที่เหมาะสม เช่น มีการประเมิน Barthel index ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันทั้งตอนเข้าโรงพยาบาลและก่อนกลับบ้าน
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณากลไกสนับสนุนทางการเงินสำหรับสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล) ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน

การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC)

- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ควรปรับวิธีการเบิกจ่ายของการดูแลระยะยาวจากเหมาจ่ายเท่ากันทุกคนเป็นแบบจ่ายตามตามระดับความต้องการการดูแล เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้งบแบบผสม (blended financing) จาก สปสช.–อปท.–กองทุนสุขภาพตำบล–ภาคเอกชน สำหรับการดูแลระยะยาว
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) ควรพัฒนาระบบจัดซื้อรวมระดับประเทศ/ระดับเขตหรือจังหวัด เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวต้องแบกรับต้นทุนเอง
- กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันการศึกษา ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้ดูแล (Caregiver) และผู้จัดการการดูแล (Care Manager) อย่างเป็นระบบ โดยปรับโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นคงในการทำงาน โดยอาจนำมาตรการจ้างงานผู้ดูแลภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้เป็นแนวทาง และมีระบบสนับสนุนสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยในรายที่จำเป็น
- เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข และ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดการคัดกรองสิทธิรับบริการ LTC ที่ครอบคลุมทั้งสมรรถภาพร่างกาย การรับรู้ และภาวะจิตสังคม โดยการใช้ Barthel Index ร่วมกับการประเมินด้านอื่น เช่น

Frailty Index, Charlson Comorbidity Index, Comprehensive Geriatric Assessment, MOCA หรือ MMSE เพื่อให้การประเมินเป็นธรรมและตอบสนองความต้องการ

- เสนอให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของนโยบายการดูแลระยะยาวแบบสถาบันและกลไกการเงิน เพื่อลดการพึ่งพาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจากภาคเอกชน
- เสนอให้พิจารณาพัฒนาแหล่งงบประมาณสำหรับการดูแลระยะยาว โดยศึกษาการปรับใช้ระบบประกันดูแลระยะยาวแบบผสมสาธารณะ-เอกชน (mixed public-private LTC insurance) เช่น CareShield Life ในสิงคโปร์ [1, 2] เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดต้นทุนส่วนบุคคล[3] พิจารณาความเป็นไปได้ของกลไกร่วมจ่าย (cost sharing) ระหว่างผู้รับบริการกับกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ/อปท. โดยปรับอัตราตามความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้รับบริการ (mean-test approach)[4, 5] เพื่อเพิ่มทรัพยากรสำหรับบริการอื่นๆ และสนับสนุนความยั่งยืนของงบประมาณ อย่างไรก็ตามยังต้องยึดหลักการที่ต้องปกป้องกลุ่มเปราะบางไม่ให้ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

บทสรุป

จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษารูปแบบบริการและระบบการดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC) และการดูแลระยะยาว (Long-term care: LTC) ในประเทศไทย รวมทั้งรูปแบบการเงินการคลังที่ใช้ในการสนับสนุนระบบและบริการ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่เด่นชัดว่าระบบการดูแลระยะกลาง IMC มีศักยภาพในการช่วยบรรเทาภาระของระบบการดูแลระยะยาว LTC ถึงแม้ว่าในปัจจุบันระบบ IMC ยังรองรับการให้บริการเพียงแค่ 4 กลุ่มโรค ยังไม่ครอบคลุมโรคหรือภาวะสุขภาพอื่นๆ แต่แนวโน้มของจำนวนผู้ที่เข้ารับบริการในระบบก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับความต้องการบริการ LTC ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าถึงระบบ IMC ในบางโรคยังคงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การกำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูเพียง 6 เดือน ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบางกลุ่มโรค และการขาดระบบส่งต่อและฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศยังส่งผลให้ไม่สามารถแสดงภาพรวมในการดูแลเชิงระบบได้ นอกจากนั้นในด้านของทรัพยากรบุคลากรยังคงขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการบูรณาการกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพส่งผลให้ระบบการดูแลยังมีช่องว่าง และยังขาดการดูแลผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อเสนอให้ตั้งเป้าหมายการเข้าถึงการดูแลระยะกลางอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับบริการ และมีกลไกติดตามและสนับสนุนให้เกิดการดูแลตามจำนวนครั้งที่กำหนดทั้งจากหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีระบบกระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้าระบบการดูแลระยะกลางให้เร็วที่สุด นอกจากนั้นต้องมีการพัฒนา Thai DRG ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยใน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือความซับซ้อนสูง รวมทั้งการจัดทำเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อดูแลแบบผู้ป่วยในที่เหมาะสม และพิจารณากลไกสนับสนุนทางการเงินสำหรับสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล)ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน

สำหรับรูปแบบบริการและระบบการดูแลระยะยาวพบประเด็นช่องว่างในระบบและการบริการคือ การจัดสรรงบประมาณยังครอบคลุมความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไม่รอบด้าน กระบวนการคัดกรองและประเมินสิทธิเข้ารับบริการ LTC ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ การขาดการดูแลและการติดตามผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวที่จำเป็น นอกจากนี้ยังต้องมีการเสริมศักยภาพและเพิ่มความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จึงเสนอให้ปรับวิธีการเบิกจ่ายของการดูแลระยะยาวจากเหมาจ่ายเท่ากันทุกคนเป็นแบบจ่ายตามตามระดับความต้องการการดูแล พัฒนาระบบจัดซื้อรวมระดับประเทศ/ระดับเขตหรือจังหวัด เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นคงในการทำงานของผู้ดูแล (Caregiver) และผู้จัดการการดูแล (Care Manager) นอกจากนั้นควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดการคัดกรองสิทธิรับบริการ LTC ที่ครอบคลุมทั้งสมรรถภาพร่างกาย การรับรู้ และภาวะจิตสังคม พัฒนาแหล่งงบประมาณสำหรับการดูแลระยะยาว และการศึกษาความเป็นไปได้ของนโยบายการดูแลระยะยาวแบบสถาบันและกลไกการเงิน เพื่อลดการพึ่งพาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจากภาคเอกชน

เอกสารอ้างอิง

1. Singapore Statutes Online. CareShield Life and Long-Term Care Act 2019 [Internet]2020 [cited 2025 22 Sep]. Available from: https://sso.agc.gov.sg/Act/CLLTCA2019.
2. Asian Development Bank. Singapore's Long-Term Care System: Adapting to Population Aging. 2020.
3. Costa-Font J, Raut N. Long-Term Care Financing: a review. World Health Organization; 2022.
4. Tamiya N, H.Yasunaga, X.Jin, K.Uda and O.Komazawa (eds.). Outcomes of Long-term Care Insurance Services in Japan: Evidence from National Long-term Care Insurance Claim Data. ERIA Research Project Report FY2020 no.13. Jakarta: ERIA; 2019.
5. Schön P, J H. ESPN Thematic Report on Challenges in long-term care: Sweden. Brussels (Belgium): European Commission; 2018.
6. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.ศ. 2567. กรุงเทพฯ: กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ กองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ; 2567.
7. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แนวทางปฏิบัติเรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุข สำหรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง. นนทบุรี: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข; 2561.
8. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, วิชช์ เกษมทรัพย์, วิชัย เอกพลากร, บวรศม ลีระพันธ์. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2561.
9. World Health Organization. Long-term care for older people: package for universal health coverage. Geneva: World Health Organization; 2023.
10. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006;3(2):77–101.
11. World Health Organization. Framework for countries to achieve an integrated continuum of long-term care. Geneva: World Health Organization; 2021.
12. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน. คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2562.
13. กรมการแพทย์. รูปแบบการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2562.
14. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๘. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2568. p. 21–30.
15. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง พ.ศ. ๒๕๖๗. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2567.
16. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2559.

17. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2559.
18. World Health Organization. Universal health coverage (UHC) [Internet]2025 [cited 2025 21 Sep]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc).
19. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545, (2545).
20. Hfocus. สปสช. หนุนงบฯอปท.จัดหา Caregiver ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ให้สิทธิ์จ้างงานต่างตำบลได้ [Internet]2568 [cited 2025 21 Sep]. Available from: https://www.hfocus.org/content/2025/07/34650.
21. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ปี 2567. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2567.
22. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2568.
23. The Active. สปสช.ตัดงบ e-Claim ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย สะเทือนระบบ Palliative Care ชุมชน [Internet]2024 [cited 2025 22 Sep]. Available from: https://theactive.thaipbs.or.th/news/public-health-20241215-2.
24. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน. สปสช. ยืนยัน ไม่ได้ตัดงบ e-Claim ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย [Internet]2025 [cited 2025 22 Sep]. Available from: https://gcc.go.th/2025/04/21/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9A-e-claim/.
25. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์. คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง Guideline for Intermediate care สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan): ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567. [Internet]2567 [cited 2025 22 Sep]. Available from: https://www.snmri.go.th/snmri-e-library/#imc-2567/1/.
26. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2567.
27. Ministry of Health Singapore. Intermediate and Long Term Care (ILTC) Services [Internet]2025 [cited 2025 22 Sep]. Available from: https://www.moh.gov.sg/seeking-healthcare/find-a-facility-or-service/mental-health-services/intermediate-and-long-term-care-services.
28. Goto Y, Miura H. Intermediate Care for Patient-Centered Care, Shared Decision Making, and Hospital Discharge Support in a Japanese Acute Care Hospital: A Cross-Sectional Study. Hospitals. 2024;1(1):32–49.
29. Ministry of Health, Labour and Welfare. Long-term Care Insurance System: toward long-term care supported by society as a whole and a sense of security for post-retirement years. 2024.
30. NHS England. Intermediate care framework for rehabilitation, reablement and recovery following hospital discharge [Internet]2023 [cited 2025 22 Sep]. Available from:

https://www.england.nhs.uk/publication/intermediate-care-framework-for-rehabilitation-reablement-and-recovery-following-hospital-discharge/.

31. NHS England. NHS care for people with long term health needs [Internet]2022 [cited 2025 22 Sep]. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/64638419d3231e000c32da48/Framework_for_NHS_Continuing_Healthcare_Easy_Read_accessible_May2023.pdf.

32. สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กองตรวจราชการ. แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2566.

33. สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ. LONG-TERM CARE การดูแลระยะยาวเพื่อภาวะพึ่งพิงอย่างมีคุณภาพในสังคมไทย. ประเทศไทย: สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; 2563.

34. Feng Z, Zhuang X, Glinskaya E. Understanding China's Long-term Care Insurance Pilots : What is Going On? Do they Work? and Where to go Next? : Technical Note (English). Washington, D.C.: World Bank Group; 2019.

35. Du K, Liu Y, Hu Y. Evaluation of long-term care insurance pilot city policies in China: a cross-sectional study. Frontiers in Public Health. 2025;Volume 13 - 2025:1–10.

36. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Long-term Care of Older Persons in the Republic of Korea: In LONG-TERM CARE FOR OLDER PERSONS IN ASIA AND THE PACIFIC [Internet]2015 [cited 2025 22 Sep]. Available from: https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD%20Working%20Paper%20Ageing%20Long%20Term%20Care%20ROK%20v1-2.pdf.

37. Cho H. Long term care for older persons in Korea [Internet]2011 [cited 2025 22 Sep]. Available from: https://www.unescap.org/sites/default/files/Cho_Hyunse_0.pdf.

38. OECD. Long-term care and health care insurance in OECD and other countries. Paris: OECD Publishing; 2020.

39. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Long-term Care of Older Persons in Japan: In LONG-TERM CARE FOR OLDER PERSONS IN ASIA AND THE PACIFIC [Internet]2015 [cited 2025 22 Sep]. Available from: https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD%20Working%20Paper%20Ageing%20Long%20Term%20Care%20Japan%20v1-3%20FINAL.pdf.

40. Henley L, Joyce RB. New Aged Care Act Upholding the Rights of Older People with Disability 2024.

41. Department of Health and Aged Care. 2021-22 Report on the Operation of the Aged Care Act 1997. 2022.

42. Doty P, Nadash P, Racco N. Long-term care financing: lessons from France. Milbank Q. 2015;93(2):359–91.

43. Beitman A. Germany's Long-Term Care System: Lessons for U.S. States. New York: American Council on Germany; 2024.

44. Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems and Fiscal Sustainability – Country Documents 2019 Update. 2019.

45. OECD. Improving Long-Term Care in Croatia, OECD Health Policy Studies. Paris: OECD Publishing; 2023.

46. Schulz E. The Long-Term Care System in Denmark. DIW Berlin Discussion Paper No 1038. 2010.
47. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ผลการดำเนินงานการบริบาลฟื้นสมรรถภาพระยะกลาง (IMC) แบบผู้ป่วยนอก ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2568.
48. สุริยัน สกุลศิริไพบูลย์. แนวทางการดำเนินงานบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2568 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ระยอง: สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 6 ระยอง; 2568.
49. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๗. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2567.
50. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่. ประเทศไทย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 2567.
51. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีผ้าอ้อม แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นเสริมซึมซับ และผ้าอ้อมทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๖. กรุงเทพฯ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2566. p. 14–7.
52. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย. ระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาว Long Term Care. ประเทศไทย: สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย.
53. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. แนวทางการดำเนินงาน การขอรับค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567. 2567.
54. กระทรวงมหาดไทย. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ต.ค. 62-การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 2562.
55. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑. ราชกิจจานุเบกษา; 2561. p. 25–33.
56. กระทรวงมหาดไทย. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒. ราชกิจจานุเบกษา; 2562. p. 3–4.

ภาคผนวก

รายงานการประชุมอภิปรายกลุ่ม

การศึกษาความเพียงพอของงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ (สำหรับสังคมผู้สูงอายุ): การดูแลระยะกลาง (Intermediate care: IMC) และการดูแลระยะยาว (Long-term care: LTC)

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 15:00-17:30 น.

ณ ห้องประชุม Dawn 1 และ Dawn 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

รายชื่อวิทยากร

1. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์	มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
2. รศ.พญ. วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ	หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3. ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์	หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4. ผศ.นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส	ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

5. ดร.ภญ. สุธาสินี คำหลวง	มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
6. ดร.ณิชากร วรขจิต	หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เริ่มประชุม เวลา 15:00 น.

รศ.พญ. วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ และ ดร.ณิชากร วรขจิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ แนะนำโครงการวิจัย จากนั้น ผศ. นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส และ ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ กล่าวแนะนำกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม โดยที่ประชุมมีข้ออภิปรายในแต่ละห้องย่อย ดังนี้

ห้องที่ 1 เสริมสร้างระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง “Financing of care for older persons (IMC & LTC): เพียงพออย่างไร สูงวัยยั่งยืน” (Model of Care)

ตัวชี้วัดที่สำคัญต่อการติดตามระหว่างการส่งต่อผู้สูงอายุระหว่างระบบบริการ (phase of transitions)

ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ควรสะท้อนทั้งผลลัพธ์ทางสุขภาพ (health-related outcome) เช่น ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (Barthel’s index หรือ Lawton ADL score) และผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ทางด้านสุขภาพแต่สะท้อนความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคม (non-health-related) เช่น คุณภาพชีวิต (ประเมินโดยใช้เครื่องมือ EQ5D5L) และต้นทุนทางสุขภาพ (ทั้งต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ และต้นทุนทางตรงที่ไม่ใช่ทางการแพทย์) ของผู้สูงอายุ รวมถึงผลกระทบต่อผู้ดูแล

ผลลัพธ์ที่มีความสำคัญเพื่อประเมินอย่างครบวงจรตลอดระบบบริการ (Continuum of care)

ที่ประชุมเสนอเรื่องผลลัพธ์ที่มีความสำคัญเพื่อประเมินอย่างครบวงจรตลอดระบบบริการ ได้แก่

- **มุมมองผู้ป่วย:**
    - ผลลัพธ์ทางคลินิก: อัตราการกลับเข้ารักษาตัวซ้ำ (readmission) คะแนนภาวะเปราะบาง (frailty) การช่วยเหลือตัวเองที่ดีขึ้น (Functional level)
    - ผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์: ต้นทุนทางสุขภาพ (direct medical cost และ direct non-medical cost) ในมุมมองทางสังคม (societal perspective)

- ผลลัพธ์ที่น่าสนใจสำหรับการประเมินผลการดูแลระยะกลาง IMC คือ health-related life expectancy (HALE) ที่เมื่อได้รับบริการแล้วควรยืนยาวยิ่งขึ้นเทียบเคียงกับอายุคาดทั่วไป (Life expectancy; LE)

- **มุมมองต่อบุคลากรทางการแพทย์**: ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น (Better health system efficiency) และ ความยั่งยืนของระบบการเงินการคลังสุขภาพ (Financial sustainability)
- **มุมมองทางสังคม:** การวัดภาระที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้สูงอายุ (caregiver burden) หรือ การลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากความตระหนักรู้ที่ดีขึ้น (health literacy) ของกลุ่มผู้ดูแลที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต

ข้อจำกัดสำคัญที่สุดต่อการสร้างระบบไร้รอยต่อ (Seamless integrated system) และควรมีการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างไร

1.1 เชิงนโยบาย (Policy implication)

1.1.1 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพในกลุ่ม IMC (disease prioritization) ต้องตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ไม่ควรจำกัดเฉพาะ 4 เงื่อนไข แต่ควรครอบคลุมปัญหาที่ส่งผลต่อความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันที่ลดลง หรือ ก่อให้เกิดโรคร่วมหรือภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้เกิดทุพพลภาพ (disability)

1.1.2 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่อการเพิ่มข้อบ่งชี้ IMC ได้ให้มุมมองว่าการเพิ่มเงื่อนไขของชุดสิทธิประโยชน์ IMC อาจส่งผลต่อภาระการทำงานของบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น เพราะเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับบริการ อาจกระทบต่อคุณภาพการบริการโดยรวม

1.1.3 ความเหลื่อมล้ำระหว่างสิทธิ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยเฉียบพลันระยะ pre-aging ที่เกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ซึ่งมีข้อจำกัดในการรับบริการสำหรับสิทธิ refer (สิทธิประกันสังคม) เมื่อเกิด Stroke แล้วในอนาคตอาจจะมีความสามารถในการจ่ายลดลงและอาจไม่สามารถจ่ายค่าผู้ประกันตนได้ หรือกรณีความเจ็บป่วยที่เป็นภาวะเดียวกันแต่คนละสิทธิ์ก็อาจเป็นปัญหาในการดูแลต่อเนื่องได้

1.1.4 การผลักดันเชิงนโยบายควรเป็นระดับจากบนสู่ล่าง (top-down approach) เพื่อให้นโยบายด้าน IMC/LTC มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

1.2 เชิงนำนโยบายไปปฏิบัติ (Implementation implication)

1.2.1 ความแตกต่างระหว่างสิทธิสุขภาพของทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ยังมีกองทุนประกันสังคมและกองทุนกรมบัญชีกลางที่ยังไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์สำหรับ IMC

1.2.2 ความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของระบบ IMC และ LTC ในกลุ่มแพทย์เป็นหนึ่งในข้อจำกัด ที่ประชุมเสนอว่า ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระดับโรงเรียนแพทย์

เพื่อฝึกฝนพัฒนาให้แพทย์ที่จบมามีมุมมองและเห็นความสำคัญของการดูแลระยะกลางและระยะยาว

1.2.3 ความมุ่งหวังในการพัฒนาระบบการดูแลอย่างต่อเนื่อง (seamless integrated services) ยังมีช่องว่างในเชิงปฏิบัติ จึงมีข้อเสนอว่าควรพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างสถาบัน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

1.2.4 ความแตกต่างของนโยบายระดับหน่วยงาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน

1.2.5 ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพที่ยังไม่มีการเชื่อมต่อ (personal health record) ที่ยังไม่เชื่อมต่อกัน และยังไม่มีมาตรฐานของระบบส่งต่อข้อมูล IMC/LTC ระหว่างหน่วยงาน

1.2.6 ที่ประชุมเสนอว่าควรมีการสร้างความร่วมมือการดูแลกับภาคเอกชน (private sector)

1.2.7 ที่ประชุมเสนอว่าควรมีศูนย์ฟื้นฟูระดับชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การฟื้นฟูการเคลื่อนไหว (one province, one hospital) หรือด้านจิตเวช เพื่อให้สามารถมีการส่งต่อและเพิ่มการเข้าถึงบริการโดยยึดชุมชนเป็นฐาน (Area-based approach) มากขึ้น

2. การขยายข้อบ่งชี้สำหรับการให้บริการผู้ป่วยระยะเฉียบพลันผ่านระบบ IMC system

ที่ประชุมมีความเห็นสำหรับกลุ่มโรคที่ควรจัดเป็นข้อบ่งชี้สำหรับการเข้ารับบริการ IMC นั้นควรมีการเพิ่มเติมจาก 4 กลุ่มโรคที่มีอยู่เดิม โดยอาจพิจารณาจากโรค หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรค ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือ ภาวะเปราะบางในกลุ่มผู้สูงอายุ (Pre-frail and frail elderly)

2.1 กลุ่มโรคจิตเวชหรือโรคทางระบบประสาท

2.1.1 โรคสมองเสื่อม (Dementia)

2.1.2 โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease)

2.1.3 ผู้ป่วยจิตเวชหลังการดูแลระยะเฉียบพลัน

2.2 ผู้สูงอายุที่มีภาวะถดถอย (Older persons with functional limitation) หรือกลุ่มเปราะบาง (frailty) หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะ deconditioning syndrome จนพึ่งพาตนเองไม่ได้

2.3 กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบที่มีการสวนหลอดเลือดหัวใจ

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปสำคัญคือ ประเทศไทยควรมีการพัฒนาระบบบริการของ IMC ให้มีความพร้อมก่อนที่จะมีการปรับรูปแบบการเบิกจ่ายแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์

ห้องที่ 2 เสริมสร้างระบบการดูแลระยะกลางและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
“Financing of care for older persons (IMC & LTC): เพียงพออย่างไร สูงวัยยั่งยืน รูปแบบการเบิกจ่ายที่เหมาะสม (Payment strategies)

1. การจ่ายแบบ bundled payments ที่ครอบคลุมทั้งเส้นทางบริการจาก acute care สู่ IMC และ LTC system

1.1 กลุ่มผู้เห็นด้วยกับการปรับจากรูปแบบการจ่ายปัจจุบัน เป็นรูปแบบการจ่ายแบบ Bundled payment ตลอดกระบวนการ

ผู้ที่เห็นด้วยได้ให้เหตุผลว่าการจ่ายแบบ Bundled payment มีข้อดีคือสามารถกระตุ้นให้เกิดการให้บริการตลอดกระบวนการตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Acute care จากความเจ็บป่วยเฉียบพลัน ส่งต่อไปยังระบบ IMC และเข้าสู่ระบบ LTC สำหรับผู้ที่เข้าสู่ภาวะพึ่งพิงตามลำดับ ป้องกันการเข้าสู่ภาวะระยะท้ายชีวิต (End-of-life period) ที่รุนแรงจากการดูแลที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทางสุขภาพโดยรวมสูงกว่าการไม่เข้าระบบการดูแลอย่างเป็นทางการการ

สำหรับการปรับรูปแบบการจ่ายจากเดิมที่เป็นการจ่ายลักษณะเหมาจ่ายรายหัวสำหรับผู้เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอก และ รูปแบบการจ่ายแบบ Disease-related group (DRG) สำหรับผู้เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยใน ซึ่งควรใช้วิธีการจัดแบ่งผู้เข้ารับบริการตามระดับภาวะเปราะบางว่าอยู่ในกลุ่มใด และมีเป้าหมายสูงสุด (Maximum benefits) ของการฟื้นฟูผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มที่ระดับใด รวมถึงการคำนวณอัตราจ่ายควรคำนวนในลักษณะเป็นช่วง (Flexible rate)แทนการคำนวณแบบอัตราคงที่ (Fixed rate) และ ควรพิจารณาระดับความพร้อมของสถานพยาบาลเป็นองค์ประกอบร่วมด้วย (เช่น โรงพยาบาลใดที่มีระบบ IMC และ LTC ครบ ควรได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าโรงพยาบาลที่มีบริการไม่ครบทั้งระบบ) เพื่อปรับอัตราจ่ายให้แตกต่างกันตามผลลัพธ์บริการ

1.2 กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับการปรับจากรูปแบบการจ่ายปัจจุบัน เป็นรูปแบบการจ่ายแบบ Bundled payment ตลอดกระบวนการ

กลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วย เสนอว่าควรมีการจ่ายแบบ bundled payment เฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งก่อน เช่น จ่ายเฉพาะช่วงที่มีการให้บริการแบบ acute care จนถึง IMC หรือ จากระบบ IMC ถึง LTC ก่อน เพราะอาจมีกรณีที่สถานพยาบาลเบิกงบประมาณเกินจริงโดยไม่ได้ให้การบริการอย่างมีคุณภาพ การแก้ไขปัญหาควรมีการติดตามผลลัพธ์ของการให้บริการของ Acute care และ IMC ได้ชัดเจนกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน LTC

ทั้งกลุ่มผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยได้อภิปรายถึงข้อควรระวังสำหรับผู้กำหนดนโยบายว่า การดูแลแบบ Acute care เป็นการดูแลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ควรมีการใช้รูปแบบการจ่ายรูปแบบใหม่ที่ประเมินจากผลลัพธ์ (Value-based payment) นอกเหนือจากการใช้วิธีคำนวณตาม DRG อีกทั้งความแตกต่างของระบบส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลผู้เป็นเจ้าภาพของแต่ละระดับ (เช่น ผู้ป่วยอาจเข้าสู่ระบบ Acute care ผ่านโรงพยาบาลอำเภอ แต่เมื่อส่งต่อกลับไปยัง ระบบ IMC ของโรงพยาบาลระดับจังหวัด และ ระบบ LTC ของชุมชน) อาจมีคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันนำไปสู่ข้อจำกัดทางการตรวจสอบ สามารถสรุปความเห็นได้ว่าควรมีการแก้ไขปัญหาการดูแลแบบแยกส่วน (Fragmented care) บางหน่วยบริการ LTC ปัจจุบันยังไม่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ร่วมกับการแก้ไขปัญหาทางการเงินการคลัง โดยที่ประชุมเสนอให้มีการถอดบทเรียนจากโครงการที่มีการดำเนินการแล้ว ว่ามีกลยุทธ์อย่างไร เช่น โครงการ Stroke fast track ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวทางออกแบบนโยบายควรเป็นในลักษณะที่มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพบริการอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ (Third-party evaluation) ผู้ประเมินผลลัพธ์ภายในควรมีทักษะความรู้ ประสบการณ์ที่เพียงพอ (ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากราชวิทยาลัย ร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) ควรมีผู้ประเมินภายนอกตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน เงื่อนไขการเบิกจ่ายที่ชัดเจน มีการกำหนดเพดานอัตราจ่ายที่สมเหตุสมผล รวมถึงผู้กำหนดนโยบายต้องมีการประมานการณ์ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการปรับรูปแบบการจ่ายจากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบใหม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อม (เช่น ระยะเวลา 2 ปี) เพื่อให้กิจกรรมทั้งกระบวนการมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นไปได้สำหรับการขยายระดับไปสู่ระดับชาติ ป้องกันความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายโดยไม่ได้ให้บริการจากสถานพยาบาลบางแห่ง

2 การกระจายค่าใช้จ่ายทางสุขภาพผ่านกระบวนการแบ่งปันค่าใช้จ่ายระหว่างผู้รับบริการและสถานพยาบาล (Cost sharing)

ที่ประชุมได้ให้ข้อมูลว่า สำหรับระบบ LTC ปัจจุบันได้มี Cost sharing ในระดับกองทุนส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจึงอาจยังไม่นำมาพิจารณา แต่อาจมีการร่วมจ่ายกับบริษัทประกันเอกชน (Private insurance) ที่มีการคำนวณเบี้ยประกันในอัตราพิเศษ (Premium)

3 ความยั่งยืนของระบบการเงินการคลัง

ที่ประชุมทั้ง 2 กลุ่ม ได้เสนอว่าควรมีการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพิ่มเติมที่เป็นช่องทางรวบรวมแหล่งที่มาของงบประมาณส่วนเพิ่มนอกเหนือจากกองทุนสุขภาพที่มีปัจจุบัน เช่น งบประมาณที่ได้จากระบบภาษีสรรพสามิตร (ภาษีบุหรี่ ภาษีสุรา) ซึ่งจัดสรรโดยรัฐบาล หรือเป็นการใช้งบประมาณร่วมกับกระทรวงต่างๆที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้ามาสมทบ รวมถึงอาจมีการจัดตั้งระบบประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Insurance) รวบรวมภาษีสุขภาพ (Health tax) หรือเงินออมสุขภาพในอัตราที่เหมาะสม จากประชาชนในวัยทำงานที่กำลังจะเข้าสู่วัยชรา คล้ายกับในหลายประเทศที่มีระบบประกันสุขภาพ (LTC Insurance) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ เมื่อประชาชนเข้าสู่วัยชราจะได้รับเงินทดแทนตามระดับภาวะพึ่งพิง

ข้อสรุปจากการจัดอภิปรายกลุ่ม

1. การปรับรูปแบบการจ่าย (Payment reform)

1. ภาครัฐควรเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร โครงสร้างระบบ และกลไกการคลังสุขภาพ เพื่อรองรับการปรับรูปแบบการจ่ายให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากสังคมสูงวัย โดยควรดำเนินการภายใต้กรอบระยะที่ให้สถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อม
2. การกระจายภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ (Cost sharing) ควรออกแบบให้มีความเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงและภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ โดยอาจเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
3. การพัฒนาระบบการจ่ายแบบไร้รอยต่อ (Seamless system) โดยใช้รูปแบบ **Bundled payment** ครอบคลุมช่วงการดูแลตั้งแต่ Acute care สู่ IMC และ ช่วงการดูแล IMC เข้าสู่ LTC ทั้งในระดับ

สถานพยาบาล (Institution-based) และระดับชุมชน (Community-based care) เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลระหว่างระดับสถานพยาบาล (Integrated Data system) และมาตรฐานการส่งต่อ (Quality indicators)

4. ความยั่งยืนทางการเงินควรได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนใหม่ เช่น ภาษีสรรพสามิต (ภาษียาสูบ สุรา) หรือ งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และภาคสังคม
5. ควรมีการปรับกลไกการใช้งบประมาณของกองทุนสุขภาพระดับจังหวัดและนโยบายการคลังระดับท้องถิ่นให้สามารถรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และขยายขอบเขตการใช้เงินให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบริการตลอดเส้นทางการดูแล
6. การพึ่งพาการซื้อประกันส่วนบุคคลหรือภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ยั่งยืนในระยะยาว จึงควรใช้เป็นกลไกเสริมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ และ การจัดเก็บเงินออมสุขภาพหรือภาษีสุขภาพ (Health tax) จากประชาชนวัยทำงาน เพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพในอนาคต อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

2. การปรับรูปแบบบริการ (Model of care)

1. ระบบการดูแลผู้สูงอายุควรมุ่งเน้นการวัดผลลัพธ์อย่างรอบด้านตลอดช่วงการส่งต่อ (Phase of transitions) ครอบคลุมทั้งผลลัพธ์ทางสุขภาพ และ ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ด้านสุขภาพ เช่นผลลัพธ์ทางสังคม
2. ปัจจุบันระบบบริการยังเผชิญปัญหาการดูแลแบบแยกส่วน (Fragmented care) จึงจำเป็นต้องมีการปรับนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากร ผ่านการปลูกฝังแนวคิด IMC และ LTC เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuum of care)
3. ระบบ IMC ควรขยายความครอบคลุมไปยังทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิประโยชน์และเพิ่มความต่อเนื่องของการดูแลผู้สูงอายุ
4. การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญ โดยควรเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ IMC และ LTC รวมถึงพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสุขภาพระดับบุคคล (personal health record) และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
5. การขยายข้อบ่งชี้สำหรับการให้บริการ IMC ควรพิจารณาจากภาวะที่ส่งผลต่อความสามารถในการดำรงชีวิตและภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุ ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มโรคเดิม โดยอาจรวมถึง กลุ่มโรคสมองและจิตเวช กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มภาวะเปราะบาง

ข้อค้นพบจากการจัดอภิปรายกลุ่ม

ประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับ การพัฒนาระบบบริการ IMC และ LTC ให้มีความพร้อมต่อการขยายความเป็นไปได้ของคุณภาพบริการในระดับประเทศและมุ่งเน้นการสร้างระบบเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับรูปแบบการจ่ายเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Value-based payment) แทนรูปแบบการจ่ายปัจจุบัน โดยการขับเคลื่อนเชิงนโยบายควรเป็นแบบบนสู่ล่าง (Top-down) ควบคู่กับการจัดตั้งกองทุนสุขภาพพิเศษหรือระบบประกันการดูแลระยะกลาง/ระยะยาว พัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติของสถานพยาบาล การสร้างมาตรฐานคุณภาพโดยองค์กรผู้รับผิดชอบ และระบบติดตามประเมินผลที่โปร่งใส เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างยั่งยืน เท่าเทียม และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยยิ่งยวด

ในท้ายที่สุด รศ.พญ. วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ และ ผศ. นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

จบการประชุม เวลา 17:30 น.

ศักดิโชติ เพชรสม

ร่างรายงานการประชุม

ณิชากร วรขจิต

หฤษฎ์ ปัณณะรัส

ตรวจทาน